HÔPITAUX Paris

Saint Joseph Marie Lannelongue

LIVRET D'ACCUEIL

TOME 8

LES PROCEDURES ET PROTOCOLES DU SERVICE ET DE L'INSTITUTION

SERVICE DES URGENCES

SOMMAIRE

1. Du service ..... - 5 -

Traçabilité et vérification quotidienne des zones ..... - 5 -

Gestion des effets personnels des patients 6

Procédure des effets personnels des patients 13

Procedure de restitution des effets personnels des patients 15

Procedure en cas de sortie a l'insu du service 17

Procedure en cas de fugue 18

Procedure en cas de décès 19

Procédure de prévention des chutes 24

Procedure en cas de chute d'un patient 29

Chartes des accompagnants et badges 31

Procedure de tranfusion sanguine et traçabilite 32

Feuille de surveillance transfusionnelle 36

Feuillet d'information sur la transfusion 38

Effets indésirables receveur trasfusion sanguine 42

Procédure d'Identito-vigilance (bracelet d'identification) 43

Alarme Agression 45

Alarme ACR 45

Procédure matériel defectieux 45

Procédure de prise en charge d'un mineur aux urgences 46

Protocole de mise en place de contention 48

Procédure de prise en charge d'un patient SDF 50

Conduite à tenir en cas d'AES 52

Prescription de traitement de substitution nicotinique (TSN) par les IDE 53

Indication à LA réalisation d'un ECBU aux urgences 57

2. Laboratoire ..... - 58 -

Procédure etiquettage des sachets de laboratoire ..... - 58 -

Procedure envoie de gaz du sang ..... - 58 -

Procédure groupe sanguin ..... - 59 -

Procedure alerte thrombolyse ..... - 59 -

Procedure d'acheminement des prelevements d'une ponction lombaire ..... - 60 -

3. Pharmacie ..... - 61 -

Vérification des stupefiants ..... - 61 -

Traçabilité d'administration des stupéfiants ..... - 65 -

Protocole titration de morphine ..... - 68 -

Protocole d'utilisation de la Naloxone pour antagonisation des opioïdes en cas de surdosage....- 70 -

contrôle et entretien es réfrigérateurs pharmaceutiques ..... - 71 -

Conduite à tenir en cas de d'alarme et/ou de température <+2°C ou >+8°C. ..... - 73 -

Procédure des traçabilités spécifiques ..... - 75 -

Octaplex ..... - 75 -

Actilyse ..... - 77 -

Vaccin antitétanique ..... - 79 -

4. Hygiène ..... - 80 -

information dans le dossier patient ..... - 80 -

Prescription de précautions complementaires et/ou d'un dépistage ..... - 84 -

Les précautions standard ..... - 85 -

Les fiches des précautions complementaires ..... - 88 -

Précautions complémentaires contact - BMR, diarrhées infectieuses. ..... - 89 -

Précautions complémentaires contact renforcées - BHRe : ..... - 90 -

Précautions complémentaires contact renforcées – Clostridium difficile ..... - 91 -

Précautions complémentaires contact renforcées – Ectoparasites, Gâle ..... - 93 -

Précautions complémentaires gouttelettes – COVID, VRS, Grippe ..... - 95 -

Précautions complémentaires air – Tuberculose, Varicelle, Rougeole. ..... - 97 -

Précautions complémentaires contact renforcées – Candida Auris ..... - 98 -

Isolement protecteur ..... - 99 -

Conduite a tenir en cas de gâle ..... - 101 -

Prise en charge d'un patient suspect ou atteint d'infection due au monkeypox virus..... - 103 -

Prise en charge d'un patient suspect d'infection due au CORONAROVIRUS du Moyen Orient (Mers-CoV) ..... - 111 -

Prise en charge d'un patient suspect ou atteint de rougeole ..... - 115 -

Prise en charge d'un patient suspect ou atteint du COVID ..... - 119 -

Patient suspect ou atteint du covid aux urgences ..... - 124 -

5. Zone 1 ..... - 125 -

Prise en charge d'un AES ..... - 125 -

Mise en place d'attelle ou de syndactylie ..... - 127 -

6. Zone 2 ..... - 128 -

Cycles de troponine et ECG ..... - 128 -

Protocole de pose de sonde nasogastrique (SNG) ..... - 129 -

Protocole de pose de sonde urinaire chez l'homme ..... - 131 -

Protocole de pose de sonde urinaire chez la femme ..... - 135 -

Procedure de prise en charge d'une rau en cas de rad ..... - 138 -

Feuille de transmissions zone 2 ..... - 140 -

7. IOA ..... - 141 -

Procedure de certificat de NON-ADMISSION (CNA) et réquisition ..... - 141 -

Procédure d'utilisation des packs réfrigérants ..... - 143 -

Schéma de prise en charge de la douleur ..... - 145 -

Agressions sexuelles ..... - 146 -

Prise en charge de femme victime de violences conjugales ..... - 148 -

Délivrance d'antalgique par l'IOA ..... - 150 -

Conduite a tenir en cas de consultation et/ou hospitalisation d'un detenu (A METTRE) . - 152 -

Patient porteur d'arme ou de drogue ..... - 153 -

Protocole de coopération professionnelle : Prescription de radiologie ..... - 155 -

Protocole de cooperation professionnelle : Intocication au monoxyde de carbone (CO) ... - 157 -

Protocole de coopération professionnelle : Rétention aigue d'urine ..... - 158 -

Protocole de coopération professionnelle : Prise en charge des plaies ..... - 160 -

Protocole de prise en charge d'une alerte thrombolyse ..... - 161 -

Protocole de réalisation d'un electrocardiogramme à l'IAO ..... - 162 -

1. DU SERVICE

TRAÇABILITE ET VERIFICATION QUOTIDIENNE DES ZONES

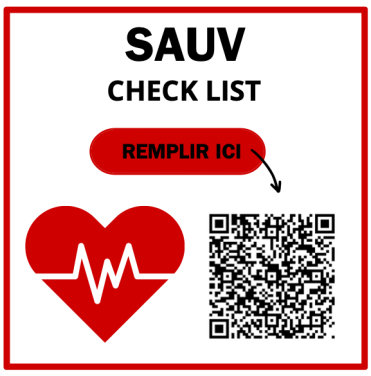
A votre prise de poste, vous devez effectuer la vérification de votre zone. Pour se faire, plusieurs possibilités :

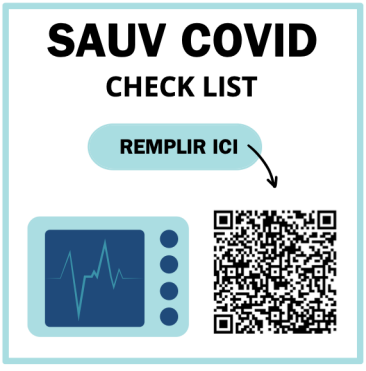
1) Vous flashez le QR Code présent dans le poste de soins et/ou box
2) Vous ouvrez le dossier ... sur le bureau d'un des ordinateurs et vous cliquez sur la vérification concernée.

Un questionnaire Google Form s'affiche, vous n'avez plus qu'à remplir ou cocher.

Un jeu d'enfant 😉

Les QR Code :





GESTION DES EFFETS PERSONNELS DES PATIENTS

1. Accueil administratif du patient

L'agent administratif s'engage à remettre **immédiatement** au patient les documents prouvant son identité (pièce d'identité) et ses droits d'ouverture (carte vitale) à la suite de leur vérification, **exception faite pour le patient qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, ou devant recevoir des soins urgents, pour lequel l'agent administratif dépose alors les documents administratifs dans le classeur situé sur le bureau de la borne d'accueil des urgences (trieur).**

L'agent administratif (jour et nuit) doit **obligatoirement** tracer l'accueil administratif pour chaque séjour du patient dans DxCare – (type de pièces d'identité présentées, remises à qui, lieu de consignation). L'agent administratif doit vérifier les documents présents dans le classeur à chaque sortie de patient.

Aucun document administratif original ne doit rester présent dans un dossier médical.

2. Prise en charge par l'Infirmier d'Orientation et d'Accueil (IOA)

A. Patients orientés sans troubles cognitifs

L'IOA rassemble les effets personnels du patient (objets de valeur compris) dans un sac nominatif avec une étiquette du patient.

Si présence d'objets type cannes, fauteuils roulants, béquilles, téléalarmes… l'IOA identifie ces objets avec une étiquette du patient.

Le sac est laissé au patient sur ou sous le brancard et est sous la responsabilité du patient.

Il faut bien communiquer l'information au patient et lui rappeler qu'à partir de ce moment **il est totalement responsable de ses effets personnels.**

B. Patients n'ayant pas toutes ses facultés cognitives

Tout patient présentant une altération de ses facultés cognitives, hors d'état d'exprimer sa volonté ou devant recevoir des soins urgents (article L1113-3) **doit obligatoirement bénéficier d'un inventaire détaillé et d'un dépôt au coffre de ses biens de valeurs.**

Il s'agit de patients suivants :

➔ Ayant des troubles de la conscience.

- Ayant des troubles cognitifs.
- Nécessitant une prise en charge en réanimation.
- Nécessitant une contention physique.
- Sous protection juridique (tutelle).

C. Cas particuliers

Il s'agit des patients suivants :

- Patients nécessitant une prise en charge urgente au bloc opératoire.
- Les mineurs sans accompagnants.

Dès lors que l'inventaire est obligatoire, l'IOA déshabille le patient et rassemble ses effets personnels (objets de valeur compris) dans un **sac nominatif avec une étiquette patient.** Le sac est déposé dans le poste de soins dans un endroit dédié.

Aucun inventaire ne doit être réalisé à l'IOA.

Les AS en zone de soins doivent être informées de la présence de ce sac dans le poste de soins par l'IDE et/ou AS ayant réalisé l'IOA.

3. Prise en charge par l'Aide-Soignant (AS).

L'inventaire des effets personnels et des biens de valeur est **réalisé par un aide-soignant en binôme avec un autre soignant (IDE ou AS)** selon la procédure institutionnelle *« Dépôt de biens et de valeurs des patients hospitalisés »*.

Pour les objets de valeurs :

- Remplir la fiche de dépôt qui se trouve dans le dossier DxCare du patient. Attention aux objets que vous mettez dans le coffre. (Trouver une formulation car parfois dans le coffre on retrouve tout et n'importe quoi.)
- La liste de l'inventaire doit être exhaustive et non une synthèse.
- Noter de manière lisible et en toute lettre le nom et prénom des deux professionnels, signature.
- Numériser la fiche de dépôt dans le dossier du patient par les agents d'accueil.
- Déposer les biens de valeur au coffre des urgences et tracer sur la main courante prévue à cet effet.

4. Transfert de patient ayant des troubles cognitifs ou une pathologie psychiatrique (patient contentionné) dans un autre établissement de santé

Lorsque le patient (ayant des troubles cognitifs ou une pathologie psychiatrique) doit être transféré dans un autre établissement de santé, ses objets de valeur qui ont été sécurisés dans le coffre des urgences, **ne lui sont pas restitués**.

Les objets de valeur du patient sont transférés dans le coffre central de l'hôpital par le comptable de la caisse central. Sur demande de l'encadrement ou des ide réf, ce dernier pourra procéder au transfert du coffre vers l'établissement d'accueil via coursier.

L'IDE ou l'AS en informe le patient et lui indique la démarche à suivre pour récupérer ses biens de valeur en lui remettant une fiche d'information (cf. annexe). En cas de doute sur la compréhension du process par le patient, mettre la fiche d'information dans le dossier de sortie qui sera récupéré par l'ambulancier. Une transmission écrite doit être réalisée dans le dossier de soins.

Dans un second temps, le patient devra récupérer ses objets de valeur à la caisse centrale.

En cas d'impossibilité de se déplacer, il peut mandater un tiers en établissant une procuration (sur papier libre ou selon modèle cf annexe). La personne mandatée devra se présenter à la caisse centrale avec sa pièce d'identité et la procuration signée.

5. En cas d'hospitalisation des patients orientés sans troubles cognitifs (non contentionné)

Tout patient hospitalisé (hors cas particuliers cités ci-dessus) doit bénéficier d'un inventaire à l'entrée du service d'hospitalisation y compris aux lits d'urgences.

L'inventaire est réalisé selon la procédure institutionnelle *« Dépôt de biens et de valeurs des patients hospitalisés ».*

Pour les objets de valeurs :

- Proposer au patient de sécuriser ses bien de valeur au coffre des urgences. Tracer son acceptation ou son refus dans DxCare. Pour rappel, les coffres des chambres sont sous la responsabilité des patients. De plus, un refus entraine l'annulation de la responsabilité de l'hôpital en cas de perte et/ou vol de biens de valeur. Il est alors important de bien sensibiliser le patient sur ce point.
- En cas d'acceptation, l'inventaire des biens de valeur est réalisé **en présence du patient.**
- Noter de manière lisible et en toute lettre le nom et prénom du professionnel, signature du professionnel et du patient
- Numériser la fiche de dépôt dans le dossier

➔ Déposer les biens de valeur au coffre des urgences

Lors des transferts de patients des urgences / lits d'urgence vers les services d'hospitalisation l'équipe soignante doit veiller à ce que le patient reparte bien avec ses effets personnels. Le brancardier doit veiller à ne rien laisser sous le brancard.

Lorsqu'un patient doit aller au bloc opératoire, le brancardier achemine ses effets personnels vers le service (dès connaissance de celui-ci) qui l'accueillera en post opératoire demande réalisée sur THEO par l'un des soignants. Dans le cas où les effets personnels ont été remis à l'un des proches du patient, il est impératif de le tracer en réalisant une transmission ciblée du DxCare dans le dossier du patient.

6. Suivi des effets personnels

A. Aux urgences

Tous les jours, l'aide-soignant du SAU vérifie les effets personnels déposés au vestiaire. Si vêtements non étiquetés : **prévenir le cadre ou IDE référente.**

Si vêtements étiquetés : **localiser le patient et les lui faire parvenir dans le service.**

Tous les mercredis une vérification sera faite par un binôme d'aides-soignants et infirmiers.

Si le patient n'est plus à l'hôpital, lui demander de venir chercher ses effets personnels. Il faudra alors le **tracer sur le registre et dans le dossier du patient.**

Le premier mercredi de chaque mois un binôme d'aides-soignants et d'infirmiers trient les effets consignés depuis plus de 3 mois.

Exemple : *Nous sommes le premier mercredi du mois de février. Vous allez donc vider l'étagère du mois de novembre. Il restera une étagère avec les vestiaires du mois de décembre et de janvier. Puis vous effectuez la liste des vestiaires à détruire (avant destruction des vestiaires, les soignants doivent joindre le patient ou sa personne de confiance. Un délai d'une semaine leur est alors autorisé pour venir le récupérer. Au-delà, il est détruit). Pour finir, la liste des vestiaires détruits est à remettre à un membre de l'encadrement (IDE référents et/ou cadre de santé).*

B. Aux lits d'urgences

L'aide-soignant doit être présent pour chaque sortie ou transfert des patients.

Tous les après-midis, il vérifie s'il reste des vêtements dans les chambres et dans le poste de soins. Si c'est le cas, il les fait acheminer dans le service d'hospitalisation ou contacte le patient s'il est sorti et doit le tracer dans le dossier du patient.

7. Résumé de la conduite à tenir pour restituer les objets de valeur déposés au coffre des urgences

Transfert vers un autre établissement de santé d'un patient orienté, sans troubles cognitifs et/ou non contentionné

Restitution au patient des biens de valeur sécurisés au coffre des urgences par l'équipe managériale.

Conduite à tenir :

- Restitution du dépôt devant le patient en énumérant chaque objet de valeur.
- Signature du soignant (nom et fonction) et du patient sur la fiche de dépôt (noter la date du jour).
- Mettre la fiche de dépôt signé dans le dossier du patient, ou dans la bannette

Transfert vers un autre établissement de santé d'un patient ayant des troubles cognitifs et/ou non contentionné

Pas de restitution des biens de valeur sécurisés au coffre des urgences.

Conduite à tenir :

- En informer le patient et lui remettre la fiche explicative de la procédure pour récupérer ses biens disponibles sur BlueKango
- Tracer dans le dossier du patient que l'information a bien été transmise.
- Tracer sur la main courante du coffre des urgences.

Annexe :

Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Madame, Monsieur,

Vous avez été pris en charge au sein du service des urgences de l'hôpital Paris Saint-Joseph.
Lors de votre séjour, vos biens de valeur ont été déposés dans un coffre sécurisé.
Vous n'êtes plus présent à l'hôpital Paris Saint-Joseph.

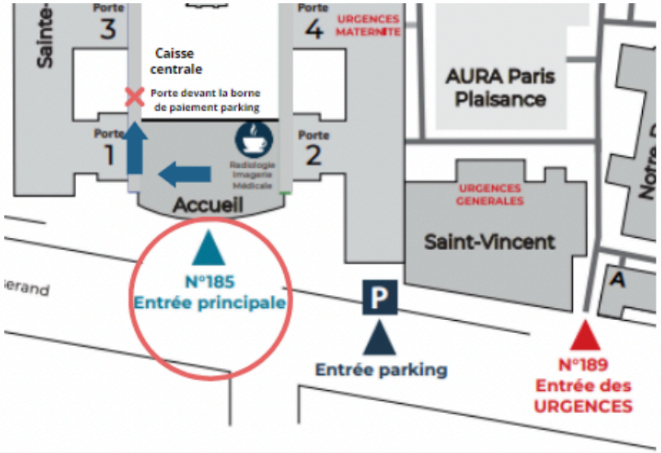
La conduite à tenir pour récupérer vos biens est la suivante :

- Du lundi au vendredi de 9h à 17h : contacter la caisse centrale de l'hôpital au 01.44.12.38.81.
- Le week-end de 9h à 17h : contacter le service des urgences au 01.44.12.34.58.

Vous devrez alors vous présenter à la caisse centrale de l'hôpital ou à l'accueil du service des urgences (voir plan ci-dessous).
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, vous pouvez donner une procuration (*cf modèle de procuration*) à un membre de votre entourage qui devra se présenter avec sa pièce d'identité officielle (carte nationale d'identité ou passeport).
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons disponibles.

Cordialement,

L'équipe du service des urgences



Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

PROCURATION pour récupérer mes biens de valeur

Je, soussigné(e) madame, monsieur (*Prénom, NOM*).....

né(e) le....., donne procuration à madame, monsieur (*Prénom, NOM*) .....
né(e) le..... pour récupérer mes biens de valeur qui ont été sécurisés lors de mon séjour dans le service des urgences du .....

Fait à .....
Le .....

Signature

PROCEDURE DES EFFETS PERSONNELS DES PATIENTS

Cette procédure vise à améliorer la qualité de prise en charge des patients en diminuant la perte et en évitant le vol de leurs effets personnels.

Nous réalisons un inventaire et un coffre systématiquement pour :

- Les patients atteint de pathologie dégénérative entraînant des troubles cognitifs (Alzheimer, parkinson, etc.).
- Les patients présentant une pathologie psychiatrique pouvant entraîner une mise en danger (IMV, risque suicidaire, risque de fugue).
- Les patients nécessitant une contention physique et chimique.

Et pour les cas particuliers suivants :

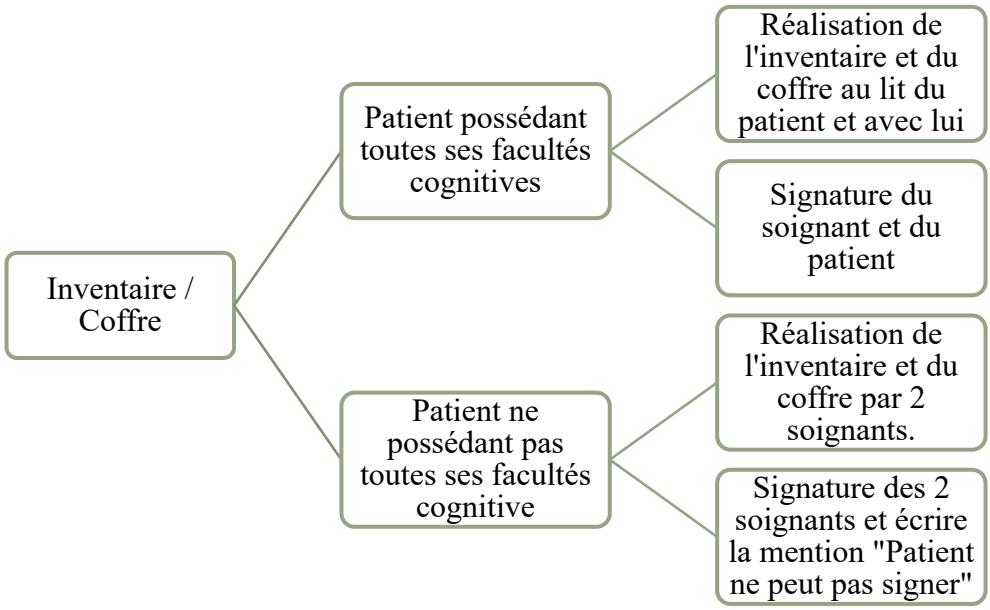
- Patient nécessitant une prise en charge en service de réanimation.
- Patient nécessitant une prise en charge au bloc opératoire.
- Patient sous protection juridique (tutelle).

Les effets personnels du patient sont réunis dans un sac nominatif (étiquettes), ainsi que si nécessaire identifier les cannes, béquilles, fauteuils roulants, lunettes de vue, déambulateurs, caddy, valise, ...

<u>Rappel :</u> Tout patient hors d'état d'exprimer sa volonté ou devant recevoir des soins urgents doit obligatoirement bénéficier d'un inventaire détaillé et d'un dépôt au coffre de ses biens de valeurs (articleL1113-3) du Code de la santé publique - Partie législative.[1]

[1] Code de la santé publique - Partie législative > Première partie : Protection générale de la santé > Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé > Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé > Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies > Articles L1113-1 à L1113-10.

Réalisation de l'inventaire :



La réalisation de l'inventaire et du coffre est à faire via le logiciel métier DxCare.

IL EST INTERDIT DE NOTER « VÊTEMENTS DE VILLE »

En effet, « vêtement de ville » ne veut rien dire, est-ce que cela signifie que le patient possède un short ou un pantalon ? Est-ce qu'il y a un manteau ? ... Il est donc impossible en cas de perte de justifier les dores du patient, si ce dernier dit qu'il est venu aux urgences avec un manteau, comment pouvons-nous savoir qu'il dit vrai ou faux avec la notion « vêtement de ville ». Par conséquent, le patient aura gain de cause et l'hôpital devra rembourser la perte.

De même, pour le coffre, vous ne pouvez noter la marque des bijoux ou le métal.

Exemple :

- Montre à fond blanc, bracelet en métal de couleur argent.
- 3 bagues couleurs dorés, 1 collier couleur argent avec un pendentif en forme de croix.

La réalisation d'un inventaire et d'un coffre est donc quelque chose à faire avec rigueur.

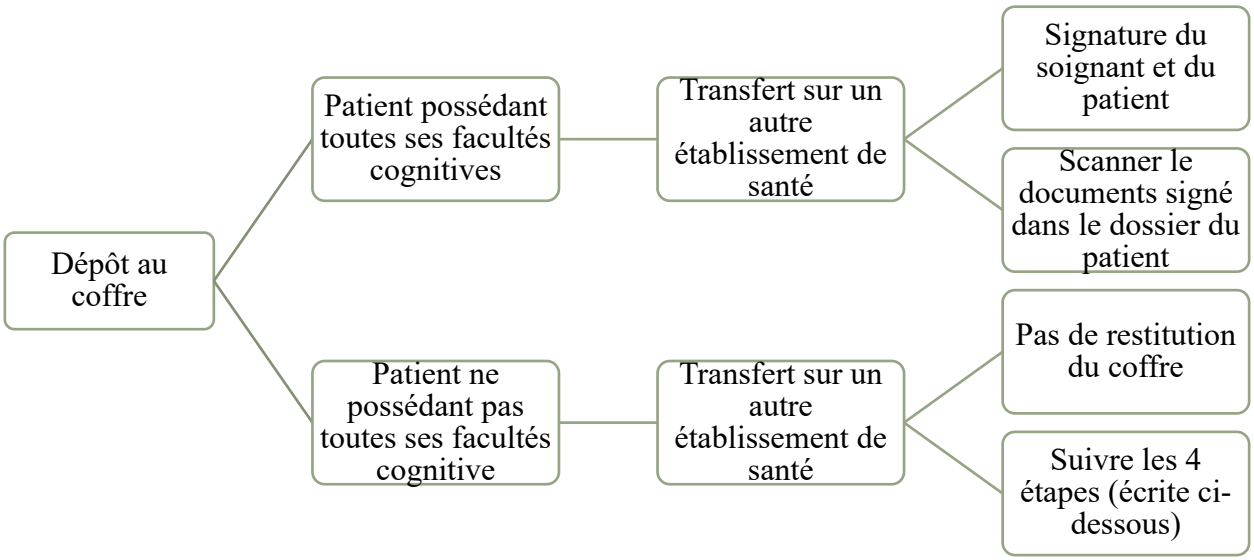
PROCEDURE DE RESTITUTION DES EFFETS PERSONNELS DES PATIENTS

Dans le cas, ou un patient est transféré dans un autre établissement de santé et que celui-ci ne possède pas toutes ses facultés cognitives, nécessitant la mise en sécurité de ses biens de valeur au coffre du service des urgences, alors ils ne sont pas restitués au patient lors de son transfert.

Les biens de valeur seront donc transféré à la caisse centrale de l'hôpital et le patient pourra venir les récupérer dans un second temps, ou il peut mandater via une procuration un membre de son entourage pour venir les récupérer à sa place (la personne mandatée devra se présenter avec sa pièce d'identité et la procuration signé).

Le patient est prévenu que ses biens de valeurs ne sont pas transférer avec lui, une transmission est mise dans le dossier et une fiche explicative est mise dans son dossier concernant la marche à suivre pour récupérer ses biens de valeurs.

Restitution des biens de valeurs :



Les 4 étapes :

1) Informer le patient si son état de santé le permet.
2) Réaliser une transmission écrite dans le dossier du patient (voir exemple).

3) Remettre la fiche explicative « Comment récupérer mes biens de valeur ? ». La mettre dans la pochette de sortie.
4) Noter sur le registre des coffres (présent dans l'accueil administratif au-dessus du coffre des urgences) la date, l'heure et le nom de l'établissement dans lequel le patient a été transféré.

Exemple de transmission :

Donnée	Action	Résultat
Patient transféré sur l'hôpital ... Patient ne possédant pas toutes ses facultés cognitives.	- Biens de valeur non restitué. - Réalisation d'une transmission. - Fiche récapitulative mise dans le dossier de sortie. - Information du transfert du patient noté sur le registre des coffres des urgences.	(Aucun résultat attendu).

PROCEDURE EN CAS DE SORTIE A L'INSU DU SERVICE

Pendant la prise en charge de votre patient, vous vous rendez compte que celui-ci n'est plus présent dans la zone de prise en charge ou sur son brancard.

1) Appeler l'agent de sûreté (DECT : 50.32).
2) Faire un tour de tout le service, vérifier les WC, les placards, les boxes, ...
3) Appeler le patient sur son numéro de téléphone (si pas de réponse, laisser un message).
4) Prévenir le médecin en charge du patient, qui décide :
    a. Que c'est une sortie à l'insu du service.
    b. Que c'est une fugue.

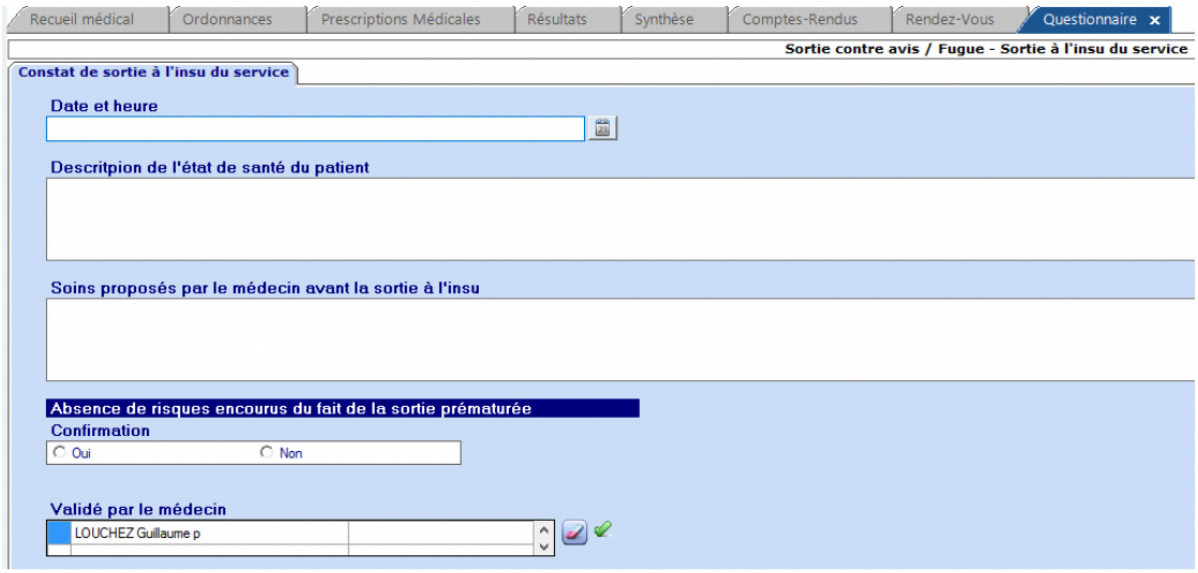
Dans le cas d'une sortie à l'insu du service :

Une sortie à l'insu du service correspond à une sortie de l'enceinte de l'hôpital d'un(e) patient(e) sans avoir averti le médecin et l'équipe soignante et dont le profil est :

- Majeur
- Et ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle
- Et ne présentant pas de risque médical aigu

1) Prévenir la cadre du service.

Remplir le « constat de sortie à l'insu du service » dans DxCare (recueil soignant > questionnaire > commun > sortie > fugue / sortie



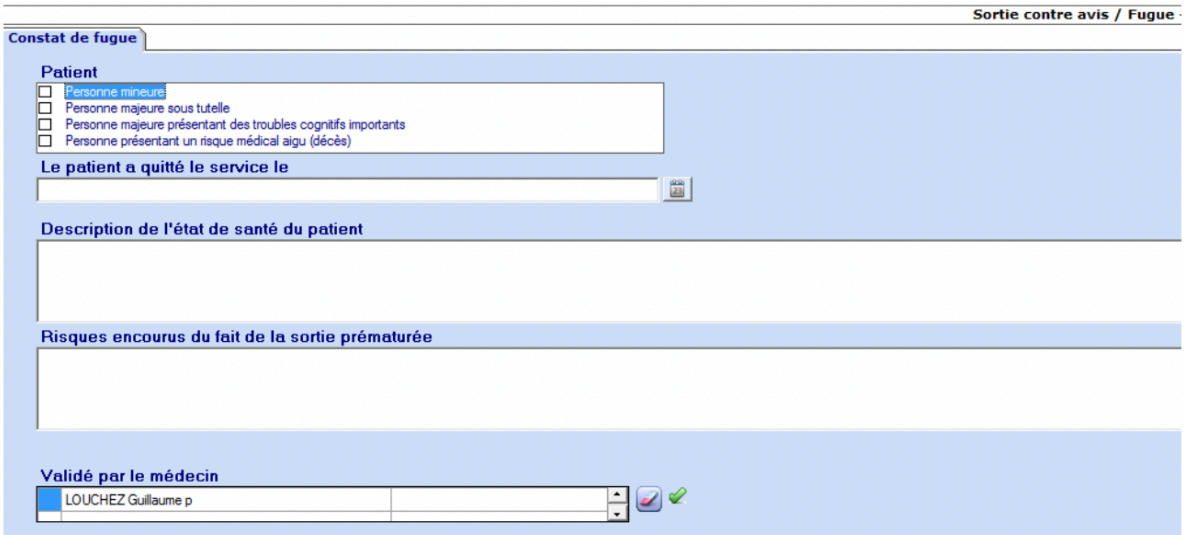
PROCEDURE EN CAS DE FUGUE

→ Dans le cas d'une fugue :

Une fugue correspond à une sortie de l'enceinte de l'hôpital d'un(e) patient(e) sans avoir averti le médecin et l'équipe soignante et dont le profil est :

- Mineur
- Ou majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
- Ou majeur présentant des troubles cognitifs importants (danger pour lui-même et/ou pour autrui)
- Ou majeur présentant un risque médical aigu

1) Prévenir la cadre du service
2) Prévenir immédiatement le service sécurité accueil (DECT : 36.65) : donner un signalement très précis (identité, sexe, âge, type, corpulence, couleur de cheveux, signes particuliers, vêtements, ect ...).
    a. Le cadre se rend au PC sécurité pour visualiser sur la vidéosurveillance si le patient a quitté l'établissement ou non.
3) Contacter : le domicile du patient, sa famille, (le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale si mineur) ou ses proches, le tuteur (si patient sous tutelle), la personne de confiance ou tout autre contact mentionné dans le dossier (médecin traitant, aide à domicile, etc.).
4) Tracer dans la transmission ciblée « fugue » : le déclenchement du niveau 1 ainsi que la nature des échanges téléphoniques.
5) Remplir le « constat de fugue » dans DxCare (recueil soignant > questionnaire > commun > sortie > fugue / sortie à l'insu du service).



6) Tracer les actions menées dans le dossier DxCare du patient.
7) Remplir une fiche d'évènement indésirable (via Intranet > Procédures & FEI).

PROCEDURE EN CAS DE DECES

Cette procédure décrit les différentes modalités autour du décès du patient.

1) Conduite à tenir au moment du décès :

En journée, l'infirmière ou le cadre prévient rapidement les agents de la chambre mortuaire du décès.

Préciser la présence ou non d'un Pace Maker et indiquer si possible, la religion du défunt (si important pour la famille).

Si un décès survient la nuit, l'assistante médicale du service doit s'assurer qu'un certificat de décès a bien été établi.

Le certificat de décès et la demande de transport de corps sans mise en bière sont imprimés et numérisés dans les documents externes du dossier patient, par l'assistante médicale en semaine ou le cadre de garde le weekend.

Le médecin informe la « personne à prévenir » du décès. Le cadre ou le médecin demande à la famille si elle souhaite se déplacer immédiatement ou non :

- Si la famille se déplace dans les heures qui suivent le décès. Le corps peut rester dans le service de soins, minimum 2 heures et 10h maximum avant le transfert à la chambre mortuaire.
- Si la famille ne souhaite pas se déplacer immédiatement, lui demander de téléphoner à la chambre mortuaire afin de convenir d'un rendez-vous pour la présentation du corps (du lundi au vendredi entre 10h et 18h – samedi, dimanche et jours fériés entre 10h et 17h).

L'infirmier(e) fait une demande de brancardage sur THEO en fonction de la réponse de la famille.

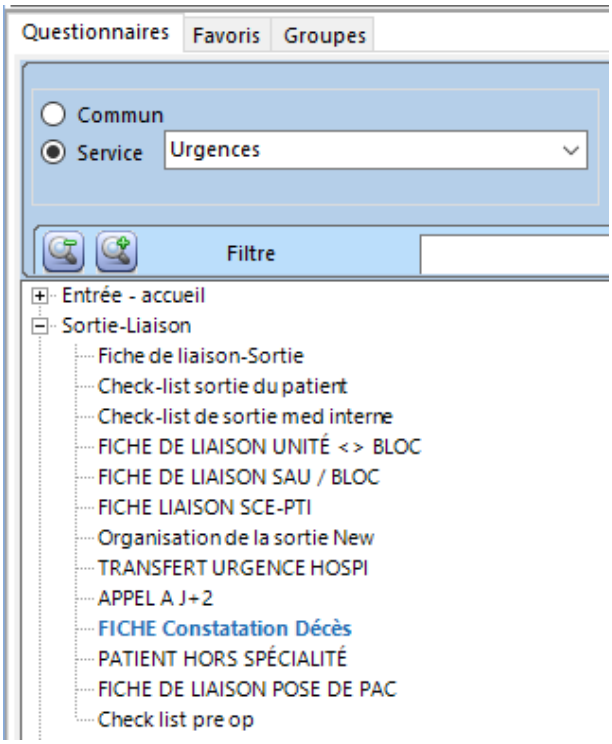
L'équipe soignante prépare la personne décédée avant son transport vers la chambre mortuaire (voir partie 3). L'IDE ou l'AS établit l'inventaire des effets personnels. Les effets personnels, hormis les valeurs, sont remis à l'entourage. Un exemplaire de l'inventaire est remis à la personne concernée et est scanné dans le dossier du patient. Les valeurs font l'objet d'un dépôt au coffre central de l'établissement. Elles ne doivent pas être remises à la famille sans avis de l'encadrement ou de l'administrateur de garde.

Dans les cas suivants :

- Transport du corps sans mise en bière,
- Don du corps,
- Autopsie,
- Obstacle médico-légal,

- Isolement social ou problème d'identité qui nécessitera des recherches

➔ Prévenir immédiatement le cadre du service ou de garde qui fera les liens nécessaires pour assurer la continuité de prise en charge.



2) Remplir la fiche « constatation de décès » sur DxCare :

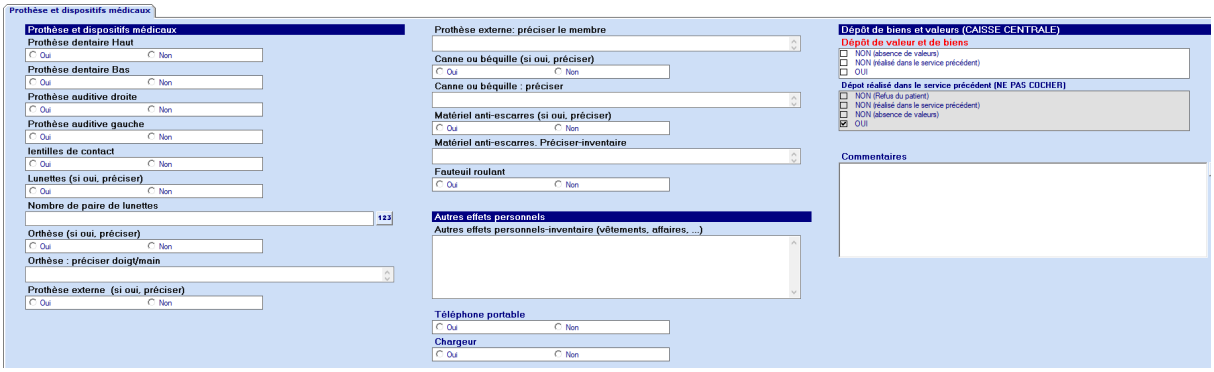
Dans le menu > recueil soignant > Questionnaires – Services Urgences > Sortie - Liaison > FICHE constatation Décès

Ouverture de la fiche de constatation du décès :

Remplir les cases suivantes :

- Entourage prévenu – fiche funéraire
- Information décès remise à la famille
- Date et heure du décès (cliquez sur le calendrier)
- Si le patient est porteur d'une prothèse fonctionnant avec une pile (Pace Maker), le noter dans « commentaires pour les agents de la chambre mortuaire ».

- Réaliser l'inventaire avec l'AS et notifier les données dans « inventaire des effets ».



3) Préparation de la personne décédée avant son transport à la chambre mortuaire :

La préparation de la personne décédée est le dernier soin réalisé par l'équipe soignante avant son départ vers la chambre mortuaire.

Elle consiste à réaliser avec soin la toilette du patient.

Elle est effectuée dans le respect des souhaits exprimés par le patient avant son décès ou par son entourage.

- Retirer les dispositifs médicaux : perfusion, sondes, drains…
- Retirer les bijoux.
- Retirer les prothèses externes : auditives, lunettes…, les mettre avec les effets personnels du patient et les noter dans l'inventaire.
- Les prothèses dentaires doivent être nettoyées et remises dans la bouche de la personne décédée.
- Les prothèses type Pace Maker doivent être signalées à la chambre mortuaire par téléphone.
- Effectuer la toilette pour rendre le corps présentable (toilette incluant le rasage et la coiffure).
- Protéger les plaies et les points de ponction (compresses, pansement adéquat).
- Mettre une protection anatomique au niveau du siège.
- Mettre une mentonnière pour maintenir la bouche fermée (commande au service Achats).
- Fermer les paupières sur lesquelles on pose un coton humide (15').
- Mettre une chemise d'hôpital.
- Vérifier que le patient est porteur de son bracelet d'identification et préparer une dizaine d'étiquettes avec le corps.
- Positionner les bras le long du corps ou croisés sur le thorax (sauf disposition autre signalée par le patient ou la famille).
- Rassembler les effets du patient qui seront rendus à l'entourage et en faire l'inventaire. En l'absence de valise, les mettre dans un SAC KRAFT 40X47X19 réf D0019256 (disponible sur commande au service Achats – V. Beurel au 7104, commande groupée par pôle car conditionnement important), en aucun cas dans un sac poubelle.

- Si la famille souhaite laisser les vêtements qui serviront à habiller le patient, les déposer dans un SAC KRAFT. Bien identifier le sac avec une étiquette patient.
- Déposer les bijoux et autres objets de valeur au coffre de l'hôpital après avoir fait un inventaire sur le formulaire « fiche de dépôt ».

4) Retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile (Pace Maker) :

Toute prothèse fonctionnant au moyen d'une pile (Pace Maker) doit être retirée.

- Le jour :

Le retrait est réalisé à la chambre mortuaire par un agent de la CM 7 jours sur 7, ou dans la chambre du patient par un médecin.

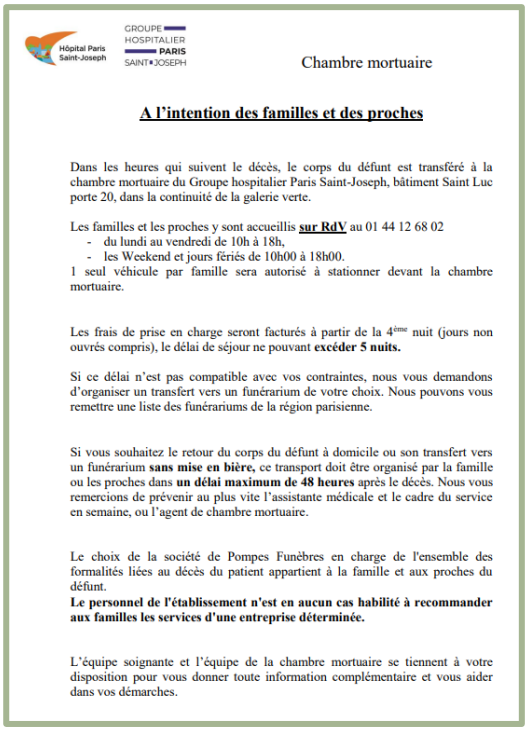
Conduite à tenir :

1. Téléphoner à la chambre mortuaire pour prévenir de la présence d'un Pace Maker
2. Vérifier sur le certificat de décès que le patient en était porteur.
3. Penser à joindre une dizaine d'étiquettes qui sont nécessaires pour l'ablation et l'élimination du pace Maker.

- La nuit :

Le retrait du pace maker sera réalisé le lendemain par les agents de la chambre mortuaire.

5) Note d'information à la famille (à remettre) :



Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Chambre mortuaire

A l'intention des familles et des proches

Dans les heures qui suivent le décès, le corps du défunt est transféré à la chambre mortuaire du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, bâtiment Saint Luc porte 20, dans la continuité de la galerie verte.

Les familles et les proches y sont accueillis **sur RdV** au 01 44 12 68 02
- du lundi au vendredi de 10h à 18h,
- les Weekend et jours fériés de 10h00 à 18h00.

1 seul véhicule par famille sera autorisé à stationner devant la chambre mortuaire.

Les frais de prise en charge seront facturés à partir de la 4ème nuit (jours non ouvrés compris), le délai de séjour ne pouvant **excéder 5 nuits.**

Si ce délai n'est pas compatible avec vos contraintes, nous vous demandons d'organiser un transfert vers un funérarium de votre choix. Nous pouvons vous remettre une liste des funérariums de la région parisienne.

Si vous souhaitez le retour du corps du défunt à domicile ou son transfert vers un funérarium **sans mise en bière,** ce transport doit être organisé par la famille ou les proches dans **un délai maximum de 48 heures** après le décès. Nous vous remercions de prévenir au plus vite l'assistante médicale et le cadre du service en semaine, ou l'agent de chambre mortuaire.

Le choix de la société de Pompes Funèbres en charge de l'ensemble des formalités liées au décès du patient appartient à la famille et aux proches du défunt.
Le personnel de l'établissement n'est en aucun cas habilité à recommander aux familles les services d'une entreprise déterminée.

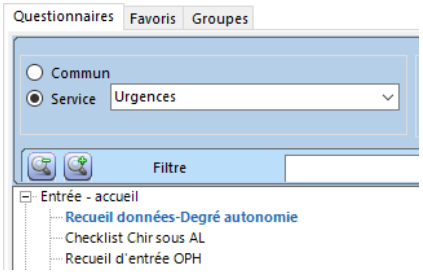
L'équipe soignante et l'équipe de la chambre mortuaire se tiennent à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire et vous aider dans vos démarches.

6) Livret d'information pour les proches d'un patient décédé à l'hôpital (à remettre) :

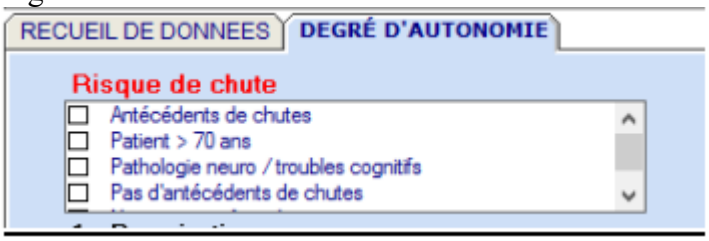
PROCEDURE DE PREVENTION DES CHUTES

La chute peut être définie comme « le fait de se retrouver involontairement sur le sol ou dans une position de niveau inférieur par rapport à sa position de départ ».

1) Identification des patients à risque de chute :



L'identification du risque de chute se fait à l'arrivée du patient dans le service de soins et peut être réalisée par une IDE ou une AS (dans DxCare aller dans : Recueil soignant > Questionnaires > Service - Urgences > Entrée - accueil > Recueil données - Degré autonomie (onglet « degré d'autonomie »).



A l'HPSJ, sont considérés comme à risque de chute, tous les patients ayant au moins 1 des 3 critères suivants :

- Plus de 70 ans
- Un antécédent de chute
- Une pathologie neurologique / troubles cognitifs

L'information saisie dans le recueil soignant se reporte automatiquement dans le bandeau et Optisoins.

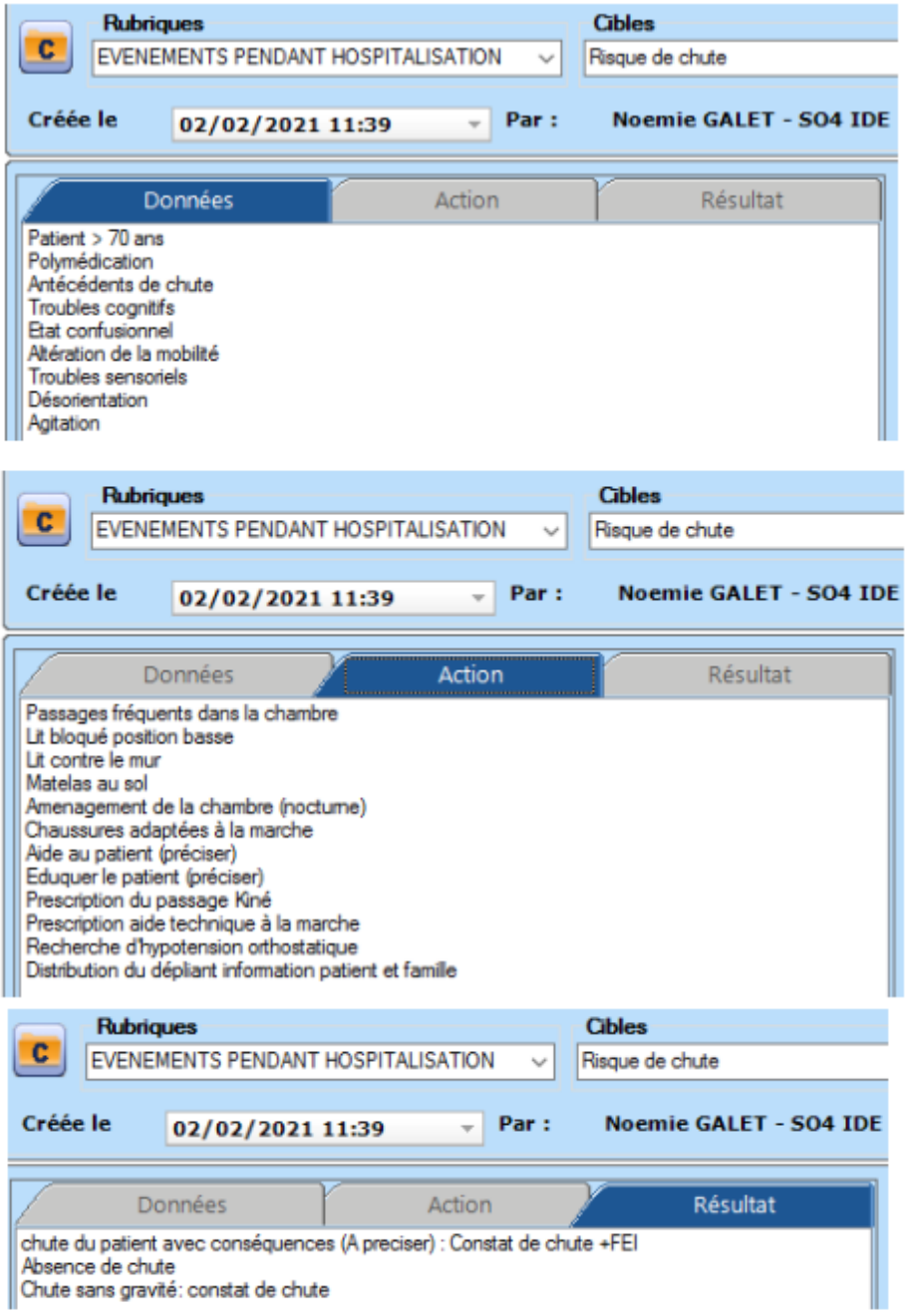
A noter : il est aussi possible de saisir un risque de chute plus tard lors de la prise en charge directement dans Optisoins (cela se reportera également dans le bandeau).

2) Éléments de prévention pour les patients à risque de chute :

Une fois le patient identifié comme à risque de chute, il est nécessaire de mettre en place des éléments de prévention.

1- Ouvrir une transmission ciblée « risque de chute »

Pour chaque patient identifié comme à risque de chute, il est nécessaire d'ouvrir une transmission ciblée « risque de chute » afin de tracer les éléments de prévention mis en place.



2- Mettre le lit en position adaptée

Pour la plupart des patients à risque de chute, régler la hauteur du lit à son niveau minimal permet de diminuer la gravité d'une éventuelle chute du patient à partir de son couchage. Ne le régler en position haute que pendant les soins pour faciliter le travail des soignants.

NB : Les lits "Enterprise" Arjo® disposent d'une hauteur de lit dite "Extra-Basse" : lors de sa descente, le sommier marque une pause lorsqu'il arrive à 38 cm du sol puis poursuit plus lentement jusqu'à sa hauteur minimale possible.

3- Ne pas mettre les barrières (sauf si prescription médicale)

Les barrières du lit sont considérées comme des contentions. Elles sont soumises à la prescription médicale. Dans le cas des chutes, la barrière est souvent un facteur de gravité de la chute :

- Patient essayant de passer par-dessus
- Patient tombant la tête en avant
- Patient restant piégé dans la barrière

En conclusion : Ne pas mettre les barrières entières sauf en cas de prescription médicale spécifique. Laisser les demi-barrières côté tête de lit en position haute pour permettre au patient d'accéder aux commandes de lit qui lui sont dédiées. De plus, elles peuvent servir d'appui au patient pour se lever de son lit.

4- Sensibilisation et éducation du patient et de ses proches

Il existe des conseils simples qui permettent de prévenir les chutes. Un « dépliant prévention

chute patient » a été créé par le groupe de travail sur les chutes de l'HPSJ.

Il est disponible à l'impression sous le score de chute dans DxCare et sur Ennov :

Une affiche est également disponible en format A3 pour mettre dans les services.

5- Chaussures adaptées à la marche

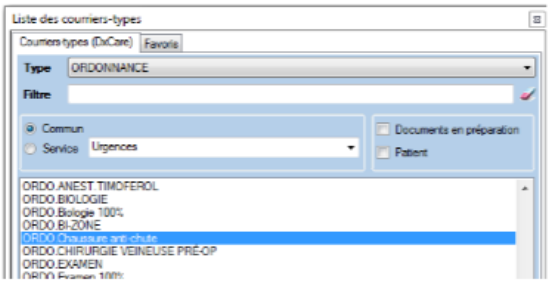
Des chaussures qui englobent le pied sont disponibles à la pharmacie pour les patients ne possédant pas de chaussures adaptées à la marche et présentant un risque identifié de chute. Ces chaussures peuvent être délivrées sur prescription médicale. Une procédure pour la « délivrance de chaussures adaptées à la marche » est disponible :

1- **Détermination du besoin de chaussures :**
   - Le patient est à risque de chute (score : antécédent de chute / > 80 ans / > 3 médicaments)
   - Le patient ne dispose pas déjà de chaussures adaptées
   - Le patient est isolé / personne dans son entourage ne peut lui procurer ce type de chaussures

➔ un seul type de chaussures de la marque Neut® est disponible en stock limité à la pharmacie

2- **Information et accord du patient**

3- **Prescription médicale :** sur Dxcare (outil bureautique ou compte rendu → courriers types → Ordonnance → ORDO.Chaussure anti-chute)



➔ Cela génère automatiquement une ordonnance, dans laquelle il faut indiquer la pointure du patient

4- **Appeler pour savoir si la pointure est disponible :**
   - **HPSJ**
     Appeler la **pharmacie** au 8042 ou au 5383 (7705 pendant les horaires de garde si urgence de 18h à 8h).
   - **HML**
     Appeler le **magasin économat** au 8643 ou la **D**irection **H**ôtelière et **L**ogistique au 8825 ou au 8820

Pour indication : si la pointure n'est pas disponible le prestataire apporte une nouvelle paire dans les 24h à 48h.

5- **Imprimer la prescription médicale et le bulletin de situation du patient** qui mentionne les droits de sécurité sociale et de mutuelle du patient nécessaires pour le remboursement

   ➔ Si le patient n'a pas de mutuelle celui-ci recevra une facture à son domicile de la part du prestataire d'environ 25€. Prix unitaire pour une paire de chaussures : environ 57€ LPPR - Prise en charge : 60% par la sécurité sociale et 40% par la mutuelle.

6- **Se déplacer à la pharmacie (HPSJ) ou au magasin économat (HML) pour aller chercher les chaussures :** celles-ci seront remises uniquement contre la prescription et le bulletin de situation

7- **Tracer dans le dossier du patient la remise des chaussures**

6- Tapis de sol « amortissant »

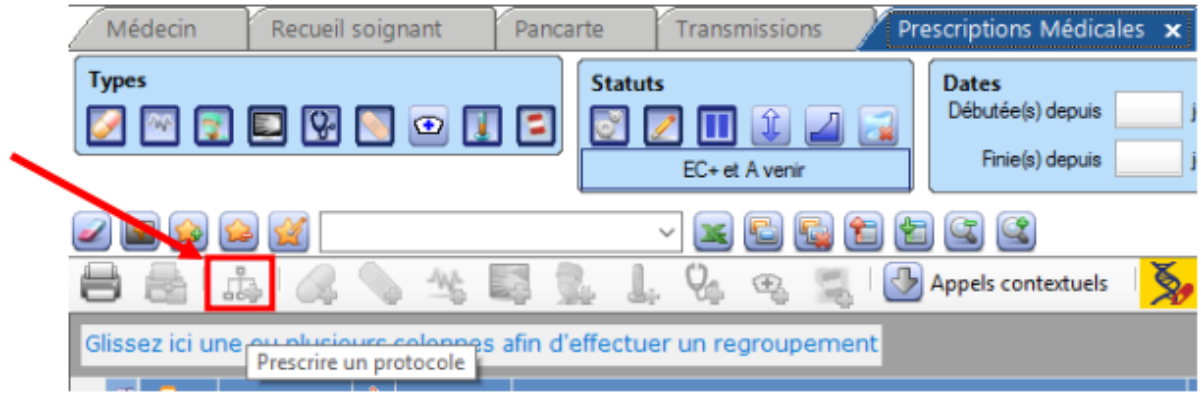
Pour les patients risquant de tomber lorsqu'ils sont couchés dans le lit ou lorsqu'ils tentent de sortir seuls du lit : ce matelas de protection se place au

sol sur le côté du lit et permet d'absorber le choc. Associé à un positionnement en hauteur extra-basse du lit, il contribue à diminuer la gravité des dommages causés par la chute.

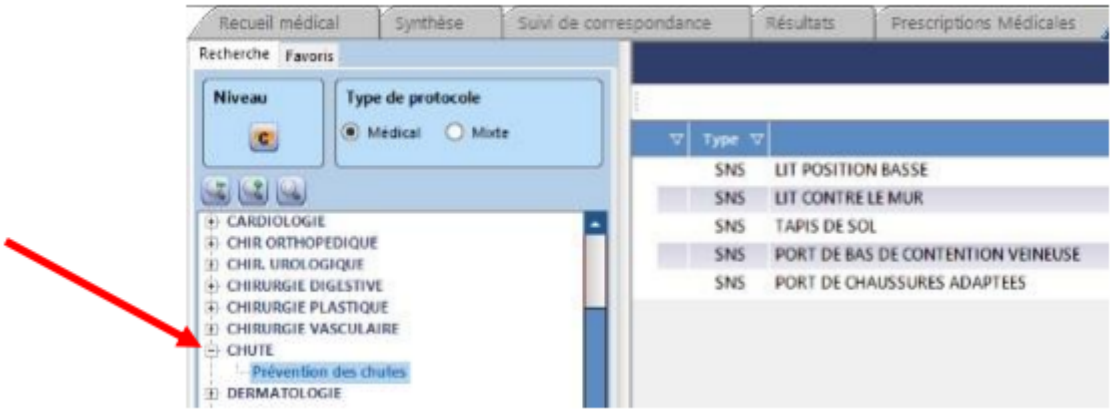
7- Prescrire un protocole médical « prévention des chutes »

Un protocole de prescription médicale a été paramétré dans DxCare. Pour l'ouvrir aller dans :

- Prescriptions médicales
- Prescrire un protocole



Type de protocole → médical → chute



Sélectionner un ou plusieurs éléments en fonction du cas clinique du patient.

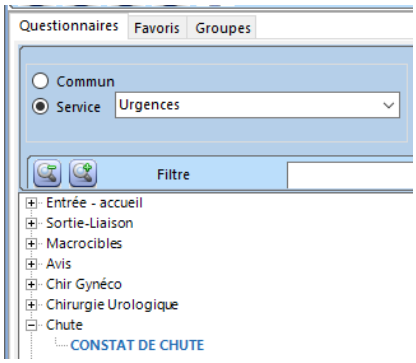
PROCEDURE EN CAS DE CHUTE D'UN PATIENT

Cette procédure permet de définir les modalités de prise en charge d'un patient qui a chuté.

Conduite à tenir devant un patient qui a chuté :

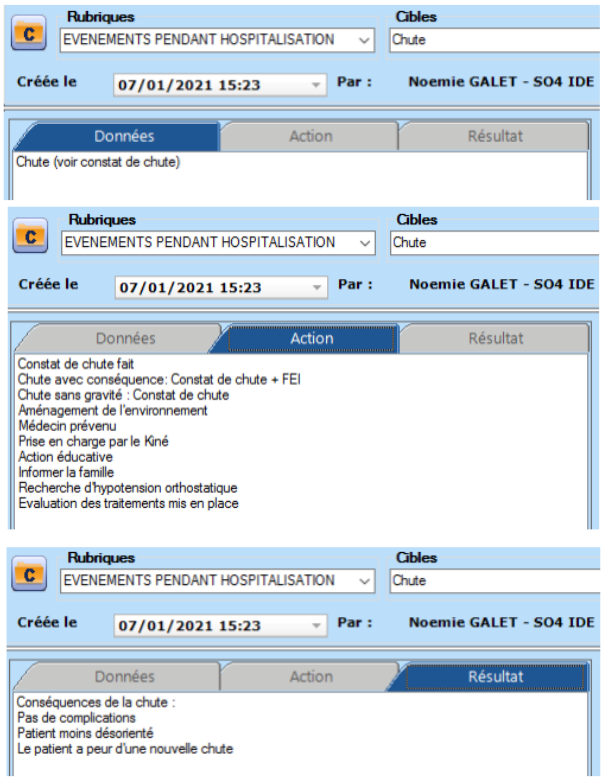
1) Écarter tout risque susceptible d'aggraver la situation du patient ou de représenter un danger pour les soignants (mobilier susceptible de tomber et/ou empêchant l'intervention des soignants).
2) Mettre dans la mesure du possible en confort le patient (oreiller, couverture).
3) Prendre les constantes et évaluer l'état de conscience (FC, TA, T°, Saturation, HGT, Glasgow, douleur) et les tracer dans le dossier patient (DxCare).
4) Évaluer les conséquences directes (plaies, déformation, trauma, hématome, saignement, douleur, agitation …).
5) Identifier si le patient a un traitement anticoagulant ou antiagrégant
6) Alerter le médecin :
   - Jour : médecin référent du patient.
   - Nuit et WE : interne de garde des urgences : 7720.

   Expliciter les circonstances de la chute (malaise ? chute mécanique ? perte de connaissance pré et/ou post accident ?).
7) Deux possibilités :
   a. Dans le cas où l'on suspecte une conséquence grave (traitement anticoagulant ou antiagrégant, déformation faisant suspecter une fracture, inconscience du patient, état de choc…) : attendre l'arrivée du médecin pour réinstaller le patient. Préciser au médecin, les éléments de gravité et solliciter sa venue de toute urgence.
   b. En l'absence de conséquence grave : réinstaller le patient en utilisant les outils adaptés.
8) Faire une prescription de surveillance rapprochée.
9) Prévenir le cadre de santé (quelle que soit la gravité, l'heure ou le jour).
10) Tracer les informations dans le dossier du patient :
    a. Pour toutes les chutes : remplir le constat de chute dans DxCare (Recueil soignant > Questionnaires > Service – Urgences > Chute > Constat de chute).
    b. Pour les chutes graves :
       - Remplir une fiche d'évènement indésirable (fracture, reprise au bloc, plaies, hématome, conséquences traumatiques nécessitant une suture ou la réalisation d'examens complémentaires).



11) S'assurer que l'information à la famille est réalisée et tracée dans le dossier, en lien avec le médecin.
12) Identifier le patient comme à risque de « chute » (si pas déjà indiqué comme à risque précédemment).

13) Ouvrir une transmission ciblée « chute » :



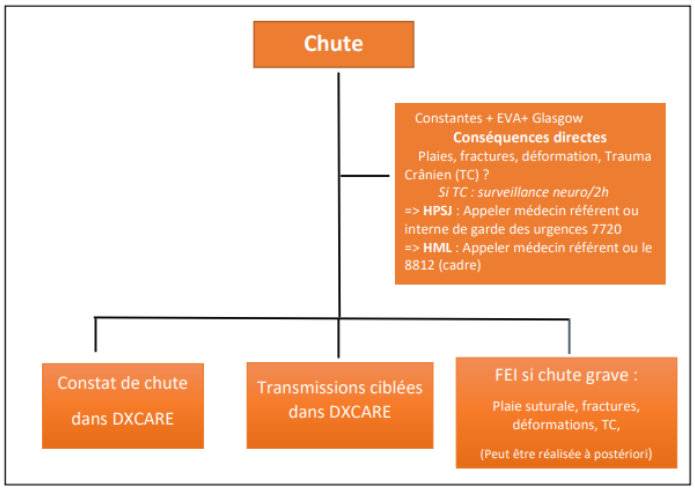
Mémo chute :

MEMO chute

Prévention du risque de chute

- Evaluer le score de chute
- Evaluer la pose du tapis amortissant
- Mettre le lit en position basse
- Vérifier le port de chaussures adaptées
- Proposer la demi barrière. La pose de barrières complète est une prescription médicale
- Sensibiliser et éduquer le patient et ses proches (dépliant : qualité/t/info-030/04-09-2019)

Conduite à tenir en cas de Chute



Prévenir une nouvelle chute

- Vérifier que tout a été mis en place pour sécuriser le patient

CHARTES DES ACCOMPAGNANTS ET BADGES

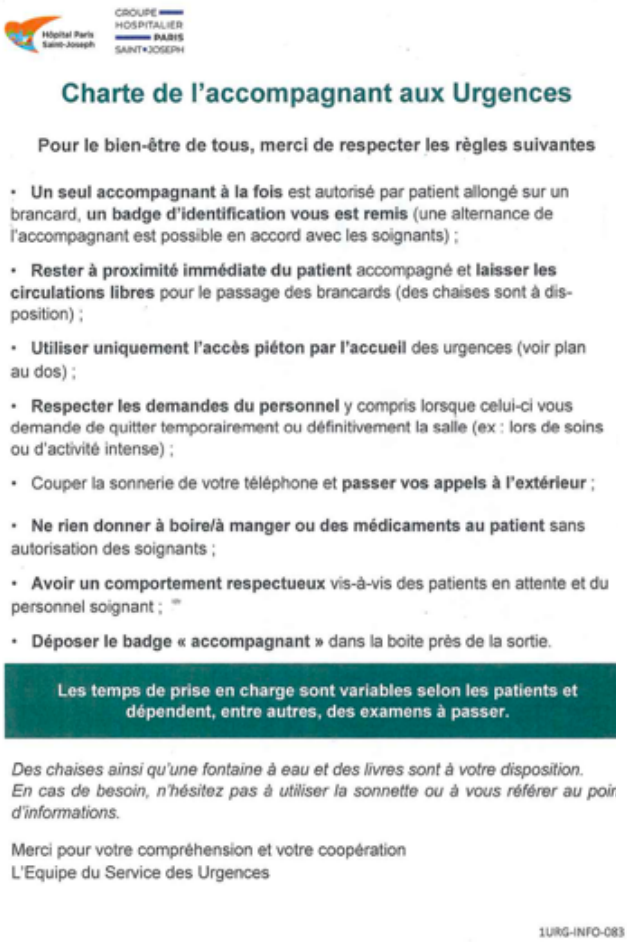
Une règle simple dans le service concernant les accompagnants :

→ Zone 1 = Pas d'accompagnants (sauf : barrière de langue, handicap, mineurs).
→ Zone 2 : 1 accompagnant max par patient.

Chaque accompagnants doit avoir un sa possession :

- 1 badge (étiquette)
- La charte des accompagnants.

(Vous trouverez ces documents à l'accueil administratif, ou dans les boxes IAO).



Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Charte de l'accompagnant aux Urgences

Pour le bien-être de tous, merci de respecter les règles suivantes

- **Un seul accompagnant à la fois** est autorisé par patient allongé sur un brancard, **un badge d'identification vous est remis** (une alternance de l'accompagnant est possible en accord avec les soignants) ;
- **Rester à proximité immédiate du patient** accompagné et **laisser les circulations libres** pour le passage des brancards (des chaises sont à disposition) ;
- **Utiliser uniquement l'accès piéton par l'accueil** des urgences (voir plan au dos) ;
- **Respecter les demandes du personnel** y compris lorsque celui-ci vous demande de quitter temporairement ou définitivement la salle (ex : lors de soins ou d'activité intense) ;
- Couper la sonnerie de votre téléphone et **passer vos appels à l'extérieur** ;
- **Ne rien donner à boire/à manger ou des médicaments au patient** sans autorisation des soignants ;
- **Avoir un comportement respectueux** vis-à-vis des patients en attente et du personnel soignant ;
- **Déposer le badge « accompagnant »** dans la boite près de la sortie.

Les temps de prise en charge sont variables selon les patients et dépendent, entre autres, des examens à passer.

Des chaises ainsi qu'une fontaine à eau et des livres sont à votre disposition. En cas de besoin, n'hésitez pas à utiliser la sonnette ou à vous référer au poir d'informations.

Merci pour votre compréhension et votre coopération
L'Equipe du Service des Urgences

1URG-INFO-083

PROCEDURE DE TRANFUSION SANGUINE ET TRAÇABILITE

Les produits sanguins labiles sont délivrés par le **dépôt de délivrance** du GHPSJ, qui dispose :

- En stock :
  - Des concentrés de globules rouges (CGR, aussi appelé concentrés érythrocytaires) des différents groupes et phénotypes les plus fréquents.
  - Des plasmas frais congelés (PFC) des différents groupes
- Sur commande :
  - Des concentrés plaquettaires (CP).
  - Des produits qualifiés ou transformés : phénotypes étendus, compatibilités irradiation, CMV négatif...

NB : il y a un réapprovisionnement quotidien du lundi au vendredi par le site distributeur de l'EFS de l'HEGP (hôpital Georges Pompidou) ; des commandes ponctuelles sont faites à la demande si nécessaire.

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph

Dépôt de Produits Sanguins Labiles

Tél : 01 44 12 34 56 Fax : 01 44 12 3230

ORDONNANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL)

Etiquette patient

☐ BLOC CENTRAL / SSPI
☐ BLOC / SSPI MATER
☐ REA / USC

Téléphone personne à contacter :

Degré d'urgence : *cocher obligatoirement 1 des 4 cases*

☐ URG *Immédiate* sans délai	☐ URG *Vitale* < 30 minutes	☐ URG *Relative* < 2 heures	☐ *Prévue pour*
En l'absence de carte de groupe et de RAI conformes → transfusion sans attendre les résultats des groupes et RAI	*En l'absence de carte de groupe et de RAI conformes → transfusion sans attendre les résultats de la RAI*	*Transfusion urgente Mais pouvant attendre la réalisation des analyses réglementaires*	Date ☐ ce jour ☐ le ..... Délivrance souhaitée : ☐ dès que possible ☐ à.....H.....

Concentrés érythrocytaires	Nbre	Qualification	Indication
☐ HOMOLOGUES		☐ Standards ☐ phénotypés ☐ Autres : *préciser*	- Hb : - Indication clinique :
☐ AUTOLOGUES			

Plasmas Frais Congelés	Nbre	Indication	Cas particulier (→ PFC VHE free)
☐ HOMOLOGUES		☐ coagulopathie grave de consommation ☐ hémorragie massive ☐ déficit en facteur(s) rare ou complexe ☐ Autres : *préciser*	☐ grossesse en cours ☐ hépatopathie chronique ☐ déficit immunitaire congénital ☐ Allogreffe de moelle
☐ AUTOLOGUES			

Concentrés Plaquettaires	Nbre	
☐ Concentré plaquettaire		Poids du patient :..... kg Numération plaquettaire : ...../mm³ Date

La décision du 06-11-06 définissant les principes de bonnes pratiques prévues à l'Art L-1223-3 CSP, prolonge, sur indication formelle du prescripteur et en l'absence d'épisode immunisant (transfusion, grossesse, greffe) dans les 6 mois précédents, la validité de la RAI de 3 à 21 jours

Pour ce patient, après vérification, je prescris la prolongation à 21 jours de la validité de la RAI ☐

Nom et Prénom du médecin prescripteur : Signature : Date : __/__/__ Heure :

Cette prescription doit être accompagnée d'un document de groupage sanguin valide et, pour les concentrés érythrocytaires, d'une RAI datant de moins de 4 jours ou des prélèvements permettant de réaliser ces examens

Exemplaire à adresser au Dépôt de Produits Sanguins Labiles TRANSFUSION/DE/VR-MAJ23-11-2017

L'acte transfusionnel en pratique :

1) Réalisation du groupage sanguin et du dépistage d'agglutines irrégulières = premier temps de l'acte transfusionnel (chapitre 4)

2) Prescription et préparation de la commande :

La prescription est faite par le médecin, après information du patient :

- Sur l'ordonnance de demande nominative :
  - Étiquette du patient avec coordonnées du service.
  - Téléphone de la personne à contacter.
  - Degré d'urgence ou date et heure de délivrance souhaité.
  - Nature et nombre de PSL demandés.
  - Indications et renseignements cliniques.
  - Date de la prescription.
  - Nom et signature du prescripteur.
- L'ordonnance est faxée à au dépôt de sang : **32.30**.
- Téléphoner au **34.56, surtout en cas d'urgence**, pour confirmer la commande.
- Lorsque la commande est prête, le dépôt de PSL avertit par téléphone (au numéro indiqué sur l'ordonnance) de la disponibilité des produits.

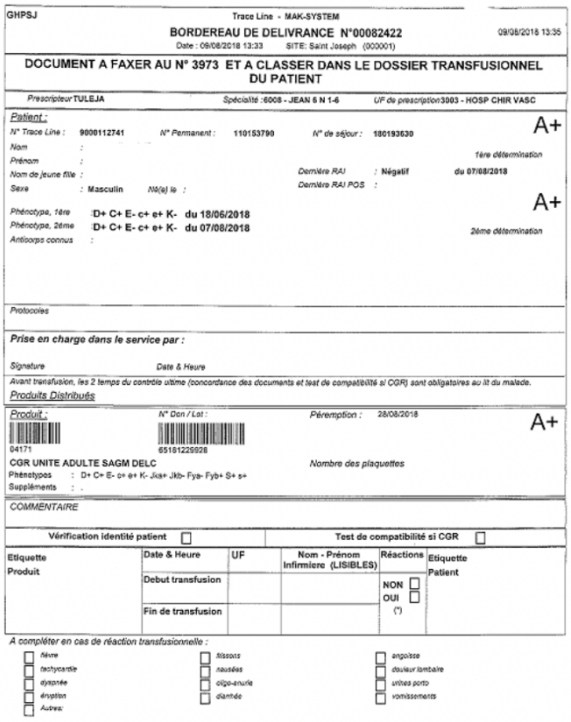
NB : hors urgence vitale (bloc...) les produits sont délivrés 1 à 1.

3) Organisation de la livraison des produits :

- L'IDE effectue une demande de course via le logiciel THEO pour obtenir un coursier (appel téléphonique en cas d'urgence vitale au 54.54). Celui-ci se présente dans le service.
- L'IDE lui remet :
  - L'original de l'ordonnance.
  - Les documents de carte de groupage et RAI.
- Le coursier :
  - Après vérification avec le dépôt.
  - Prend la livraison de la valisette isotherme avec le(s) PSL, le(s) bordereau(x) de délivrance, le(s) transfuseur(s) et pour les CGR, le(s) dispositif(s) de contrôle ultime.

4) Réception des produits dans l'unité de soins

- Le coursier remet en main propre la valisette à l'IDE qui lui a passé commande.
- L'IDE contrôle dès réception :
  - La destination (service).
  - La concordance des produits :
    - Avec la prescription médicale.
    - Et le bordereau de délivrance.
  - Leur conformité (aspect, intégrité, date de péremption).
  - La concordance stricte identité patient / documents.
    - Si OK : il (elle) note la date et l'heure et signe.
    - Au moindre doute, contacter immédiatement le dépôt de PLS au **34.56**.
- La transfusion est réalisée immédiatement ; en cas d'‘impossibilité le PSL est conservé, accroché à la potence, au lit du patient.


GHPSJ — Trace Line - MAK-SYSTEM

BORDEREAU DE DELIVRANCE N°00082422 — 09/08/2018 13:35

Date : 09/08/2018 13:33 SITE: Saint Joseph (000001)

DOCUMENT A FAXER AU N° 3973 ET A CLASSER DANS LE DOSSIER TRANSFUSIONNEL DU PATIENT

Prescripteur TULEJA — Spécialité :6008 - JEAN 6 N 1-6 — UF de prescription3003 - HOSP CHIR VASC

Patient : A+ (1ère détermination)

N° Trace Line : 9000112741 — N° Permanent : 110153790 — N° de séjour : 180193630

Nom : — Prénom : — Nom de jeune fille : — Sexe : Masculin — Né(e) le :

Dernière RAI : Négatif du 07/08/2018 — Dernière RAI POS :

Phénotype, 1ère : D+ C+ E- c+ e+ K- du 18/06/2018

Phénotype, 2ème : D+ C+ E- c+ e+ K- du 07/08/2018 — A+ (2ème détermination)

Anticorps connus :

Protocoles

Prise en charge dans le service par :

Signature — Date & Heure

Avant transfusion, les 2 temps du contrôle ultime (concordance des documents et test de compatibilité si CGR) sont obligatoires au lit du malade.

Produits Distribués

Produit : 04171 — N° Don / Lot : 6510122592B — Péremption : 28/08/2018 — A+

CGR UNITE ADULTE SAGM DELC — Nombre des plaquettes

Phénotypes : D+ C+ E- c+ e+ K- Jka+ Jkb- Fya- Fyb+ S+ s+

Suppléments :

COMMENTAIRE

Vérification identité patient ☐ — Test de compatibilité si CGR ☐

Etiquette Produit	Date & Heure	UF	Nom - Prénom Infirmière (LISIBLES)	Réactions	Etiquette Patient
	Debut transfusion			NON ☐ OUI ☐ (*)	
	Fin de transfusion				

A compléter en cas de réaction transfusionnelle :

☐ fièvre ☐ tachycardie ☐ dyspnée ☐ éruption ☐ Autres:

☐ frissons ☐ nausées ☐ oligo-anurie ☐ diarrhée

☐ angoisse ☐ douleur lombaire ☐ urines porto ☐ vomissements

Dans tous les cas, le PSL doit être transfusé dans les 6 heures après son arrivée dans le service.

5) Transfusion

- S'assurer qu'un médecin est présent à proximité, prêt à intervenir.
- Se consacrer uniquement à la transfusion et respecter la règle de l'unité de temps, de lieu et d'action : tout se passe au lit du patient ; la même personne assure

les contrôles, l'acte transfusionnel et si possible le suivi et la traçabilité.

- Faire un contrôle ultime qui comporte :
    - Obligatoirement pour tout PSL la vérification de :
        - L'identité du patient
        - La concordance patient / documents (documents de groupage, ordonnance, bordereau de délivrance).
        - La compatibilité des produits.
    - Et pour les CGR, le contrôle de compatibilité ABO en comparant le sang du patient et celui de la poche, avec le dispositif joint ; l'interpréter et signer.

Rappel sur l'interprétation : JAMAIS de réaction positive avec une poche face à une réaction négative avec le sang du patient.

→ Conserver la carte de contrôle ultime entière

        - Tracer ces contrôles sur le bordereau de délivrance

- Prendre les constantes du patient et les noter sur la feuille de surveillance, pour les entrer ensuite sur DxCare (dans les surveillances).
- Poser la transfusion avec le transfuseur fourni pour chaque PSL.
  → Coller l'étiquette du patient et 1 étiquette PSL sur le bordereau
  → Noter l'heure de début de transfusion + UF et nom du transfuseur.
- Rester présent pendant les 15 premières minutes, en surveillant les réactions du patient.
- Puis surveiller le patient et prendre les constantes toutes les ½ heures pendant le reste de la transfusion.
- A la fin de la transfusion, débrancher la poche en maintenant la voie veineuse :
    - Conserver la poche débranchée pendant au moins 2 heures.
    - Noter l'heure de fin de transfusion + UF + nom de la personne ayant débranchée la poche et les réactions éventuelles.
- Poursuivre la surveillance du patient pendant 2 heures, reprendre les paramètres vitaux
- En l'absence de problème, au bout de 2 heures, débrancher la voie veineuse, jeter la poche et la carte de contrôle pré transfusionnel.
- Faxer le bordereau de délivrance complété au dépôt de sang : 39.73.
- Classer dans le dossier transfusionnel : les résultats de groupe RAI, l'ordonnance et le bordereau de délivrance.

Noter les informations concernant la transfusion

- **<u>En cas de problème :</u>**

À tout moment, au moindre doute ne pas hésiter à demander de l'aide : s'arrêter et appeler le médecin en charge de la transfusion et/ou dépôt de sang (34.56)

Au moindre signe anormal **pendant la transfusion** :

→ **ARRETER LA TRANSFUSION** = clamper la poche en maintenant la voie veineuse.
→ Prévenir le médecin de proximité et réaliser les gestes prescrits.
→ Prévenir le dépôt de sang qui avertira le correspondant d'hémovigilance.
→ Noter sur le bordereau de délivrance les réactions observées.

FEUILLE DE SURVEILLANCE TRANSFUSIONNELLE

Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH

Surveillance de la transfusion

Date : ..... **Etiquette patient**

Etiquette poche

	Heure	Pouls	TA	Température	Fréquence Respiratoire*	Diurèse*	Autre*	Autre*	
Avant pose									

***Selon prescription médicale**

TRANSFUSION/T/ENR-015/04-03-2020

FEUILLET D'INFORMATION SUR LA TRANSFUSION

Hôpital Paris Saint-Joseph

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Pour joindre le correspondant d'hémovigilance contacter, le Dépôt de sang

Tél : 01 44 12 34 56

Fax : 01 44 12 39 73

FEUILLET d'INFORMATION sur la TRANSFUSION

Madame, Monsieur,

Si votre état de santé nécessite une transfusion sanguine, ce document est destiné à vous informer sur les avantages et les risques de la transfusion, ainsi que sur les examens à réaliser avant et après celle-ci.

Dans le cas particulier d'une intervention chirurgicale, il est possible que la décision de transfuser soit prise alors que vous serez sous anesthésie. En conséquence, cette information est assez largement diffusée en préopératoire, et le fait qu'elle vous soit communiquée ne signifie pas nécessairement que vous recevrez une transfusion. Si vous avez dû recevoir une transfusion durant l'anesthésie, nous vous en informerons dès votre réveil.

Pour en faciliter la lecture, ce document comporte une première partie résumée (CE QU'IL EST IMPORTANT DE SAVOIR) et une seconde partie plus détaillée (POUR EN SAVOIR PLUS).

Nous vous invitons à poser au médecin qui vous informera, toute question que vous jugeriez utile sur ce sujet.

185 rue Raymond Losserand
75 674 Paris cedex 14
Standard : **01 44 12 33 33**

hpsj.fr

Fondation hôpital Saint-Joseph, reconnue d'utilité publique, certifiée HAS V2014
N°FINESS 750 000 523

CE QU'IL EST IMPORTANT DE SAVOIR

A quoi sert une transfusion et quels en sont les principaux risques ?

La transfusion est un traitement qui peut être nécessaire en cas de manque de globules rouges, de plaquettes, de facteurs de coagulation, de globules blancs. Pour chacune de ces situations, il existe un produit spécifique.

Comme tout traitement, la transfusion comporte des avantages et des inconvénients. Elle n'est envisagée par votre médecin que lorsque les bénéfices attendus pour votre santé sont supérieurs aux risques encourus. Les inconvénients sont rares et le plus souvent sans gravité (urticaire, réaction fébrile).

Les précautions prises permettent de rendre exceptionnels les risques liés aux très nombreux groupes sanguins et ceux liés à la transmission d'infections, notamment les hépatites et le Sida.

Pour dépister, et traiter si nécessaire, le plus tôt possible ces éventuelles conséquences, il est recommandé d'assurer une surveillance des personnes transfusées.

Quelle surveillance en cas de transfusion ?

La recherche systématique de la trace de virus après une transfusion n'est désormais plus recommandée. En revanche, la recherche d'anticorps irréguliers à distance de la transfusion est recommandée afin d'améliorer la sécurité d'une éventuelle transfusion dans le futur.

Il vous sera remis un document comportant la nature et le nombre de produits sanguins que vous aurez reçus. Il est important de conserver ces documents et de les communiquer, ainsi que les résultats des examens, à votre médecin pour lui permettre d'assurer votre suivi.

Une information plus détaillée vous est fournie dans les pages qui suivent

POUR EN SAVOIR PLUS

❶ Les produits et leurs indications

Les produits sanguins regroupés sous le terme de "produits sanguins labiles" sont les globules rouges, le plasma frais congelé, les plaquettes et, beaucoup plus rarement, les globules blancs. Ces produits proviennent du don de sang de donneurs bénévoles. Ils sont rigoureusement contrôlés et répondent à des normes obligatoires de sécurité et de qualité : sélection des donneurs, tests de dépistage sur chaque don, règles pour assurer la qualité sur toute la chaîne depuis le donneur jusqu'au receveur.

Les **globules rouges** ont pour fonction le transport de l'oxygène vers les tissus. Leur transfusion est nécessaire en cas d'anémie importante et/ou signes de mauvaise tolérance de celle-ci, dans le but d'éviter des complications, notamment cardiaques.

Le **plasma frais congelé** contient les facteurs permettant la coagulation du sang. Leur transfusion est nécessaire lorsque le taux de ces facteurs dans le sang est trop bas, dans le but de prévenir une hémorragie ou d'en faciliter l'arrêt.

Les **plaquettes** sont indispensables à la formation d'un caillot. Elles sont transfusées si leur nombre est très insuffisant, dans le but de prévenir une hémorragie ou d'en faciliter l'arrêt.

Les **globules blancs** contribuent à la défense contre l'infection. Il peut être nécessaire d'en transfuser lorsqu'ils sont pratiquement absents du sang.

D'une manière générale, tous les efforts sont faits pour limiter l'usage de ces produits au strict nécessaire.

Leurs indications ont notamment été précisées par la communauté médicale et les autorités sanitaires, de telle sorte que leurs bénéfices soient très supérieurs aux risques résiduels de la transfusion.

❷ Les risques connus

Comme tout traitement, la transfusion sanguine comporte des risques. Des réactions sans conséquences graves peuvent survenir pendant et après transfusion, comme de l'urticaire, ou des frissons et de la fièvre sans cause infectieuse. Les autres risques sont aujourd'hui limités grâce aux mesures déjà prises. Il s'agit :

☞ **Des risques liés aux très nombreux groupes sanguins :**
Il est impératif de respecter la compatibilité dans les groupes ABO et rhésus. De nombreux autres groupes sanguins existent également, contre lesquels vous avez pu développer des anticorps (appelés "irréguliers"), qu'il importe donc de rechercher avant la transfusion pour en tenir compte dans le choix du produit transfusé.
Votre identité et votre groupe sanguin seront de nouveau vérifiés juste avant la transfusion de globules rouges.
La transfusion peut provoquer l'apparition d'anticorps irréguliers (dans 1 à 5 % des cas), ce qui peut avoir des conséquences en cas de transfusion ultérieure.

☞ **Des risques résiduels de contamination :**
Ils continuent de diminuer avec les progrès des connaissances et des techniques.

❸Les dangers inconnus

Comme on ne peut, de principe, exclure des dangers inconnus, toutes les mesures possibles de prévention ont été prises, dans la sélection des donneurs de sang (notamment l'exclusion des personnes antérieurement transfusées) et dans la préparation des produits. En outre, une surveillance nationale des incidents de la transfusion a été mise en place depuis 1994 (l'hémovigilance).

Si cela s'avérait nécessaire, des informations complémentaires vous seraient communiquées.

❹Les examens biologiques avant et après transfusion

Le niveau de sécurité désormais atteint en matière de transmission de virus ne rend plus nécessaire la recherche systématique de leur trace avant et après la transfusion.

En revanche, afin de prévenir les risques liés aux très nombreux groupes sanguins, un certain nombre d'examens doivent être effectués.

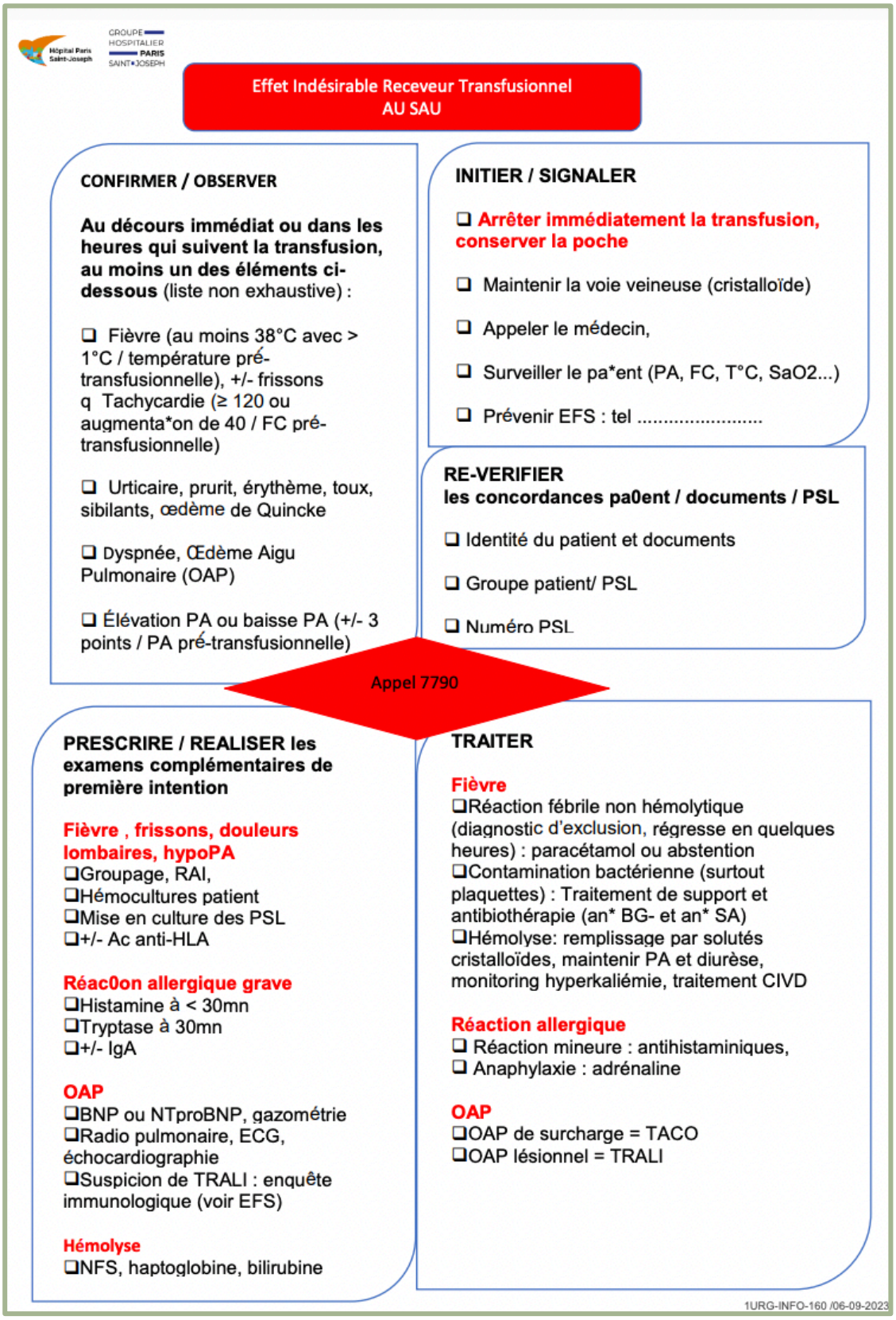
Il est important d'informer des résultats, soit le médecin traitant, soit le médecin de l'hôpital qui a prescrit ces examens.

Si des anticorps irréguliers sont apparus après la transfusion actuelle, il sera utile de le signaler en cas de nouvelle transfusion, pour en améliorer la sécurité.

❺Les documents remis et l'importance de leur conservation

Après une transfusion, il est remis, avant la sortie de l'hôpital, un document écrit comportant la date des transfusions, l'établissement et le service où elles ont été réalisées, le type et le nombre des produits sanguins labiles reçus. Il est important de conserver ce document avec soin et de le montrer à son médecin traitant. Il en a besoin pour assurer un suivi médical de qualité. En cas de transfusions régulières, ces informations peuvent être reportées sur un document récapitulatif.

EFFETS INDESIRABLES RECEVEUR TRASFUSION SANGUINE



PROCEDURE D'IDENTITO-VIGILANCE (BRACELET D'IDENTIFICATION)

→ Généralité :

L'identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en charge et à chaque venue permet de relier toutes les données relatives à la personne et de délivrer l'acte prescrit à la bonne personne. Il s'agit d'un enjeu majeur pour la continuité et la sécurité des soins compte-tenu du risque d'erreurs potentiellement graves liées à une mauvaise identification (erreur de site opératoire, erreur de traitement, erreur de résultats de laboratoire, ect).

Un système de surveillance, de correction et de prévention des erreurs permet de maîtriser ce risque.

→ Les risques liés à l'identité des patients :

Dans la cadre de la démarche qualité du GHPSJ, les risques liés à l'identité des patients ont été identifiés. Ces risques sont documentés et suivis dans le compte qualité du GHPSJ.

On peut noter, par exemple, les risques suivants :

- Erreur sur l'identité du patient lors de l'administration d'un médicament.
- Erreur sur l'identité du patient lors d'un prélèvement biologique.
- Erreur sur l'identité du patient lors d'une transfusion.
- Erreur sur l'identité du patient lors de la création du dossier administratif et du dossier patient informatisé.
- Usurpation d'identité
- Erreur sur l'identité du patient lors d'un acte d'imagerie médicale.
- Erreur sur l'identité du patient lors d'un acte interventionnel (bloc opératoire, endoscopies, fibroscopies, PTI, ect).
- Erreur sur l'identité du patient lors d'un brancardage.

→ Règles générales d'identitovigilance :

Le GHPSJ a défini plusieurs règles générales et a mis en place une organisation permettant de réduire les risques et d'assurer la meilleure qualité d'identité des patients possible.

- Pièce d'identités :

La création ou la modification d'une identité des patients doit s'appuyer sur un document officiel d'identité :

  - Pour les patients adultes :
    - Carte nationale d'identité (CNI)
    - Passeport
    - Titre de séjour.
  - Pour les patients mineurs ou sous tutelle :

- CNI, Passeport ou titre de séjour + pièce d'identité des représentants légaux
- Pour les patients mineurs, ne possédant pas leur propre pièce d'identité
- Livret de famille + pièce d'identité des représentants légaux.
- Extrait d'acte de naissance + pièces d'identité des représentants légaux.

L'identité du patient doit être vérifié par l'employé (vérification de la photo). Ces documents, délivrés par des organismes d'état et munis d'une photo récente du patient, sont listés dans les procédures internes au GHPSJ, ainsi que dans le référentiel national d'identitovigilance.

- Pose de bracelets :

Tous les patients hospitalisés se voient poser un bracelet d'identification par le personnel soignant qui accueille le patient à son arrivée. Ce bracelet comporte une étiquette d'identification sur laquelle sont mentionnés le nom de naissance, le nom utilisé, premier prénom, date de naissance, numéro d'identification permanant (NIP/IPP) et numéro de séjour (avec code barre).

- Refus d'un patient de présenter sa pièce d'identité officielle :

Il a été décidé que, dans le cas d'un patient refusant de présenter sa pièce d'identité pour une prise en charge programmé, le refus sera tracé dans la fiche administrative du patient. La prise en charge sera réalisée mais en sensibilisant le patient sur les risques encourus en cas de mauvaise identification (nom et/ou prénom mal orthographiés, risque transfusionnel, usurpation d'identité, ...).

- Impossibilité pour un patient adulte de présenter une pièce d'identité officielle :

Il a été décidé dans le cas d'un patient pris en charge en urgence, si celui-ci ne peut produite une pièce d'identité officielle (patient inconscient, incapacité physique, en attente de régularisation de droit de séjour sur le territoire, production du permis de conduire), la prise en charge sera réalisée, mais en sensibilisant le patient ou sa famille sur les risques encourus en cas de mauvaise identification (nom et/ou prénom mal orthographiés, risque transfusionnel, usurpation d'identité, ...) et le patient ou sa famille sera fortement incité(e) à produire le document officiel dans les plus bref délais afin de fiabiliser l'identité du patient.

ALARME AGRESSION

A ECRIRE

ALARME ACR

A ECRIRE

PROCEDURE MATERIEL DEFECTIEUX

A ECRIRE

PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE D'UN MINEUR AUX URGENCES

L'âge de la majorité en France a été fixé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974.

L'admission d'un mineur est prononcée par le directeur de l'hôpital, sur avis d'un médecin de l'établissement, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale (père, mère ou représentant légal).

La prise en charge d'un mineur nécessite de suivre les recommandations suivantes :

→ Moyens :

- Disposer de matériels adaptés (notamment en cas d'urgence vitale...).

→ Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel :

- Par écrit, par les deux personnes possédant l'autorité parentale ou le représentant légal.

- En cas d'urgence vitale, ces autorisations ne sont pas requises.
- En cas d'absence des parents, toutes les actions pour les joindre et obtenir leur accord et consentement écrit, doivent être mises en œuvre et tracées dans le dossier.
- En cas de mineur isolé, si l'état du patient requiert un geste urgence, c'est l'ADG qui signe l'autorisation d'opérer, s'il s'agit d'une programmation un signalement au procureur est effectué par le service social pour mettre en place des mesures de protection par le parquet des mineurs et l'ASE[2].

→ Pendant sa prise en charge :

- Mineur accompagné par l'un des parents ou son représentant légal ou par un majeur.
- Isolement en box ou à l'espace F.
- Si hospitalisation, obligatoirement en chambre seule, près du poste de soins.

→ Sortie du mineur :

- Réalisée par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale, le représentant légal ou une personne désignée par eux, par écrit.
- En cas d'absence des parents, il convient d'avertir le service Relations Patients (DECT : 35.85) ou l'ADG qui précisera la conduite à tenir.

Documents spécifiques à récupérer :

- Le carnet de santé
- Une copie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance

[2] Cf « procédure prise en charge d'un enfant mineur dont l'un des parents ou représentant légal est hospitalisé en urgence ».

- ➔ Une copie de la carte d'identité des deux parents ou tuteurs légaux
- ➔ Une copie du jugement de divorce ou du justificatif de dissolution du PACS en cas de séparation
- ➔ En cas d'absence des parents, une procuration signée par les deux parents autorisant un autre adulte à venir chercher le mineur. L'identité du majeur doit être citée dans la procuration et vérifiable par une pièce d'identité lors de la sortie du mineur.
- ➔ En cas de défaillance d'un des deux représentants légaux, l'unique représentant doit produire une attestation sur l'honneur, certifiée conforme par un commissariat ou une mairie, indiquant qu'il est le seul représentant légal de l'enfant.

➔ Aux urgences, dès l'IOA :

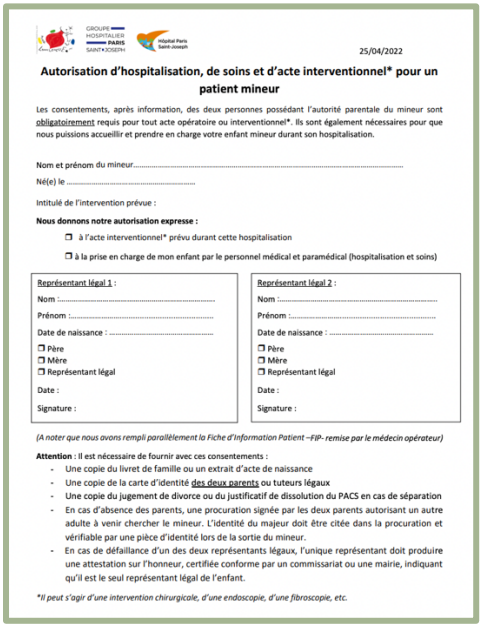
Dans le recueil IOA, vous trouverez un lien contextuel amenant à la fiche d'autorisation de soins. Lorsque l'un des parents ou le représentant légale est présent :

1) Imprimer la fiche et la faire remplir par le parent ou le représentant légal.
2) Récupérer une pièce d'identité du parent ou du représentant légal.
3) Remettre la fiche et la pièce d'identité aux agents d'accueil qui la scannerons dans le dossier patient.

Si le mineur n'est pas accompagné par l'un de ses parents ou un représentant légal, dite au mineur d'appeler ses parents, si vous avez le numéro, les appeler et leur demander de venir aux urgences ou d'envoyer par mail un courrier reprenant l'autorisation de soins. Prévenir l'encadrement (cadre).

Pour la sortie, si les parents sont absents, il faut une procuration signée par les deux parents autorisant un autre adulte à venir chercher le mineur. L'identité du majeur doit être citée dans la procuration et vérifiable par une pièce d'identité lors de la sortie du mineur.

➔ Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel pour un patient mineur :



25/04/2022

Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel* pour un patient mineur

Les consentements, après information, des deux personnes possédant l'autorité parentale du mineur sont obligatoirement requis pour tout acte opératoire ou interventionnel*. Ils sont également nécessaires pour que nous puissions accueillir et prendre en charge votre enfant mineur durant son hospitalisation.

Nom et prénom du mineur.....

Né(e) le .....

Intitulé de l'intervention prévue :

Nous donnons notre autorisation expresse :

❒ à l'acte interventionnel* prévu durant cette hospitalisation

❒ à la prise en charge de mon enfant par le personnel médical et paramédical (hospitalisation et soins)

Représentant légal 1 :	Représentant légal 2 :
Nom :.....	Nom :.....
Prénom :.....	Prénom :.....
Date de naissance :	Date de naissance : .....
❒ Père ❒ Mère ❒ Représentant légal	❒ Père ❒ Mère ❒ Représentant légal
Date :	Date :
Signature :	Signature :

(A noter que nous avons rempli parallèlement la Fiche d'Information Patient –FIP- remise par le médecin opérateur)

Attention : Il est nécessaire de fournir avec ces consentements :

- Une copie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance
- Une copie de la carte d'identité des deux parents ou tuteurs légaux
- Une copie du jugement de divorce ou du justificatif de dissolution du PACS en cas de séparation
- En cas d'absence des parents, une procuration signée par les deux parents autorisant un autre adulte à venir chercher le mineur. L'identité du majeur doit être citée dans la procuration et vérifiable par une pièce d'identité lors de la sortie du mineur.
- En cas de défaillance d'un des deux représentants légaux, l'unique représentant doit produire une attestation sur l'honneur, certifiée conforme par un commissariat ou une mairie, indiquant qu'il est le seul représentant légal de l'enfant.

**Il peut s'agir d'une intervention chirurgicale, d'une endoscopie, d'une fibroscopie, etc.*

PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DE CONTENTION

Règles :

Réalisation :

- 5 soignants minimum.
- 1 seul interlocuteur pour le patient.
- 1 soignant par membre + 1 tête + coordination.
- 5 ou 3 points : Ventrale + 4 membres ou 2 membres.
- Jamais de contention à 1 points (ventrale seule).

Mise en condition :

- Déshabillage.
- Surélever la tête.
- Vérifier qu'aucun point ne soit douloureux ou compressif.
- Recouvrir le patient d'un drap.
- Cambre seule / porte entrouverte.

Prescription médicamenteuses obligatoire :

- Réaliser un ECG (si possible) avec analyse du QT.
- Loxapax® 100mg Per Os ou IM si refus de la voie orale.
    - Refaire une injection au bout de 45 min si pas d'efficacité.
- Valium® 10mg en cas d'agitation due à l'alcool (sevrage ou intoxication).
    - Pas de Valium® si âge > 70 ans ou confusion.

Surveillance obligatoire :

- Date et heure de la contention
- Fréquence 30 min, 1h, 2h, 3h puis toutes les 2h :
    - FC, FR, SaO2, Niveau de vigilance.
    - Zones de compression : douleur, positionnement, caractère non compressif.
- Assurer soins d'hygiène, la nutrition, l'hydratation et l'élimination.
- Heure de levée de la contention.

Dans DxCare →

METTRE PHOTO

PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SDF

Les circuits de prise en charge sont définis et formalisés selon le degré d'urgence et la typologie des patients. Il s'agit pour ce protocole d'encadrer la prise en charge des patients sans domicile fixe à l'accueil et à la sortie.

Conduite à tenir :

- Prise en charge IOA :

La prise en charge des patients SDF par l'IOA est identique à celle de tout patient.

Prise des paramètres vitaux systématiques : FC, SpO2, PA, FR, GSC, HGT

  - Éthylotest si doute sur la présence d'une intoxication alcoolique (et si réalisation possible).
  - Si notion d'exogénose (alcoolisme) connue → score de Cushman et délivrance de Valium®.

- Situations particulières :

➔ Pas de plainte somatique
  - Normalité des paramètres vitaux
  - Appel du MAO
  - Sortie avec accord médical, notée dans le dossier par le médecin ou l'IOA (nom du médecin).
  - Sortie encadrée : raccompagnement à l'entrée de l'hôpital (si besoin agent de sûreté).

➔ Refus de prise en charge
  - Normalité des paramètres vitaux
  - Appel du MAO
  - Soit sortie avec accord médical, notée dans le dossier et sortie encadrée.
  - Soit décision médicale de contention si nécessité d'une PEC médicale.

➔ Patient agressif :
  - Prise des paramètres vitaux si possible.
  - Appel du MAO, vérification de l'absence de plaintes somatiques ou de signes de gravité.
  - Appel de la sécurité, discuter une contention.
  - Contact du commissariat du 14eme
  - Rédaction du certificat de non-admission (CNA) par le MAO.

➔ Patient avec plaintes somatiques et/ou intoxication alcoolique sévère :

- Prise en charge classique.
- Patient couché mis en attente zone 2.
- Déshabillage et organisation d'une toilette avec l'AS de la zone 2.
- Surveillance du score de Cushman
- Confirmation de l'intoxication alcoolique :
  - Patient conscient : éthylotest uniquement si non nécessité d'un bilan sanguin
  - Trouble de la conscience ou autre plaintes somatiques nécessitant un bilan : alcoolémie
- Admission en 30.66

➔ Patient sans plaintes somatiques demandant un hébergement :

- Normalité des paramètres vitaux
- Appel du MAO
- Si plan Grand Froid déclenché (cf procédure « grand froid »)
  - Lieu de repos dans le hall de l'hôpital, ouvert sur décision médicale avec le cadre de nuit, à proximité du PC sécurité.
  - Capacité : 5 brancards-lits.
  - Indication : hommes adultes, SDF.
- Hors plan Grand Froid :
  - En journée : appel assistante sociale (DECT : 76.84).
  - Week-end/jour férié/garde : prise en charge par le SAMU social ou retour sur le lieu de vie.

➔ Sorite du patient SDF :

- Dès la décision médicale notée dans le dossier.
- Prises des paramètres vitaux par l'IDE
- CRH de sortie remis au patient dans une enveloppe (destiné aux maraudes extérieures).
- Remise des effets personnels (dont bouteilles d'alcool).
- Dès la sortie administrative, raccompagnée jusqu'à l'entrée de l'hôpital par l'agent de sûreté.
- En cas de refus de sortie, d'agressivité → Sortie avec l'agent de sûreté.

➔ Numéros utiles :

- SAMU Social : 01.58.46.20.04 (entre 21h et 4h).
- Commissariat du 14eme : ...

CONDUITE A TENIR EN CAS D'AES

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

N° vert VIH info soignants : 0810 630 515

Conduite à tenir en cas d'AES St JO

1 ére étape : Protocole de nettoyage et d'antisepsie

Réaliser les premiers soins à l'aide du KIT AES :

Piqure et blessures ou contact direct du liquide biologique sur peau lésée

- Ne pas faire saigner
- Nettoyer immédiatement la zone cutanée lésée à l'eau et au savon puis rincer
- Antiseptique, pendant au moins 5 min avec dérivé chloré : Dakin ou à défaut Bétadine rouge

Projection sur muqueuses et yeux

- Rincer abondamment à l'eau ou au sérum physiologique pendant 5 min au moins

2 éme étape : Alerter et identifier le patient source

Prévenir le cadre du service

-Vérifier dans le dossier du patient si les statuts sérologiques récents (moins d'un mois) sont connus (VIH, VHB, VHC)
-Si les statuts sérologiques récents ne sont pas connus, après accord et signature du consentement du patient source, prélever :

1 tube rouge (patient source) + **2 tubes mauve (patient source)+ 3 étiquettes patient source**

-**Spécificité dans les blocs** : Joindre le « référent IADE du jour » au 7671
Le patient source, hors d'état d'exprimer sa volonté dans un délai de 4 h, a signé le « consentement au prélèvement sanguin » dans la Fiche d'information patient (FIP) disponible sur DX care. Le BON AES disponible au bloc, permet de réaliser les sérologies du patient en urgence Qui seront envoyés directement au laboratoire.

3 éme etape : Prise en charge medicale au SAU du salarié exposé

Le salarié exposé doit se rendre aux URGENCES dans 1 délai de 4H avec **sa carte d'identité** et **sa carte vitale**
+ les **tubes de prélèvement étiquetés** du patient source dans un sachet double poche **+ 3 étiquettes**.
Tel du SAU :3949 / Mail : admsau@ghpsj.fr

4 éme étape : Déclaration administrative de L'AT

Contacter l'assistante de prévention du service RH le plus rapidement possible avec **le certificat médical initial** (CMI) délivré par le Médecin des urgences, afin d'établir **la déclaration d'accident de travail** DAT qui sera adressée à la CPAM du salarié.
Elle délivrera une **feuille se soin** à transmettre à l'accueil des urgences pour éviter la facturation de la consultation et de la part mutuelle
Tel :3839/ mail : assistanteprevention@ghpsj.fr **/ BAT Losserand porte B 1er étage (8h30 12h30-13h30 17h00 jours ouvrés).**

5 éme étape : Information du Service de Santé au Travail

Contacter le service de SANTE AU TRAVAIL pour informer de L'AES, le SST renseignera le Dossier Médical de santé au travail sur le suivi biologique et vérifiera les vaccins. **Tel : 3508/3509 / mail:** médecinetravailstjo@ghpsj.fr

PRESCRIPTION DE TRAITEMENT DE SUBSTITUTION NICOTINIQUE (TSN) PAR LES IDE

Dans le cadre des protocoles de coopération professionnelle aux urgences, des actes diagnostiques et thérapeutiques sont délégués aux infirmières par les médecins.

Les **IDE peuvent prescrire des substituts nicotiniques** pour les patients des urgences.

Elles reçoivent pour cela une **formation spécifique en interne** et peuvent prescrire des peuvent prescrire des substituts nicotiniques pour les patients se présentant au service des urgences.

Critères d'inclusion :

- Patient de **18 ans et plus** ayant été **informé du protocole**,
- Tabagique
- **Faisabilité** : Patient **coopérant**

Critères d'exclusion :

- Patient **n'ayant pas consenti** au protocole,
- Patient non tabagique
- **Instabilité hémodynamique ou troubles de la vigilance**
- **Agitation** liée à une confusion, une démence, à la consommation de stupéfiant ou d'alcool ; agressivité manifeste,
- **Situation peu claire** créant un doute.

Modalités de prescription :

1. Posologie des patchs

- **Dose initiale**

Le choix de la **dose** constitue un **facteur important du succès**.

Elle sera **ajustée** selon l'existence de symptômes de **surdosage ou sous dosage** (intérêt de l'éducation du patient à reconnaitre ces signes).

Une règle peut être retenue

1 cigarette = 1mg de nicotine par patch.

Fume	< 10 cig. / jour	11 - 20 cig. / jour	21 - 30 cig. / jour	> 30 cig. / jour
moins de 5' après le lever	Patch moyen + formes orales	Patch grand + formes orales	Patch grand patch moyen + formes orales	Patch grand + patch moyen + formes orales
moins de 30' après le lever	Patch moyen + formes orales	Patch grand ou moyen + formes orales	Patch grand + formes orales	Patch grand patch moyen + formes orales
30 à 60' après le lever	Formes orales	Patch grand ou moyen + formes orales	Patch grand + formes orales	Patch grand + formes orales
plus de 60' après le lever	rien ou formes orales	Patch moyen + formes orales	Patch grand + formes orales	Patch grand + formes orales

On y **associera des formes orales à la demande**, autant que nécessaire, pour ne pas ressentir le manque.

La dose à proposer dépendra :

- Du nombre de **cigarettes fumées par jour**
- Du **délai** entre le **réveil et la première** cigarette

Patch grand = correspond aux formes 25mg/16h ou 21 mg/24h ou 15mg/16h
Patch moyen = correspond aux formes 14mg/24h ou 10mg/16h
Patch petit = correspond aux formes 7mg/24h

- **Cas particulier : Femme enceinte**
  - Si le sevrage ne peut être réalisé sans substitution, il est recommandé d'utiliser les **patchs sur 16 heures**.
  - En cas de réduction récente de la consommation : **substituer en tenant compte de la consommation habituelle** et non pas de la consommation réduite, en raison du phénomène de compensation

- **Réévaluation** quotidienne

Signes de **sous dosage** en nicotine : irritabilité, colère, nervosité, anxiété, difficultés à se concentrer, déprime, pleurs, augmentation de l'appétit, troubles du sommeil, pulsions à fumer => augmenter la dose.

- Signes de **surdosage** en nicotine (rare) : céphalées, palpitations, nausées, trouble du sommeil, excitation, vertiges, impression d'avoir trop fumé => diminuer la dose.

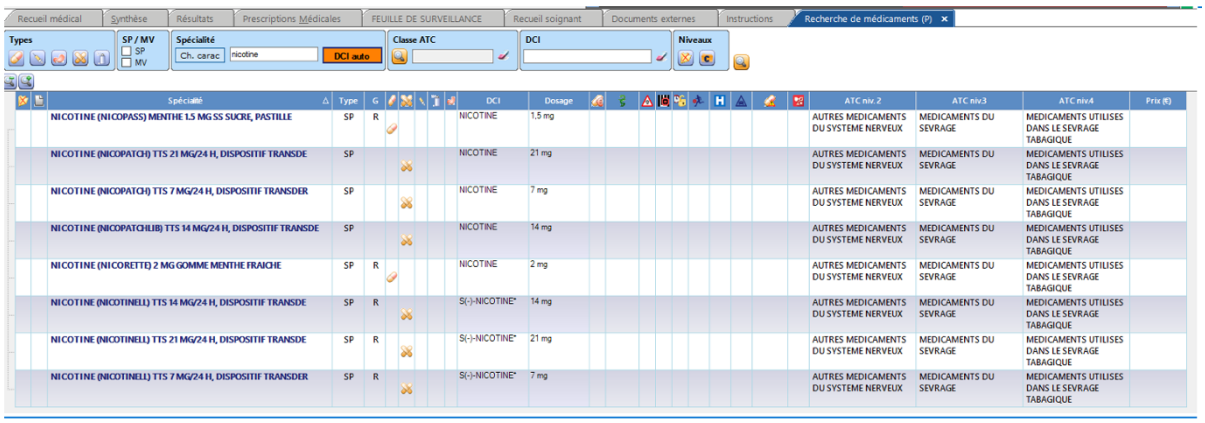
2. Mode d'emploi des patchs

- Les patchs doivent être appliqués **chaque matin**. Le **site** d'application devra être **changé chaque jour**.
- L'**effet** commence à être perceptible au bout de **trente minutes** environ et se poursuit tout au long de la journée.
- Il est conseillé de garder un **patch sur 24 heures**, quand le délai entre le réveil et la première cigarette est **inférieur à 30 minutes** (pour éviter le manque de nicotine au réveil).
- Des **troubles du sommeil** peuvent apparaitre avec les patchs mis sur 24 heures. Si cela est le cas, les enlever la nuit.
- En début de sevrage, la dose de nicotine doit être suffisante pour compenser l'apport habituel de nicotine obtenu en fumant. Les **patchs les plus petits** doivent être utilisés en fin de période de sevrage, **jamais au début.**

3. Formes orales à la demande

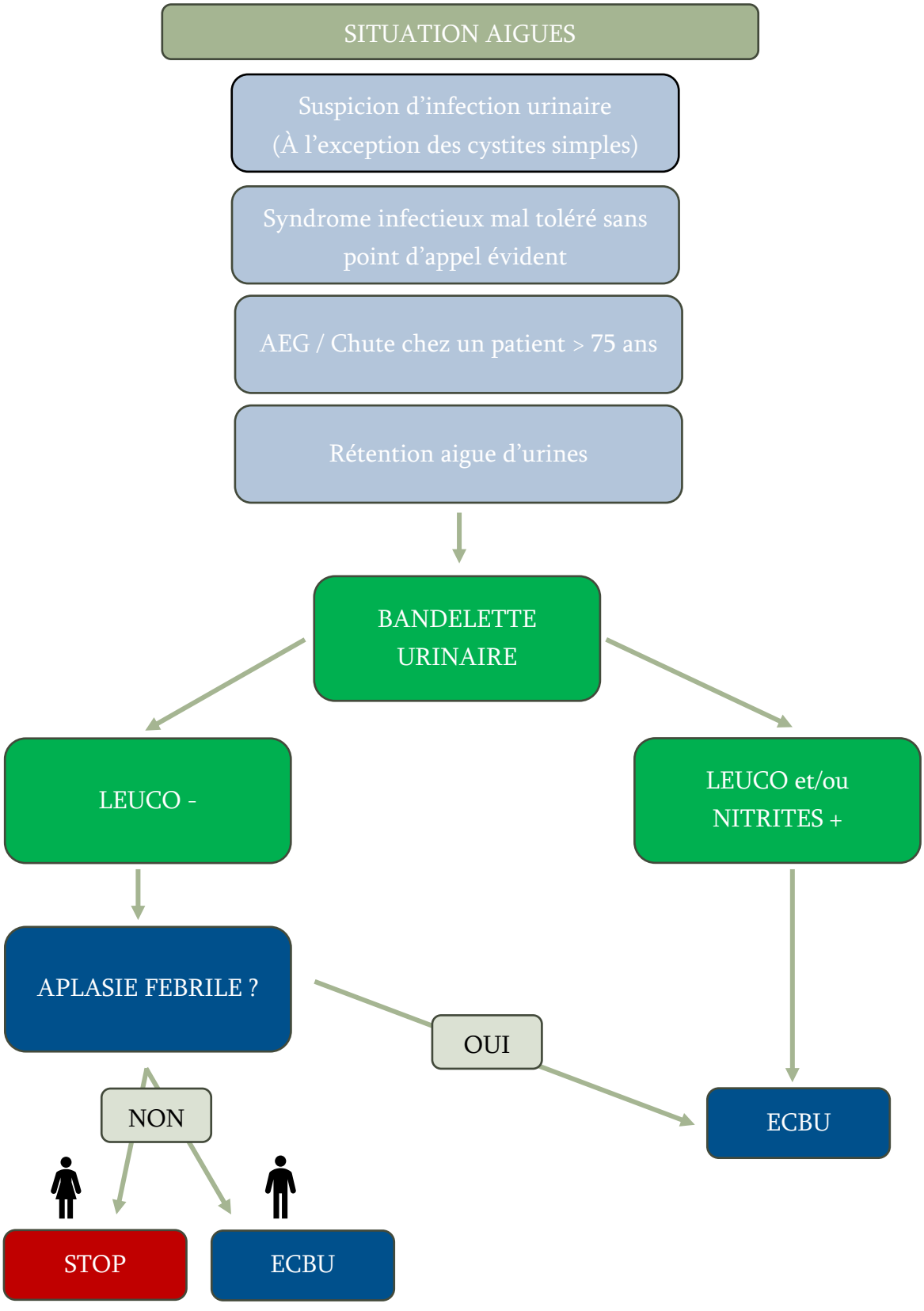
Gommes	Mâcher lentement la gomme 5 ou 6 fois, puis la garder contre la joue environ 2 minutes, pour que la nicotine se libère et soit absorbée par la muqueuse buccale. Ensuite remâcher lentement la gomme. On utilise une gomme dès que l'envie commence à réapparaître : on gère «au coup par coup» ses envies de fumer au cours de la journée. Le nombre de gommes doit être suffisant pour gérer convenablement les besoins.	*En général, on utilise de 8 à 12 gommes par jour les premiers jours et on diminue ensuite les doses graduellement. Il ne faut jamais en prendre plus de 25 dans une seule journée pour les gommes à faible dosage ou 15 par jour pour les gommes de fort dosage. Si le patient consomme plus que la dose maximale, revoir le traitement de substitution (exemple augmenter les patchs.) Les gommes sont déconseillées en cas d'appareil dentaire.*
Pastilles	Laisser se dissoudre la pastille sous la langue, ou la sucer selon les formes, sans la croquer ni l'avaler. En deux ou trois minutes, l'effet se fait sentir et l'envie de fumer s'estompe. Le nombre de comprimés à utiliser par jour varie en fonction du degré de dépendance.	*Il se situe le plus souvent entre 8 et 12 les premiers jours et diminue ensuite graduellement. Il ne faut jamais en prendre plus de 25 dans une seule journée pour les comprimés à faible dosage ou 15 par jour pour les comprimés de fort dosage. Si le patient consomme plus que la dose maximale, revoir le traitement de substitution (exemple augmenter les patchs.)*
Inhalateur	L'inhaleur se présente sous la forme d'un embout en plastique contenant une cartouche de nicotine que l'on peut utiliser lors d'une envie de cigarette. A chaque utilisation, on aspire plusieurs fois par l'embout : on aspire alors de l'air chargé de microgouttelettes de nicotine (changer la cartouche toutes les 5 ou 6 utilisations environ et au minimum toutes les 12h).	*En début de sevrage, on peut utiliser plusieurs cartouches par jour. Ce nombre va en diminuant au fil du temps. Maximum : 12 cartouches par jour.* *Si le patient consomme plus que la dose maximale, revoir le traitement de substitution (exemple augmenter les patchs.)*

4. Spécialités disponibles à Saint Joseph



La mise en application implique des droits de prescription spécifiques dans DxCare.
Un profil spécifique au service des urgences a été mis en place.
Seules les infirmières formées au protocole peuvent l'exécuter.

INDICATION A LA REALISATION D'UN ECBU AUX URGENCES



2. LABORATOIRE

PROCEDURE ETIQUETTAGE DES SACHETS DE LABORATOIRE

L'envoi des bilans sanguins s'effectuent grâce à un pneumatique.

Dans un premier temps vous devez choisir le sachet en fonction du laboratoire voulu :

- **Sachet vert :** Biochimie normal (NGS, IONO, HEMOSTASE)
- Sachet transparent : Dépôt de sang (Détermination sanguine)
- **Sachet jaune :** Bactériologie (Hémoculture, ECBU, ...)
- **Sachet orange :** Bactériologie urgente ou en période de garde (après 18h la semaine et le weekend et jours fériés).
- **Sachet rouge :** Biochimie urgente = urgence vitale (résultat attendu rapidement).

Après avoir mis les tubes dans le sachet, vous devez coller une étiquette du patient sur le sachet et noter le nombre de tubes présent dans le sachet.

Lorsque vous mettez vos tubes dans le sachet vérifier que ceux-ci soient tous étiquetés. Pour rappel, l'étiquetage des tubes se fait au lit du patient après avoir vérifié l'identité de celui-ci.

Par la suite, vous mettez votre sachet dans une poche « kangourou », puis vous le placez dans le pneumatique. Attention vous devez au préalable avoir ouvert les encoches de la poche « kangourou » pour que celle-ci puisse partir correctement.

Conseil :

Vous ne pouvez pas envoyer des hémocultures avec d'autres tubes (risque de bourrage important du pneumatique). Par conséquent les paires d'hémocultures (soit 4 hémocultures) s'envois seule.

PROCEDURE ENVOIE DE GAZ DU SANG

Les gaz du sang doivent être envoyer au laboratoire dans un pochette de couleur verte ou rouge.

En effet, ce prélèvement devant être analysé rapidement, il peut être envoyé dans une pochette de couleur rouge signifiant « urgence vitale ».

Les gaz du sang doivent être envoyé seule dans la pochette, aucun autre tube de prélèvement ne doit être présent.

Conseil :

Penser à bien noter l'heure de prélèvement sur l'étiquette, en effet, entre l'impression des étiquettes et le prélèvement il peut y avoir un certain délai. Par conséquent avec un stylo vous rayez la date mise à l'impression et vous noter la vraie heure du prélèvement.

PROCEDURE GROUPE SANGUIN

Pour chaque prélèvement de détermination sanguine, vous ne pouvez utiliser les prescriptions connectées, par conséquent, vous devez remplir un bon de laboratoire que vous joindrais à votre tube dans le sachet transparent.

Pour rappel, il est légalement et formellement interdit de prélever les deux déterminations en même temps. En effet, les deux déterminations doivent être prélever :

- 2 prélèvements différents.
- 2 temps différents (5 min d'intervalle minimum).
- 2 soignants si possible

Il est formellement interdit de noter le nom d'un autre soignant sur le bon si ce dernier n'est pas le préleveur.

Avant de prélever votre patient, vous pouvez rechercher dans le dossier si celui-ci est déjà connu de l'hôpital et par conséquent a déjà une carte de groupe, plusieurs possibilités :

- En regardant dans la synthèse > dossier transfusionnelle >
- En regardant dans les résultats
- En appelant le dépôt de sang DECT : 34.56 et en donnant l'IPP du patient.

Une fois le prélèvement effectuer vous devez remplir le bon de laboratoire de cette manière :

BON A METTRE

Envoi des 2 déterminations dans 2 sachets différends avec chacun un bon de laboratoire.

PROCEDURE ALERTE THROMBOLYSE

Nous recevons de nombreuse suspicion d'AVC aux urgences, nous les appelons des « alertes thrombolyses ». En cas de prise en charge d'une alerte thrombolyse, un bilan sanguin sera prélevé et analysé par le laboratoire.

Pour l'envoie du bilan sanguin, demander au médecin si nous considérons le patient en tant qu'alerte thrombolyse ou non, dans ce cas, 2 solutions :

→ NON = prise en charge habituelle du patient, le bilan sang sera donc identifier avec des étiquettes de prescription connecté et il sera acheminé au laboratoire via le pneumatique sans bon.

→ OUI = procédure alerte thrombolyse (voir ci-dessous).

Procédure :

Un bon préremplis est disponible dans la SAUV ou dans le meuble dans le poste de soins (« alerte thrombolyse »).

Vous devez prélever :

- Une NFS (tube mauve).
- Un Ionogramme (tube vert).
- Une hémostase (tube bleu).

Sur le bon, vous devez coller une étiquette du patient et remplir les lignes suivantes :

Vous identifiez les tubes avec des étiquettes patients et uniquement ces dernières (pas d'étiquette de prescription connectée).

Vous mettez les tubes et le bon dans un sachet rouge et vous allez les déposer en main propre au laboratoire (si vous ne pouvez pas y aller, demander à un collègue IDE/AS ou à un membre de l'encadrement).

IL EST INTERDIT D'ENVOYER LE BILAN VIA LE PNEUMATIQUE

PHOTO DU BON

PROCEDURE D'ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS D'UNE PONCTION LOMBAIRE

Vous allez réaliser une ponction lombaire, en collaboration avec le médecin.

Comme pour chaque prélèvement, vous aurez besoin d'un certain nombre de tubes.

- Les tubes qui servent à recueillir le LCR sont les tubes coniques à bouchon vert gradué.

Vous trouverez tous le matériel nécessaire à la réalisation de cette ponction dans le chariot de kit. Cependant, pour l'acheminement des tubes de prélèvement au laboratoire, quelques règles doivent être respectées :

- Prévenir le laboratoire avant l'envoi des tubes
- Identification des tubes par étiquette-patient et vérification orale.
- 1 Tube pour la biochimie analyse standard.
- 1 Tube pour la bactériologie standard + Cytologie
- Le reste des tubes est conservés en sérothèque au laboratoire.

Une fois la P.L réalisée et les tubes remplis de LCR, les tubes doivent être placé dans un sachet prévu à cet effet. Puis effectuer le transport au laboratoire. Le transport des tubes se fait à températures ambiante, sans délai en main propre (IDE, AS et ou Coursier).

Aucun prélèvement ne doit être envoyé par les pneumatiques.

3. PHARMACIE

VERIFICATION DES STUPEFIANTS

Aux urgences et aux lits d'urgences, des médicaments dits stupéfiants sont présent dans des coffres. Ces derniers font l'objet d'une traçabilité particulière que nous vous expliquons ci-dessus.

Vérification quotidienne :

La vérification est réalisée par un membre de chaque équipe, **un IDE de jour et un IDE de nuit obligatoirement**.

Toutes les zones doivent être vérifié deux fois par jour, en début et fin de service.

→ IOA 1 & 2

Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

SERVICE DES URGENCES

DOTATION GLOBALE IOA 1 et IOA 2			Le contrôle se fait obligatoirement avec deux IDE Jour ET Nuit							
Date et heure	Désignation des stupéfiants Dosage	Dotation	JOUR 7h30		Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires	Nuit 20h00		Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires
			Pleins	vides			Pleins	vides		
Lundi	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
Mardi	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
Mercredi	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
Jeudi	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
Vendredi	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
Samedi	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
Dimanche	Oxynorm oro 5 mg en cp	45								
DOTATION GLOBALE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE PAR LE CADRE INFIRMIER							Date, Nom et signature du Cadre			
Concordance entre la dotation et le nombre de contenants (vides et pleins)										
Contrôle journalier tracé par les IDE										

→ IOA 3

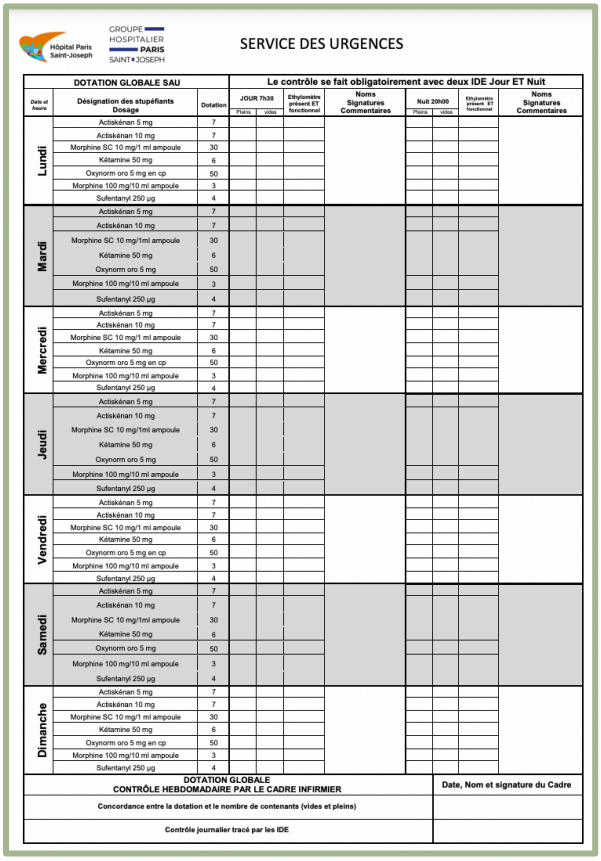
Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

SERVICE DES URGENCES

DOTATION GLOBALE IOA 3			Le contrôle se fait obligatoirement avec deux IDE Jour ET Nuit							
Date et heure	Désignation des stupéfiants Dosage	Dotation	JOUR 7h30 Pleins	JOUR 7h30 vides	Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires	Nuit 20h00 Pleins	Nuit 20h00 vides	Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires
Lundi	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Mardi	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Mercredi	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Jeudi	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Vendredi	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Samedi	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Dimanche	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								

DOTATION GLOBALE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE PAR LE CADRE INFIRMIER	Date, Nom et signature du Cadre
Concordance entre la dotation et le nombre de contenants (vides et pleins)	
Contrôle journalier tracé par les IDE	

→ Zone 2A



Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH

SERVICE DES URGENCES

DOTATION GLOBALE SAU			Le contrôle se fait obligatoirement avec deux IDE Jour ET Nuit							
Date et heure	Désignation des stupéfiants Dosage	Dotation	JOUR 7h30 Pleins	JOUR 7h30 vides	Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires	Nuit 20h00 Pleins	Nuit 20h00 vides	Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires
Lundi	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								
Mardi	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								
Mercredi	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								
Jeudi	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								
Vendredi	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								
Samedi	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								
Dimanche	Actiskénan 5 mg	7								
	Actiskénan 10 mg	7								
	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	30								
	Kétamine 50 mg	6								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	50								
	Morphine 100 mg/10 ml ampoule	3								
	Sufentanyl 250 µg	4								

DOTATION GLOBALE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE PAR LE CADRE INFIRMIER	Date, Nom et signature du Cadre
Concordance entre la dotation et le nombre de contenants (vides et pleins)	
Contrôle journalier tracé par les IDE	

→ Zone 2B

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

SERVICE DES URGENCES

DOTATION GLOBALE SAU			Le contrôle se fait obligatoirement avec deux IDE Jour ET Nuit							
Date et heure	Désignation des stupéfiants Dosage	Dotation	JOUR 7h30 Pleins	JOUR 7h30 vides	Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires	Nuit 20h00 Pleins	Nuit 20h00 vides	Ethylomètre présent ET fonctionnel	Noms Signatures Commentaires
Lundi	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Mardi	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg	10								
Mercredi	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Jeudi	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg	10								
Vendredi	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
Samedi	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg	10								
Dimanche	Morphine SC 10 mg/1 ml ampoule	10								
	Oxynorm oro 5 mg en cp	10								
DOTATION GLOBALE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE PAR LE CADRE INFIRMIER										Date, Nom et signature du Cadre
Concordance entre la dotation et le nombre de contenants (vides et pleins)										
Contrôle journalier tracé par les IDE										

→ Lits d'urgences

HÔPITAUX Paris Saint Joseph Marie Lannelongue

SERVICE DES URGENCES – Lits d'Urgences (UF : 6017)

Semaine du …./…./20…. Au …./…./20….

EDOTATION GLOBALE LITS D'URGENCES NIV G			Le contrôle se fait obligatoirement avec deux IDE Jour ET Nuit					
Date et Heure	Désignation des stupéfiants - Dosage	Dotation	JOUR 7h30 Pleins	JOUR 7h30 Vides	Noms Signatures Commentaires	NUIT 20h00 Pleins	NUIT 20h00 vides	Noms Signatures Commentaires
Lundi	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
Mardi	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
Mercredi	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
Jeudi	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
Vendredi	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
Samedi	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
Dimanche	Actiskénan 5 mg	15						
	Actiskénan 10 mg	30						
	Morphine SC 10 mg/1ml ampoule	20						
	Oxycontin 10 mg	5						
	Oxynorm oro 5 mg	7						
	Skénan LP 10 mg gel	7						
	Skénan LP 30 mg gel	7						
DOTATION GLOBALE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE PAR LE CADRE INFIRMIER								Date, Nom et signature du cadre
Concordance entre la dotation et le nombre de contenants (vides et pleins)								
Contrôle journalier tracé par les IDE								

TRAÇABILITE D'ADMINISTRATION DES STUPEFIANTS

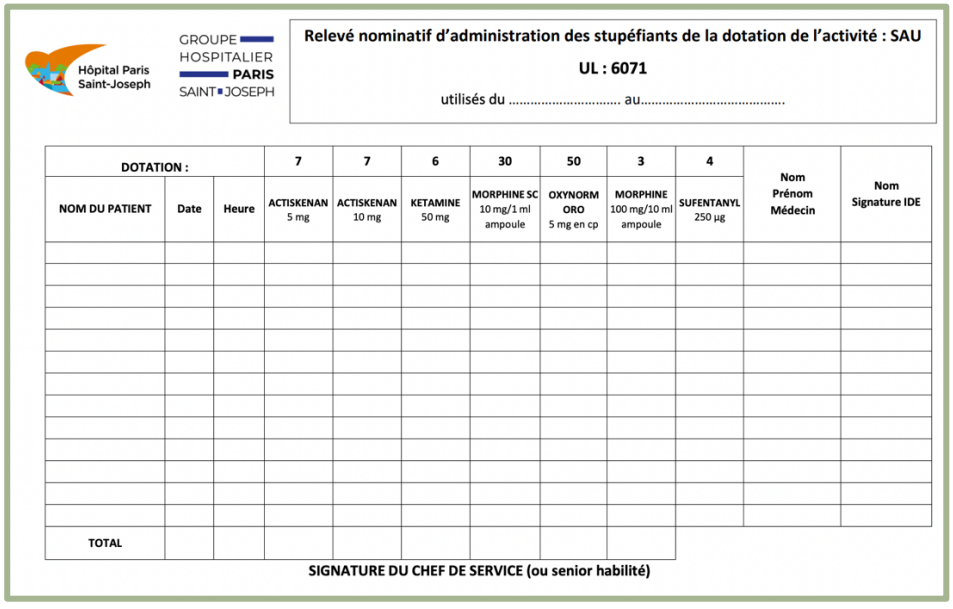
A chaque fois que vous devez prendre un stupéfiant, il vous faudra vous munir d'une étiquette du patient et suivre ses étapes :

1) Prendre le stupéfiant voulu.
2) Tracer la prise du stupéfiant sur la feuille de traçabilité dans le classeur.
3) Noter le nom du patient, la date, l'heure et la quantité prise en toutes lettres *(« Une ampoule de dix milligrammes de Morphine »)*, le nom du médecin prescripteur et votre nom.
4) Coller l'étiquette du patient sur le blister/ampoule.

Les stupéfiants présents dans les coffres sont les suivants :

Urgences		**Lits d'urgences**
Zone 2 A	Zone 2 B	
- Actiskenan 5mg - Actiskenan 10mg - Morphine 10mg/1mL - Kétamine 50mg - OxynormOro 5mg - Morphine 100mg/10mL - Sufentanyl 250µg	- Morphine 10mg/10mL - OxynormOro 5mg	- Actiskenan 5mg - Actiskenan 10mg - Morphine 10mg/1mL - Oxycontin 10mg - OxynormOro 5mg - Skénan LP 10mg - Skénan LP 30mg

→ **Relevé nominatif d'administration des stupéfiants :**



Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Relevé nominatif d'administration des stupéfiants de la dotation de l'activité : SAU

UL : 6071

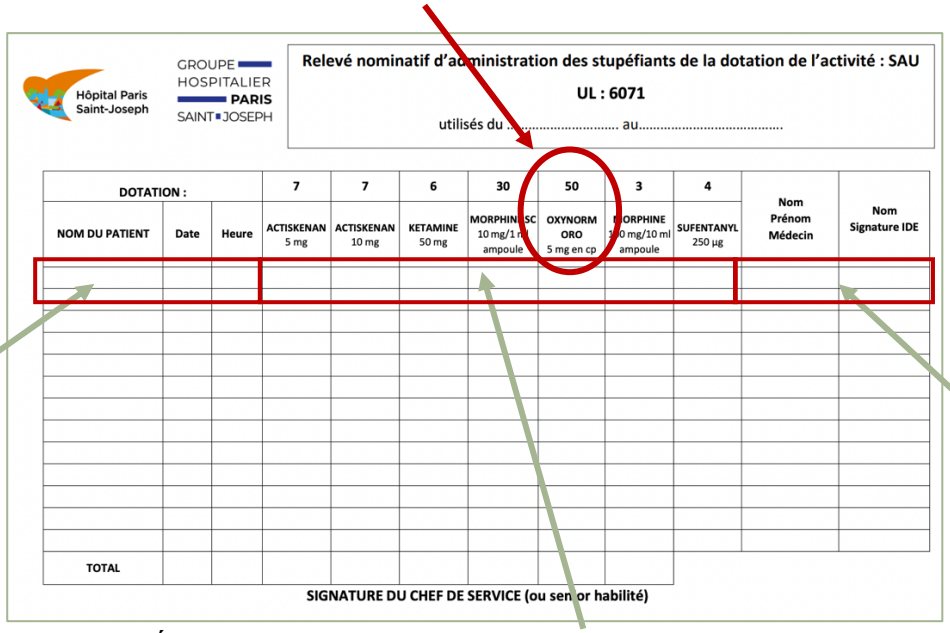
utilisés du ..... au.....

DOTATION :			7	7	6	30	50	3	4		
NOM DU PATIENT	Date	Heure	ACTISKENAN 5 mg	ACTISKENAN 10 mg	KETAMINE 50 mg	MORPHINE SC 10 mg/1 ml ampoule	OXYNORM ORO 5 mg en cp	MORPHINE 100 mg/10 ml ampoule	SUFENTANYL 250 µg	Nom Prénom Médecin	Nom Signature IDE
TOTAL											

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE (ou senior habilité)

Lorsque vous prenez un stupéfiant, vous devez donc :

(Si c'est une nouvelle feuille, entouré la catégorie de stupéfiant)



Hôpital Paris Saint-Joseph — GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Relevé nominatif d'administration des stupéfiants de la dotation de l'activité : SAU

UL : 6071

utilisés du ..... au.....

DOTATION :			7	7	6	30	50	3	4		
NOM DU PATIENT	Date	Heure	ACTISKENAN 5 mg	ACTISKENAN 10 mg	KETAMINE 50 mg	MORPHINE SC 10 mg/1 ml ampoule	OXYNORM ORO 5 mg en cp	MORPHINE 10 mg/10 ml ampoule	SUFENTANYL 250 µg	Nom Prénom Médecin	Nom Signature IDE
TOTAL											

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE (ou sen or habilité)

Écrire **lisiblement** le nom du patient, la date et l'heure de l'administration.

Écrire **lisiblement** le nom du médecin prescripteur et le nom de l'IDE

Écrire en toutes lettres le nombre de comprimés, la molécule et la posologie, exemple : « Un comprimé de cinq milligrammes d'OxynormOro ».

→ Cas particulier des IOA :

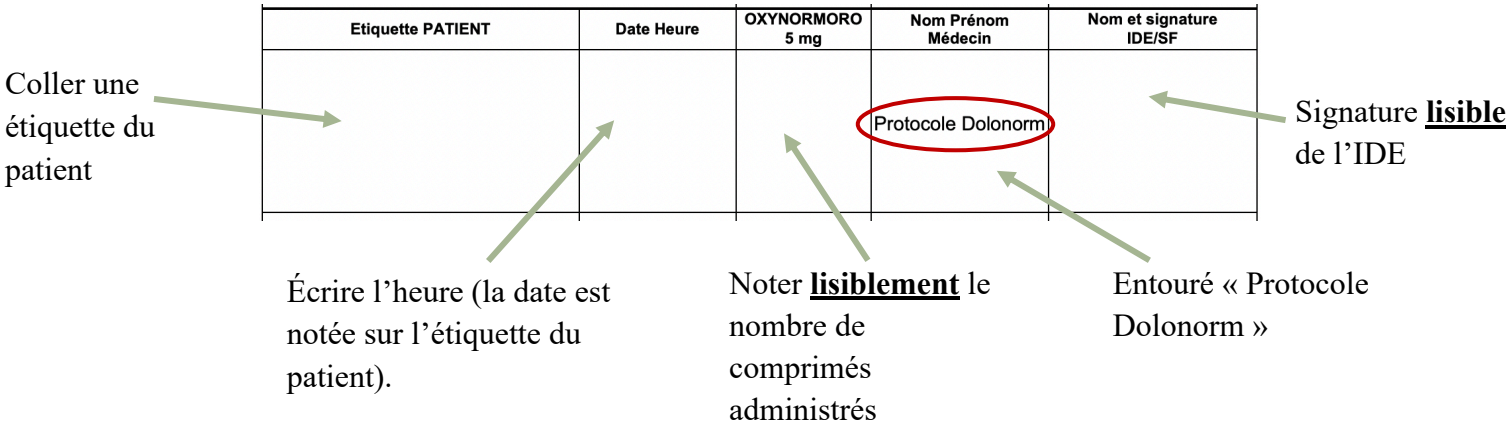
Chaque IOA possède un coffre à stupéfiant, on y retrouve seulement des OxynormOro 5mg.

L'IOA va coller une étiquette du patient sur la feuille de traçabilité et sur le blister.

Il note l'heure (la date est présente sur l'étiquette du patient), ensuite il note le nombre de comprimés administré (1 ou 2), il entoure la mention « protocole dolonorm » et il signe.

Etiquette PATIENT	Date Heure	OXYNORMORO 5 mg	Nom Prénom Médecin	Nom et signature IDE/SF
			Protocole Dolonorm	

Traçabilité :



PROTOCOLE TITRATION DE MORPHINE

Ce protocole a pour objectif de soulager la douleur aiguë induite par certaines pathologies, certains actes (examen, chirurgie, ...).

→ Indications :

Toute douleur spontanée ou provoquée justifiant l'utilisation de la morphine.

Précautions d'emploi :

- Insuffisance respiratoire, asthme
- Insuffisance rénale ou hépatique grave
- Traumatisme crânien, intervention neurochirurgicale, épilepsie
- Enfants, personnes âgées
- Association avec les IMAO

→ Effets indésirables

- Somnolence, hallucinations
- Dépression respiratoire
- Nausées, vomissements, rétention urinaire
- Prurit
- Hypotension
- Augmentation de la pression intracrânienne
- Myosis intense

→ Signes de surdosage

Dépression respiratoire, somnolence, hypotension

→ Antidote

Les antagonistes morphiniques (Naloxone, Nalorphine, Naltrexone) sont des antidotes spécifiques du surdosage par les morphinomimétiques.

→ Déroulement du soin :

1) **Évaluation de la douleur** (EN, EVS, Algoplus®).
2) **Prescription médicale :**
   - → Sur DxCare d'une pose de voie veineuse périphérique, de la « titration de morphine » et de la « surveillance titration de morphine ». Prévoir des co-analgésiques associés.

3) **Préparation de la morphine :**
   - → Seringue de 10mL

- 1 ampoule de 10mL de NaCl 0,9%.
- 1 ampoule de Morphine 10mg/1mL.
- Prélever l'ampoule de morphine, puis 9mL de NaCl 0,9%.
- Vous obtenez une solution de 10mg de morphine dans 10mL, soit une concentration de 1mg pour 1mL.

4) **Préparation du patient :**
   Expliquer au patient l'intérêt de l'administration de la morphine dans sa situation, les modalités d'administration et les effets secondaires potentiels.
5) **Préparation du matériel en cas de surdosage :**
   - 1 ampoule de Naloxone 0,4mg.
   - 1 ampoule de NaCl 0,9%.
   - Un masque haute concentration.
   - Une prise murale à O2 (ou une bouteille).
   - Une aspiration murale en état de fonctionnement et sondes d'aspiration.
6) **Titration morphine.**
7) **Surveillance à chaque bolus de l'intensité de la douleur et des échelles de sédation et respiration.**
8) **Assurer la traçabilité numérique dans DxCare**
9) **Prescription médicale d'analgésie en relais** de la titration (relais per-os, relais par PCA...).

La dose des bolus sera déterminée en fonction de l'âge et du poids du patient.
Cette dose sera répétée toutes les 5 minutes tant que :
- La douleur n'est pas soulagée (EN ≥ 3, EVS ≥ 2, Algoplus ≥ 2)
- Et que le traitement est bien toléré (échelle de sédation < 2, échelle respiratoire < 2).

Les échelles en détails :

Échelle de Sédation (EDS)

0 : Pas de sédation, patient bien éveillé
1 : Patient somnolent, mais stimulable verbalement
2 : Patient somnolent, mais stimulable tactilement
3 : Patient non réveillable, comateux

Échelle Respiratoire (ER)

0 : Respiration régulière et FR>10
1 : Ronflement et FR>10
2 : Respiration irrégulière, obstruction, tirage
3 : Pauses, apnées

En cas de surdosage, les antagonistes morphiniques (Naloxone, Nalorphine, Naltrexone) sont des antidotes spécifiques du surdosage par les morphinomimétiques.

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA NALOXONE POUR ANTAGONISATION DES OPIOÏDES EN CAS DE SURDOSAGE

→ Indications :

Dépression respiratoire secondaire à un surdosage en morphinomimétiques.

Bradypnée avec FR < 12/min. Seuil d'alerte S2 S3 sur l'échelle de la sédation.

→ Préparation de la Naloxone :

Diluer une ampoule de 0,4mg (400µg) /1ml de Naloxone dans 9 ml de sérum physiologique soit 0,04mg (40µg) /ml.

→ Administration de la Naloxone :

L'administration se fait par titration intraveineuse (voie sous cutanée ou IM possible mais absorption moins efficace) :

- Injection initiale de 2ml
- Puis, injection ml par ml toutes les 3 minutes, jusqu'à restauration d'une fréquence respiratoire.

Attention, en l'absence d'effet clinique après injection de 5 mg, le diagnostic doit être remis en cause.

- Entretien par Naloxone :
  - Un entretien par perfusion continue à la seringue électrique de Naloxone doit être discuté car une remorphinisation secondaire est prévisible ; il sera adapté au contexte clinique de chaque patient (morphiniques d'action prolongée, intoxications massives à l'héroïne).
  - Diluer 5 ampoules de 0,4mg (400µg) /1ml de Naloxone dans 45 ml de sérum physiologique soit 0,04mg (40µg) /ml.
  - Commencer par la ½ dose nécessaire pour lever la bradypnée (ex, si 10 ml ont été nécessaires, commencer par un débit de 5ml/h soit 0.2mg/h), puis adapter les doses selon la fréquence respiratoire.
  - Transfert en USC en cas de nécessité d'entretien par Naloxone

→ Score de sédation simplifié :

- S0 = éveillé
- S1 = somnolent par intermittence, facilement réveillable
- S2 = somnolent la plupart du temps, réveillable par stimulation verbale
- S3 = somnolent la plupart du temps, réveillable par stimulation tactile

CONTROLE ET ENTRETIEN ES REFRIGERATEURS PHARMACEUTIQUES

Le réfrigérateur des salles de soins et exclusivement réservé au stockage des médicaments et des packs de refroidissements. Aucun autre produit n'y est autorisé.

La péremption des médicaments est à vérifier une fois par mois.

La température du réfrigérateur doit être comprise entre 2°C et 8°C. Si celle-ci est incorrecte, réajuster au moyen du thermostat et mettre en place la procédure « conduite à tenir en cas de température incorrecte et/ou de panne du réfrigérateur ».

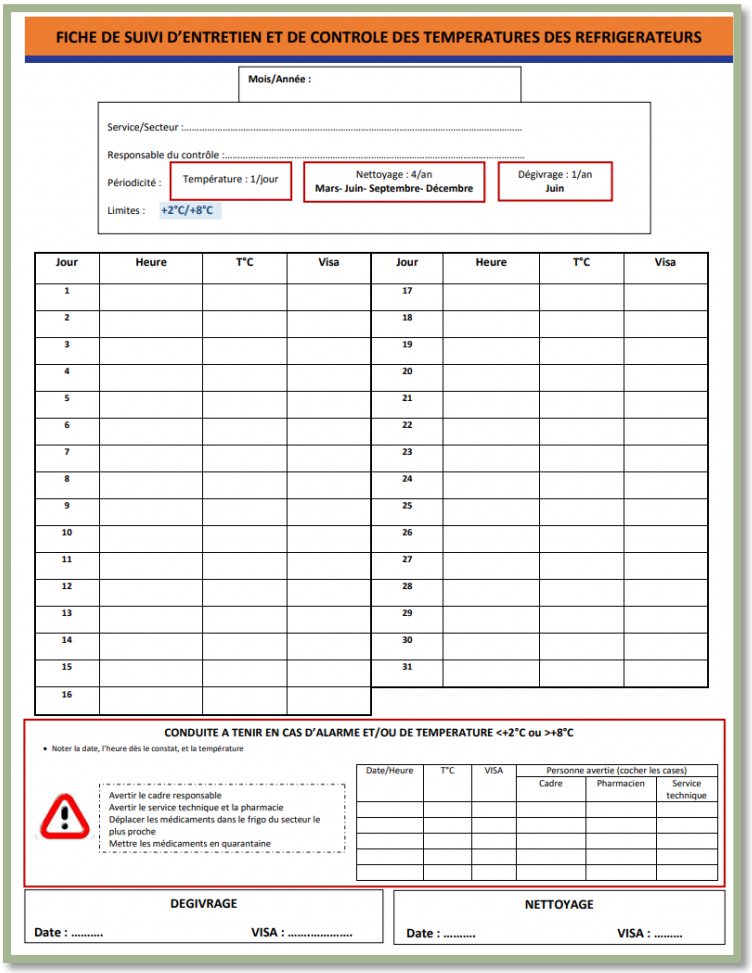
Chaque réfrigérateur est muni d'un système en ligne qui effectue un relevé centralisé par un logiciel dédié « SIRIUS Stockage ».

Ne rien poser sur les aérations des réfrigérateurs pour éviter la surchauffe.

- Contrôle :

Le contrôle de la température du réfrigérateur est réalisé une fois par jour minimum.

Remplir la fiche de surveillance afficher sur le réfrigérateur.



FICHE DE SUIVI D'ENTRETIEN ET DE CONTROLE DES TEMPERATURES DES REFRIGERATEURS

Mois/Année :

Service/Secteur :.....

Responsable du contrôle :.....

Périodicité : Température : 1/jour | Nettoyage : 4/an **Mars- Juin- Septembre- Décembre** | Dégivrage : 1/an **Juin**

Limites : +2°C/+8°C

Jour	Heure	T°C	Visa	Jour	Heure	T°C	Visa
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16							

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALARME ET/OU DE TEMPERATURE <+2°C ou >+8°C

- Noter la date, l'heure dès le constat, et la température

Avertir le cadre responsable
Avertir le service technique et la pharmacie
Déplacer les médicaments dans le frigo du secteur le plus proche
Mettre les médicaments en quarantaine

Date/Heure	T°C	VISA	Personne avertie (cocher les cases)		
			Cadre	Pharmacien	Service technique

DEGIVRAGE

Date : ..... **VISA :** .....

NETTOYAGE

Date : ..... **VISA :** .....

- Nettoyage :

Fréquence : quatre fois/an (mars, juin, septembre et décembre) par l'infirmier (e) ou son aide-soignant (e) délégué (e).

1. Sortir les médicaments du réfrigérateur. Si les médicaments risquent à être exposés à une température qui dépasse 8°C durant plus de 15 minutes, assurer le respect de la chaîne du froid (transfert dans un autre réfrigérateur ou poche isotherme).
2. Nettoyer les différents accessoires (clayettes, bacs, boîtes à médicaments…), les parois intérieures, le compartiment conservateur et le joint de porte avec une lingette imprégnée de détergeant désinfectant.
3. Rincer avec une lingette imbibée d'eau, puis sécher les surfaces avec une lingette.
4. Remettre les accessoires en place.
5. Remettre les médicaments dans le réfrigérateur.
6. Remplir la fiche de traçabilité affichée sur le réfrigérateur.
7. Tout pack de refroidissement utilisé pour un patient est nettoyé et désinfecté avec une lingette imprégnée de détergeant-désinfectant avant réintroduction dans le réfrigérateur.

Le réfrigérateur doit être dégivrer une fois par an (au mois de juin).

CONDUITE A TENIR EN CAS DE D'ALARME ET/OU DE TEMPERATURE <+2°C OU >+8°C.

Si lors de votre surveillance de la température, vous constatez que celle-ci n'est pas comprise dans la norme, vous devez suivre ces étapes :

1. Noter la date, l'heure du constat et la température.
2. Prévenir le cadre responsable (jour : **80.21** / **76.57** ; nuit : **67.12**).
3. Avertir le service technique et la pharmacie (**77.05**)
4. Déplacer les médicaments dans le frigo du secteur le plus proche (lits d'urgences).
5. Mettre les médicaments en quarantaine (dans un sachet, noter « médicaments en quarantaine ! Ne pas utiliser »).
6. Remplir le tableau en bas de la « fiche de suivi d'entretien et de contrôle des températures des réfrigérateurs » dans le carré rouge.

Date/Heure	T°C	VISA	Personne avertie (cocher les cases)		
			Cadre	Pharmacien	Service technique

7. Dans un second temps, voici la conduite à tenir concernant les médicaments :

Libellé produit	Durée max de rupture de la chaîne du froid	Durée de stabilité à température ambiante
Abasaglar - Stylo	Pas de remise au réfrigérateur possible	28 jours
Adenosine (STRIADYNE®)	Pas de remise au réfrigérateur possible	28 jours
Atracurium (TRACRIUM®	Pas de remise au réfrigérateur possible	28 jours
Cisatracurium (NIMBEX®)	Pas de remise au réfrigérateur possible	24 heures
Glucagon (GLUCAGEN®	72h	12 mois
Humalog 100U/mL	Pas de remise au réfrigérateur possible	28 jours
Humalog KWIKPEN - Stylo	Pas de remise au réfrigérateur possible	28 jours
Isoprenaline (ISUPREL®)	Pas de remise au réfrigérateur possible	12 semaines (à l'abri de la lumière)

Lidocaine (XYLOCAINE®) ADRENALINE	Pas de remise au réfrigérateur possible	48 heures
Octreotide (SANDOSTATINE®)	Pas de remise au réfrigérateur possible	24 heures
Suxamethonium (CELOCURINE®)	48 heures	8 semaines
Trimebutine (DEBRIDAT®)	/	/
Vaccin anti grippe	Pas de remise au réfrigérateur possible	12 heures
Vaccin REVAXIS	48 heures	/

8. Recommander en urgences les médicaments en respectant la dotation.

PROCEDURE DES TRAÇABILITES SPECIFIQUES

Certains médicaments ont une traçabilité spécifique.

OCTAPLEX

PPSB (Prothrombine Proconvertine (facteur) Stuart (facteur antihémophilique) B.

C'est un médicament dérivé du sang contenant quatre facteurs de la coagulation (prothrombine (II) ; proconvertine (VII), facteur Stuart (X), et facteur antihémophilique B (IX).

Il est le plus souvent indiqué comme traitement des saignements et prophylaxie péri opératoire des accidents hémorragiques lors d'un déficit acquis en facteurs de coagulation du complexe prothrombique, tel que le déficit induit par un traitement par anti-vitamines K, ou en cas de surdosage en anti-vitamines K, quand une correction urgente du déficit est requise.

Préparation :

1) Dissoudre le lyophilisat avec les 20mL de solvant.
2) Ramener la quantité souhaitée dans une ou plusieurs seringues de 50mL.
3) La concentration finale doit-être de 500UI/20mL soit 25UI/mL.
4) Administration à la vitesse de 1mL/min pour la première seringue puis 2-3mL/min pour les seringues suivantes.

- Puis coller une étiquette du flacon sur la feuille de traçabilité.
- Coller une étiquette du patient
- Note la date et l'heure d'administration
- A la fin, faxer la feuille à la pharmacie et scanner la dans le dossier du patient.

	ORDONNANCE **Dénomination Commune Internationale :** **FACTEURS X, II, VII, IX DE COAGULATION HUMAINS** **Nom commercial :** **OCTAPLEX®**	PECM-ORG-ENR-012ECM-ORG-ENR-012a Version : 05 MAJ : 18/07/2019 Page : 2 / 2

Cadre réservé à l'administration IDE	
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**
Médicament administré **☐ 1 flacon de OCTAPLEX 500 UI/ 20 ML** **Date Nom Signature**	**Coller l'étiquette du conditionnement primaire**

Envoyer cette fiche à la Pharmacie pour la traçabilité => Une copie sera retournée pour le dossier-patient

Circuit OCTAPLEX®

Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)

Dispensation :

- Prescription par un médecin senior
- Sur ordonnance spécifique disponible sur Ennov (ou sur DxCare en cochant l'indication) : HPSJ => Pharmacie => Ordonnances
- **Indication obligatoire => si indication hors AMM justification dossier patient**
- **Validation Pharmaceutique de l'ordonnance**

- **Dispensation par l'Interne ou le Pharmacien**
- Noter le(s) numéro(s) de lot(s) sur l'ordonnance + sortie Pharma®
- Donner une feuille de traçabilité d'administration
- Ranger l'ordonnance dans le classeur T2A/MDS

Service de soin

Administration au patient et traçabilité :

- Remplir le bordereau de traçabilité d'administration papier
- **Validation** de l'administration dans DxCare®
- **Faxer** le bordereau à la pharmacie (3915) et conserver la traçabilité dans le **dossier patient** (numérisation DxCare®)

PUI

La Pharmacie assure la traçabilité d'administration :
- ✓ Dès le retour de traçabilité par fax
- ✓ Sur le(s) bon(s) lot(s) dispensé(s)

Posologie (à titre indicatif) :

➢ Si pas d'INR disponible => 25 UI/kg (50 UI/kg si utilisation hors-AMM dans surdosage en AOD dans hémorragies cérébrales[1]

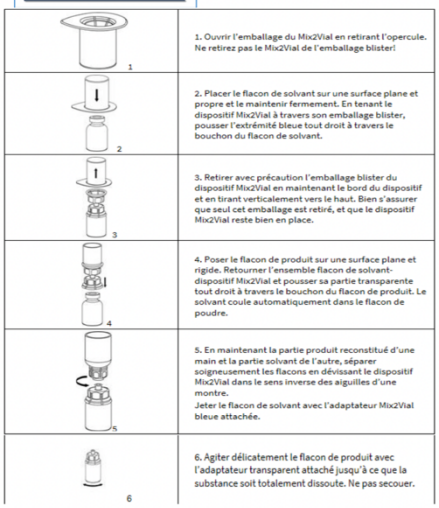
- **Posologie recommandée pour un INR Cible ≤ 1,2**

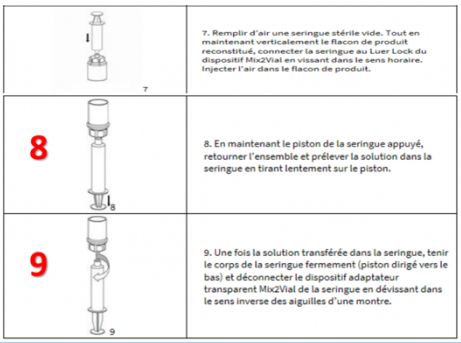
INR initial	2 – 2,5	2,5 - 3	3 – 3,5	> 3,5
Dose approximative* (ml/kg)	0,9 – 1,3	1,3 – 1,6	1,6 – 1,9	> 1,9
Dose approximative* (UI/kg)	22,5 – 32,5	32,5 - 40	40 – 47,5	> 47,5

* Une dose unique ne doit pas dépasser 3000 UI (120 ml d' Octaplex®).

Modalités d'administration de l'OCTAPLEX® (MDS)

Reconstitution :





Administration :

- ✓ Prendre le pouls avant et pdt la perfusion (➔ si ↗↗, diminution débit ou arrêt)
- ✓ Voie **IV**
- ✓ **Débit** 1 mL/mn **puis** augmenter progressivement jusqu'à max 3 mL/mn
- ✓ Pas de mélange à d'autres médicaments, solution **limpide** ou **légèrement opalescente**
- ✓ A utiliser **immédiatement** mais stabilité après reconstitution = **8h à température ambiante**

Traçabilité : faxer la traçabilité d'administration à la pharmacie (3915) et la conserver dans le dossier patient

Pharmacie à Usage Intérieur (Secteur Médicaments) Interne (7648) ou IDG (7705) / Pharmacien (7826)

ACTILYSE

- Prendre les flacons correspondant au poids
- Préparer un bolus (1/10 de la dose totale)
- Prendre les flacons en fonction (50 ou 10)
- Noter sur la feuille de traçabilité le nombre de flacons pris pour chaque quantité
- Faxer la feuille à la pharmacie puis scanner dans le dossier patient

Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph

PHARMACIE

Service Urgences

UF 6071

Dotation : 4 Actilyse 10mg et 1 Actilyse 50mg

A faxer à la pharmacie : 3915

Etiquette patient :

THROMBOLYSE effectuée le :..... /...../ .....

Dose ACTILYSE® prescrite : Bolus : …….mg

Perfusion : …….mg

Nom du Médecin Prescripteur : .....

Demande de réapprovisionnement : ..... flacons de 50 mg

..... flacons de 10 mg

Nom et Signature IDE :

VACCIN ANTITETANIQUE

- Prendre une carte vierge
- Coller une étiquette du patient sur le recto
- Sur le verso coller l'étiquette du vaccin (n° de lot et date de péremption)
- Mettre un tampon de l'établissement (à l'accueil administratif) ou noter HPSJ et signer
- Donner la carte au patient en lui disant de la mettre dans son carnet de santé.

Recto

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

CARTE DE VACCINATION ANTITÉTANIQUE

NOM :

Prénom :

Adresse :

Né(e) le :

CETTE CARTE DOIT ETRE GARDEE EN PERMANENCE
ET PEUT ETRE MISE AVEC LA CARTE DE DONNEUR DE SANG OU DE GROUPE SANGUIN

Service des urgences

185 rue Raymond Losserand 75674 PARIS CEDEX 14 - Standard : 01 44 12 33 33

Verso

Injection	Vaccin utilisé	N° du lot	Date	Cachet de l'établissement
1ère injection				
2ème injection				
3ème injection				
1er rappel				
2ème rappel				
3ème rappel				

Sérum : Date : Sérum : Date :

Sérum : Date : Sérum : Date :

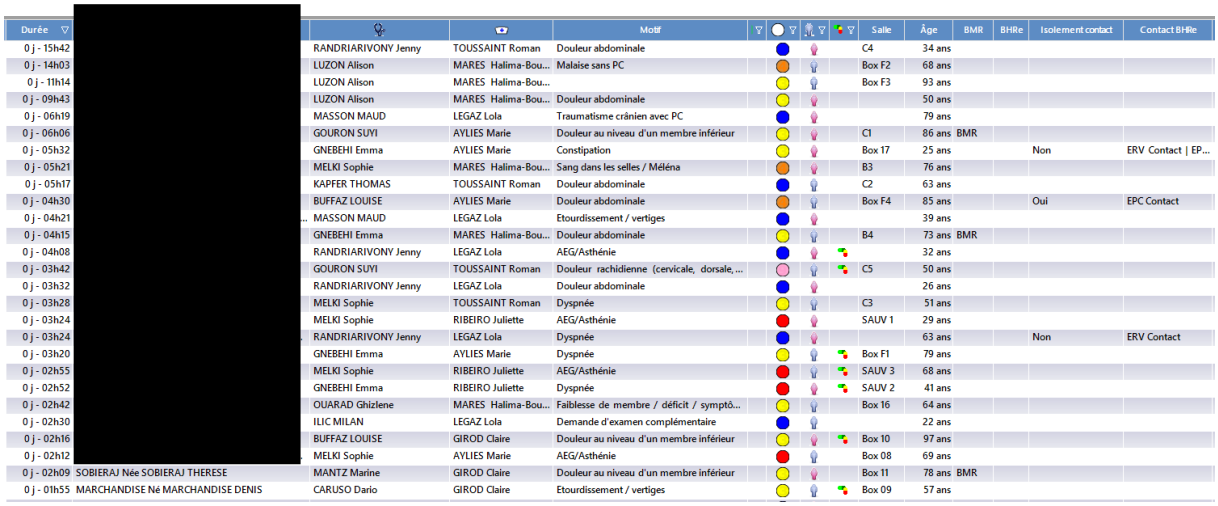
4. HYGIENE

INFORMATION DANS LE DOSSIER PATIENT

Depuis quelques années, nous n'utilisons plus le terme « isolement », nous lui préférons le terme « précautions complémentaires ».

Vous trouvez l'information dans le dossier du patient, mais également dans le bandeau de DxCare.

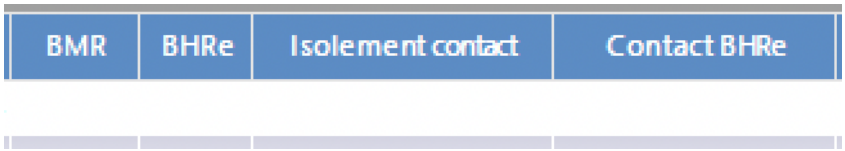
Sur DxCare, avec la liste complète des patients :



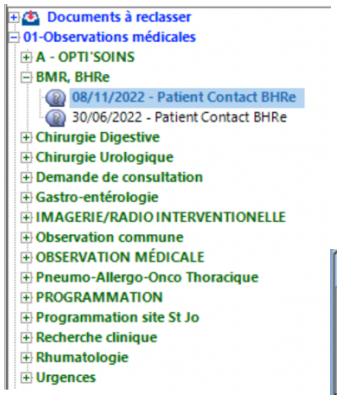
Durée	[redacted]	Motif				Salle	Âge	BMR	BHRe	Isolement contact	Contact BHRe
0 j - 15h42	RANDRIARIVONY Jenny	TOUSSAINT Roman	Douleur abdominale			C4	34 ans				
0 j - 14h03	LUZON Alison	MARES Halima-Bou...	Malaise sans PC			Box F2	68 ans				
0 j - 11h14	LUZON Alison	MARES Halima-Bou...				Box F3	93 ans				
0 j - 09h43	LUZON Alison	MARES Halima-Bou...	Douleur abdominale				50 ans				
0 j - 06h19	MASSON MAUD	LEGAZ Lola	Traumatisme crânien avec PC				79 ans				
0 j - 06h06	GOURON SUYI	AYLIES Marie	Douleur au niveau d'un membre inférieur			C1	86 ans	BMR			
0 j - 05h32	GNEBEHI Emma	AYLIES Marie	Constipation			Box 17	25 ans			Non	ERV Contact | EP...
0 j - 05h21	MELKI Sophie	MARES Halima-Bou...	Sang dans les selles / Méléna			B3	76 ans				
0 j - 05h17	KAPFER THOMAS	TOUSSAINT Roman	Douleur abdominale			C2	63 ans				
0 j - 04h30	BUFFAZ LOUISE	AYLIES Marie	Douleur abdominale			Box F4	85 ans			Oui	EPC Contact
0 j - 04h21	MASSON MAUD	LEGAZ Lola	Etourdissement / vertiges				39 ans				
0 j - 04h15	GNEBEHI Emma	MARES Halima-Bou...	Douleur abdominale			B4	73 ans	BMR			
0 j - 04h08	RANDRIARIVONY Jenny	LEGAZ Lola	AEG/Asthénie				32 ans				
0 j - 03h42	GOURON SUYI	TOUSSAINT Roman	Douleur rachidienne (cervicale, dorsale, ...			C5	50 ans				
0 j - 03h32	RANDRIARIVONY Jenny	LEGAZ Lola	Douleur abdominale				26 ans				
0 j - 03h28	MELKI Sophie	TOUSSAINT Roman	Dyspnée			C3	51 ans				
0 j - 03h24	MELKI Sophie	RIBEIRO Juliette	AEG/Asthénie			SAUV 1	29 ans				
0 j - 03h24	RANDRIARIVONY Jenny	LEGAZ Lola	Dyspnée				63 ans			Non	ERV Contact
0 j - 03h20	GNEBEHI Emma	AYLIES Marie	Dyspnée			Box F1	79 ans				
0 j - 02h55	MELKI Sophie	RIBEIRO Juliette	AEG/Asthénie			SAUV 3	68 ans				
0 j - 02h52	GNEBEHI Emma	RIBEIRO Juliette	Dyspnée			SAUV 2	41 ans				
0 j - 02h42	OUARAD Ghizlene	MARES Halima-Bou...	Faiblesse de membre / déficit / symptô...			Box 16	64 ans				
0 j - 02h30	ILIC MILAN	LEGAZ Lola	Demande d'examen complémentaire				22 ans				
0 j - 02h16	BUFFAZ LOUISE	GIROD Claire	Douleur au niveau d'un membre inférieur			Box 10	97 ans				
0 j - 02h12	MELKI Sophie	AYLIES Marie	AEG/Asthénie			Box 08	69 ans				
0 j - 02h09	SOBIERAJ Née SOBIERAJ THERESE	MANTZ Marine	Douleur au niveau d'un membre inférieur			Box 11	78 ans	BMR			
0 j - 01h55	MARCHANDISE Né MARCHANDISE DENIS	CARUSO Dario	GIROD Claire	Etourdissement / vertiges		Box 09	57 ans				

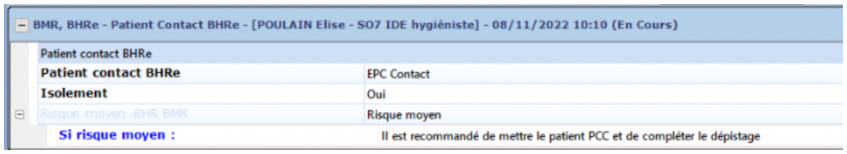
Sur le bandeau dossier patient :

On retrouve plusieurs onglets (*pas forcément dans cet ordre*) :



Dans le dossier du patient (synthèse) :





Concrètement :

BMR	BHRe	Isolement contact	Contact BHRe
		Non	EPC Contact
EBLSE			
		Non	EPC Contact
BMR			
BMR			
			EPC Contact

- Dans la case BMR, vous trouverez soit le nom de la bactérie multi-résistantes (exemple « **EBLSE** ») ou le mot « **BMR** ».

- Dans la case BHRe, vous trouverez soit le terme « **BHRe** », soit le mot « **OUI** ». Cela signifie que le patient est porteur d'une BHRe → Dans ce cas, le patient doit être isolé en box du début à la fin de sa prise en charge.

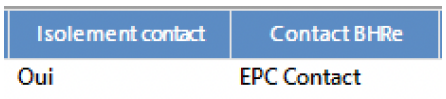
- Dans la case isolement contact, vous y trouverez les termes « **Oui** », « **Non** », ou encore « **Précautions complémentaires contact (PCC)** ».

- Dans la case contact **BHRe**, si celle-ci est notifié, cela signifie que le patient a été mis en contact avec un patient porteur d'une **BHRe.** Par conséquent, un dépistage est recommandé. Nous retrouverons les termes « **EPC contact** », « **ERV contact** » ou encore « **EPC contact / ERV contact** ».

Pour rappel →

BMR	**BHRe**
Bactérie multi-résistante	Bactérie hautement résistantes émergentes
BLSE, SARM, ABRI	EPC, ERV

Conduite à tenir :

S'il y a noté ...	Dois-je dépister ?	Qu'est-ce que je dépiste ?	Quelles précautions ?
BMR	OUI	On regarde dans la synthèse, « Observations médicales » > « BMR, BHre »	Précautions complémentaires contact
EBLSE	OUI	BLSE	Précautions complémentaires contact
ABRI	OUI		Précautions complémentaires contact
SARM	OUI	SARM	Précautions complémentaires contact
BHRe	OUI	EPC / ERV	Précautions complémentaires contact renforcées
	OUI	EPC	NON
	OUI	EPC	OUI

PRESCRIPTION DE PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES ET/OU D'UN DEPISTAGE

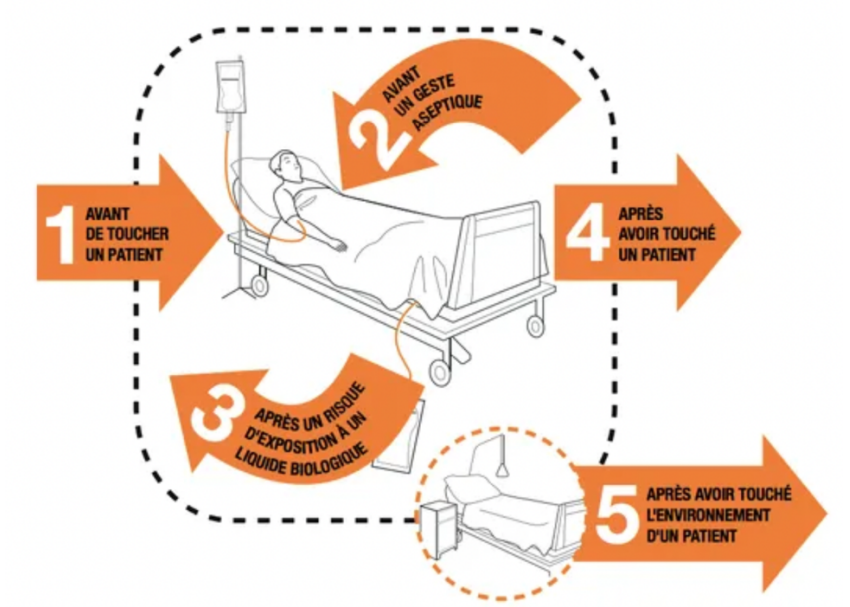
A ECRIRE

LES PRECAUTIONS STANDARD

1. Désinfection des mains

Devant le patient

- Après le retrait des gants
- Entre deux patients,
- Chez un même patient entre deux activités



2. Port de gants

Les gants ne doivent être portés que :

- S'il y a risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l'occasion de soins à risque de piqûre (hémocultures, poses et déposes de voies veineuses, chambres implantables, prélèvements sanguins…) et lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériel souillés, urines, selles….

ET

- Lors de tout soin, lorsque les mains du soignant comportent des lésions

Les gants doivent être immédiatement jetés après le soin et une friction des mains avec un produit hydroalcoolique doit être réalisée.

Deux types de gants :

→ Gants vinyle non poudrés qui doivent être portés selon les indications précédentes.

→ Gants nitrile non poudrés qui doivent être utilisés seulement pour la réalisation de soins, tel qu'un prélèvement sanguin ou la pose d'une voie veineuse périphérique.

3. Port de surblouses, lunettes, masques

Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine (aspirations, endoscopies, actes opératoires, autopsies, manipulations de matériel et linge souillés).

Le port du masque est aussi obligatoire lorsque le soignant est porteur d'une maladie transmissible par voie aérienne (grippe, angine, rhinopharyngite…)

4. Matériel souillé

- Matériel piquant / tranchant à usage unique : ne pas recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la main, déposer immédiatement après usage sans manipulation ce matériel dans un conteneur adapté, situé au plus près du soin, et dont le niveau maximal de remplissage est vérifié. Ce conteneur doit être daté et éliminé dès que la limite de remplissage est atteinte ou tous les sept jours maximums.
- Matériel réutilisable : manipuler avec précautions le matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine

5. Gestion des excreta et déchets

Le protocole de gestion des excreta doit être respecté. L'acheminement des bassins, urinaux est protégé (couvercle ou sac).

6. Surfaces souillées

Nettoyer et désinfecter avec un désinfectant approprié les surfaces souillées par des projections ou aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine.

7. Transport de prélèvements biologiques, de linge et de matériel souillés

Les prélèvements biologiques, le linge et instruments souillés par du sang ou tout autre produit d'origine humaine doivent être transportés dans un emballage étanche, fermé.

8. Si contact avec du sang ou liquide biologique[3]

- Après piqûre, blessure : lavage et antisepsie au niveau de la plaie
- Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant
- Contacter dans les 4 heures un médecin référent AES

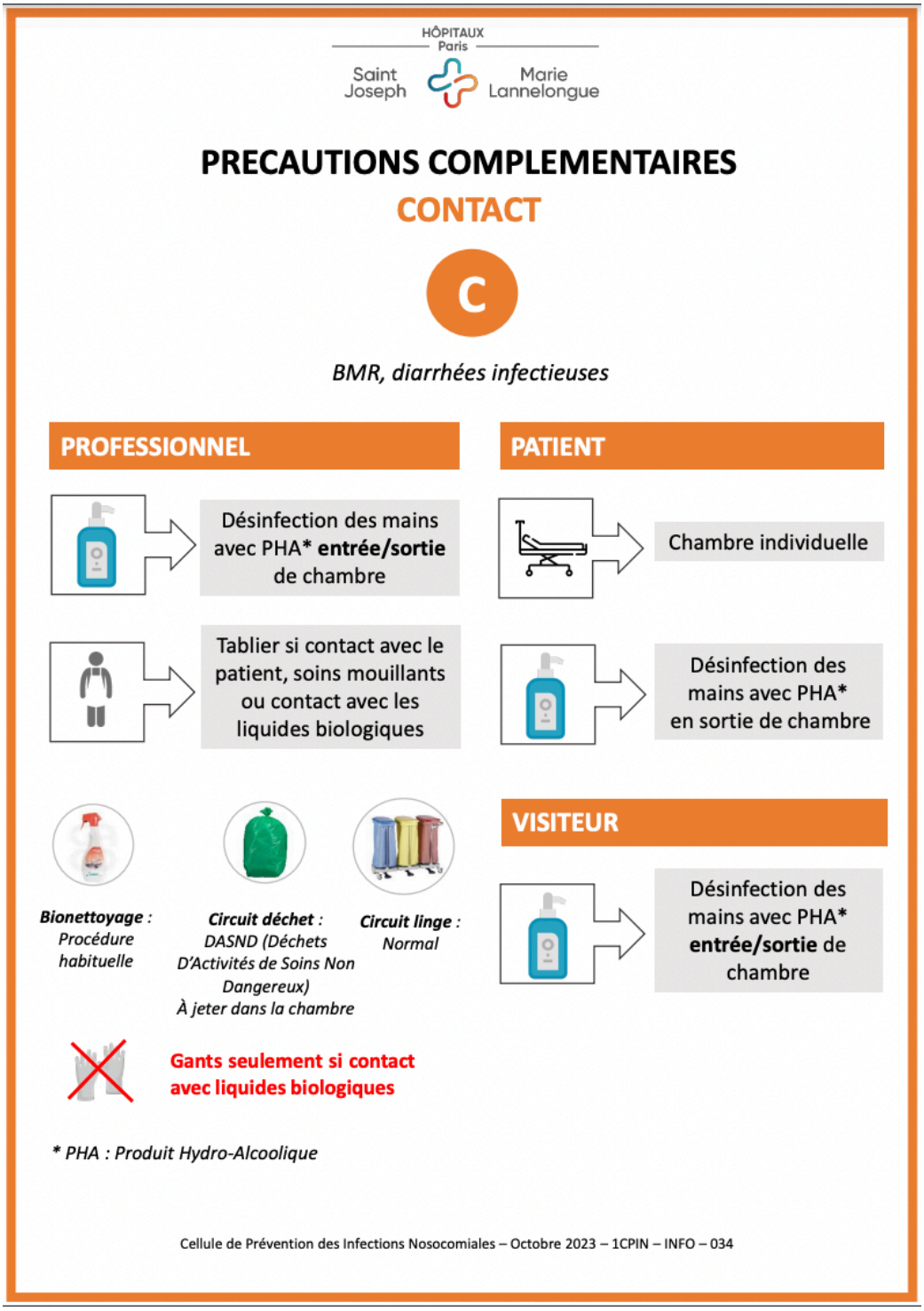
[3] Chapitre Procédure et protocole, I. Procédure 1. AUX URGENCES > 1.19 : Conduite à tenir en cas d'AES.

LES FICHES DES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

A l'Hôpital Saint-Joseph, la cellule de prévention des infections nosocomiales (CPIN) a mis en place 7 précautions complémentaires contact et 1 isolement protecteur.

Nous vous invitons à en prendre connaissance :

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT - BMR, DIARRHEES INFECTIEUSES.



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT RENFORCEES - BHRE :

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph — Marie Lannelongue

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES
CONTACT Renforcées
BHRe

CR

Bactéries Hautement Résistantes émergentes

PROFESSIONNEL

- **Désinfection des mains** avec PHA* **entrée/sortie** de chambre
- **Surblouse dès l'entrée** de la chambre
- Tablier si contact avec le patient, soins mouillants ou contact avec les liquides biologiques

Bionettoyage : *Procédure BHRe*

Circuit déchet : *DASND (Déchet d'Activités de Soins Non Dangereux) à jeter dans la chambre*

Circuit linge : *Normal*

Gants seulement si contact avec liquides biologiques

PATIENT

- Chambre individuelle
- **Désinfection des mains** avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

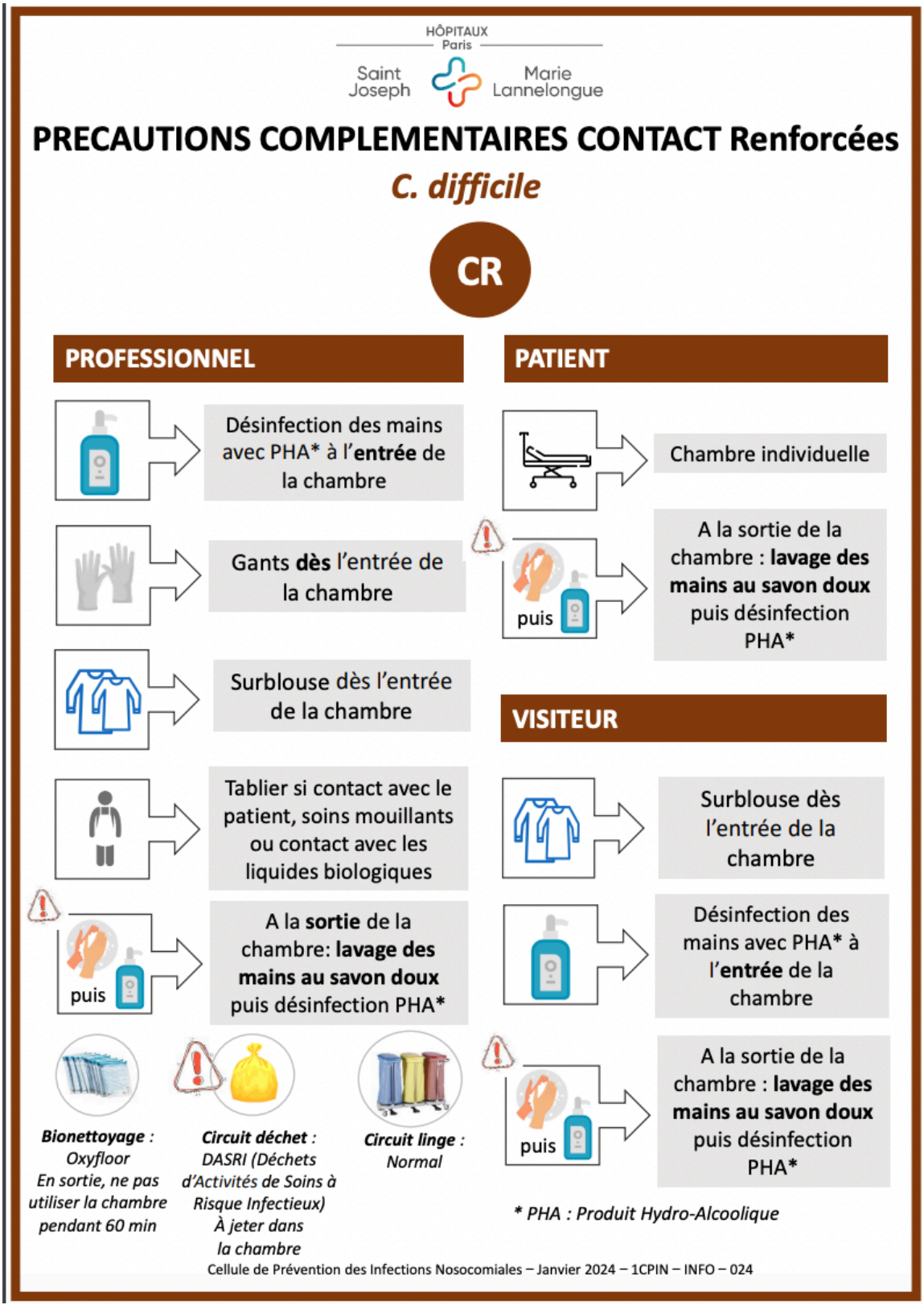
VISITEUR

- **Désinfection des mains** avec PHA* à **entrée/sortie** de chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Janvier 2024 – 1CPIN – INFO – 024

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT RENFORCEES – CLOSTRIDIUM DIFFICILE



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT RENFORCEES – ECTOPARASITES, GALE

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph — Marie Lannelongue

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées

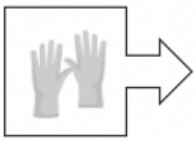
ECTOPARASITES, GALE

CR

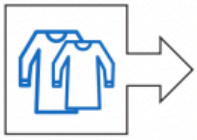
Gale, autres ectoparasites

PROFESSIONNEL

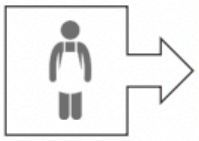
Désinfection des mains avec PHA* à l'**entrée** de la chambre



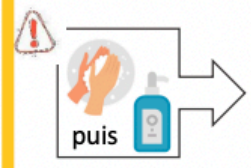
Gants **dès** l'entrée de la chambre



Surblouse dès l'entrée de la chambre



Tablier si contact avec le patient, soins mouillants ou contact avec les liquides biologiques



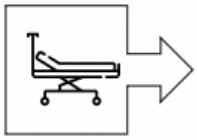
A la **sortie** de la chambre: **lavage des mains au savon doux** puis désinfection PHA*

Bionettoyage : *Oxyfloor En sortie, ne pas utiliser la chambre Pendant 60 min*

Circuit déchet : *DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux) À jeter dans la chambre*

Circuit linge : ***SPECIFIQUE***

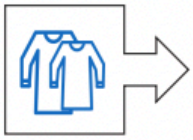
PATIENT



Chambre individuelle

A la sortie de la chambre : **lavage des mains au savon doux** puis désinfection PHA*

VISITEUR



Surblouse dès l'entrée de la chambre

Désinfection des mains avec PHA* à l'**entrée** de la chambre

A la sortie de la chambre : **lavage des mains au savon doux** puis désinfection PHA*

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Janvier 2024 – 1CPIN – INFO – 024

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES GOUTTELETTES – COVID, VRS, GRIPPE

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph — Marie Lannelongue

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

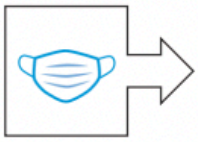
GOUTTELETTES

G

Infections respiratoires : Covid, Grippe, VRS, méningocoque…

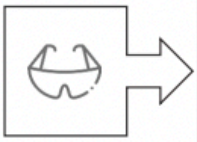
PROFESSIONNEL

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

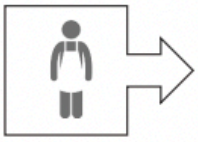


Masque chirurgical** **avant** de rentrer dans la chambre

***FFP2 : Si soins à risque d'aérosolisation (précautions standard)*



Lunettes ou visière :
- Si soins proches du patient sans masque
- Si soins à risque d'aérosolisation



Tablier :
- Si soins proches du patient sans masque
- Si soins à risque d'aérosolisation

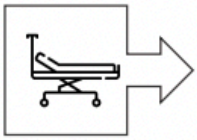
Bionettoyage : *Procédure habituelle*

Circuit déchet : *DASND (Déchets d'Activités de Soins Non Dangereux) à jeter dans la chambre*

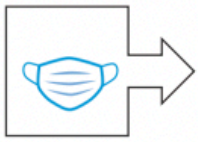
Circuit linge : *Normal*

Gants seulement si contact avec liquides biologiques

PATIENT



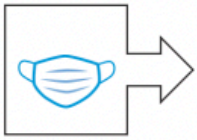
Chambre individuelle



Masque chirurgical :
- En sortant de la chambre
- Dès qu'une personne entre dans la chambre

Désinfection des mains avec PHA* en sortie de chambre

VISITEUR



Masque chirurgical avant d'entrer

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Janvier 2024 – 1CPIN – INFO – 024

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES AIR – TUBERCULOSE, VARICELLE, ROUGEOLE.

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

AIR

A

Tuberculose, varicelle, rougeole

PROFESSIONNEL

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

Masque FFP2 **avant** de rentrer dans la chambre
Même en l'absence du patient

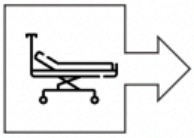
Bionettoyage : *Procédure habituelle*

Circuit déchet : *DASND (Déchets D'Activités de Soins Non Dangereux)*
À jeter dans la chambre

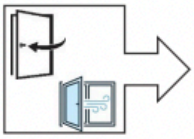
Circuit linge : *Normal*

Gants seulement si contact avec liquides biologiques

CHAMBRE

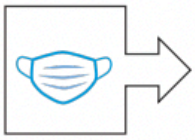


Chambre individuelle



Porte fermée et **aération régulière** de la chambre

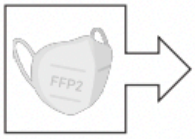
PATIENT



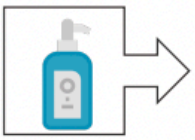
Masque chirurgical en sortant de la chambre

Désinfection des mains avec PHA* en sortie de chambre

VISITEUR — Visites à limiter



Masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre



Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Octobre 2023 – 1CPIN – INFO – 035

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT RENFORCEES – CANDIDA AURIS

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées

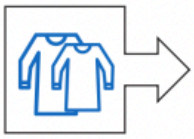
Candida auris

CR

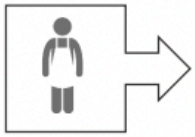
Candida auris

PROFESSIONNEL

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Surblouse dès l'entrée de la chambre



Tablier si contact avec le patient, soins mouillants ou contact avec les liquides biologiques

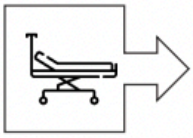
Bionettoyage : *Oxyfloor*
En sortie, ne pas utiliser la chambre pendant 60 min

Circuit déchet : *DASND (Déchet d'Activités de Soins Non Dangereux) à jeter dans la chambre*

Circuit linge : *Normal*

Gants seulement si contact avec liquides biologiques

PATIENT



Chambre individuelle

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

VISITEUR

Désinfection des mains avec PHA* à **entrée/sortie** de chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Janvier 2024– 1CPIN – INFO – 024

ISOLEMENT PROTECTEUR

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

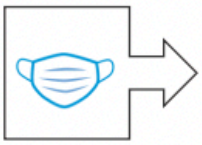
ISOLEMENT PROTECTEUR

P

Patients à risque élevé d'infections fongiques, bactériennes ou virales graves

PROFESSIONNEL

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque chirurgical **NEUF dès l'entrée** de la chambre

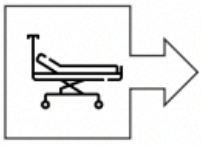
Bionettoyage (En dernier) : *Procédure habituelle, désinfection matériel partagé entrée/sortie de chambre*

Circuit déchet : *DASND (Déchets D'Activités de Soins Non Dangereux)*

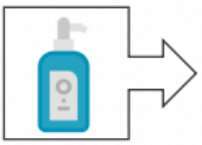
Circuit linge : *Normal*

Gants seulement si contact avec liquides biologiques

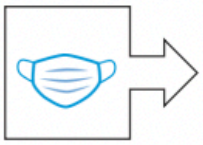
PATIENT



Chambre individuelle



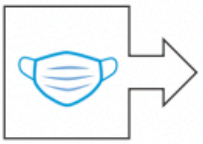
Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque chirurgical en sortant de la chambre

VISITEUR

Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque chirurgical **NEUF dès l'entrée** de la chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Janvier 2024 -1CPIN – INFO – 024

CONDUITE A TENIR EN CAS DE GALE

1. Généralités

La gale est une infection cutanée très contagieuse due à un parasite (Sarcoptes scabiei hominis), creusant des sillons dans la couche cornée de l'épiderme.

2. Modes de transmission

La transmission de la maladie est liée à la contamination par une femelle fécondée de Sarcoptes scabiei hominis.

- Contamination inter humaine, au cours de soins directs : par contact étroit et prolongé en cas de gale commune. Un contact cutané simple suffit en cas de gale hyperkératosique.
- Contamination indirecte par l'intermédiaire de l'environnement (les vêtements, le linge, ou la literie, les serviettes, les fauteuils). Toute surface poreuse peut être parasitée en cas de gale hyperkératosique.

3. Facteurs de risques

La dissémination du parasite est favorisée par la vie en collectivité.

Les facteurs de risques sont :

- Les contacts rapprochés et prolongés
- La cohabitation de personnes dans un espace restreint
- Pour les soignants, les soins de nursing

4. Incubation

La durée d'incubation moyenne de la gale est de 4 semaines et peut aller jusqu'à 6 semaines.

5. Diagnostic

5.1. Clinique

Association d'un prurit (recrudescence nocturne, parfois à caractère familial) et présence de lésions cutanées.

- **Gale commune :** touche les doigts (espaces interdigitaux), les poignets et les cuisses (faces antérieures), les aisselles, l'aréole mammaire, les organes génitaux mais pas le visage et le dos. Présence de papules inflammatoires prurigineuses, vésicules perlées, sillons et nodules scabieux. Association à des lésions secondaires non spécifiques (lésions de grattage, eczématisation, lichénification, impétigo).
- **Gale hyperkératosique** (exemple gale « norvégienne »), **gale profuse** : forme rare, sévère et très contagieuse de gale caractérisée par une infestation massive de parasites. Conséquence d'un déficit immunitaire, parfois d'un diagnostic tardif ou d'un traitement

inadapté. Les cas non diagnostiqués peuvent être à l'origine d'épidémies de gale, notamment en institution, en raison d'un risque de contagiosité très élevé, y compris par le biais des surfaces inertes. Se présente sous la forme d'une dermatose hyperkératosique « farineuse » sur tout le corps dont visage, dos et cuir chevelu, associée à une éruption érythémateux-papuleuse du tronc (dos inclus), du visage, du cou et du cuir chevelu. Attention aux formes localisées au **niveau ongles des mains et des pieds.**

5.2. Parasitologique

Demander un avis dermatologique et faire réaliser, par le laboratoire de microbiologie, un prélèvement par grattage profond des lésions afin d'identifier dans les sillons et/ou vésicules des adultes, œufs, larves, ou scybales.

6. Traitement

Traitement individuel - Il associe le traitement médicamenteux et le traitement du linge.

Traiter le patient et le(s) contact(s) simultanément. Il n'y a pas de consensus concernant le traitement local et ou oral pour les gales communes. **Cependant, la facilité d'utilisation plaide en faveur du traitement per os d'autant plus que le nombre de personnes à traiter est important.**

Dans les gales hyperkératosiques : associer le traitement topique et per os en plus du traitement du linge et de l'environnement.

- Le traitement médicamenteux est appliqué sur prescription médicale (tableau des modalités d'application du traitement à J-0) :

Traitement local	Traitement par voie orale
- Déshabiller le patient en évitant de secouer les vêtements à mettre dans un sac plastique hermétique. - Faire prendre une douche chaude avec un savon doux, rincer, sécher modérément. - Appliquer la crème Topiscab® avec une compresse sur la totalité de la surface corporelle y compris le visage, en insistant sur les lésions, les plis, les espaces interdigitaux, sous les ongles coupés courts, l'ombilic, la face antérieure des poignets, derrière les oreilles, la plante des pieds, les parties génitales (en dehors des muqueuses) ; frotter en cas de pilosité importante. Eviter les paupières et les muqueuses. Appliquer sur le cuir chevelu si gale hyperkératosique. - Laisser sécher puis 2ème application à passer selon le même protocole. - Laisser en contact 24 heures, y compris sur les mains, renouveler l'application dans la journée si besoin (en cas de lavage des mains). - Mettre du linge propre (vêtements et draps).	- Administrer le traitement Stromectol® (3mg) en comprimé, prescrit en une seule prise après un jeun strict de deux heures, et ensuite laisser à jeun pendant deux heures. **Posologie : 200ug/kg** - Faire prendre une douche au savon doux. - Rincer abondamment. Sécher. - Mettre du linge propre (vêtement et draps). - Changer la literie.

- Changer la literie.	

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT D'INFECTION DUE AU MONKEYPOX VIRUS

Rappels épidémiologiques :

La variole simienne (du singe) « monkeypox » ou « MKP » (orthopoxvirose/poxviridae) est apparenté au virus de la variole. Dans sa forme Africaine (Nigeria, bassin du Congo, RDC), l'infection est une zoonose : la majorité des patients a été contaminée au contact d'animaux infectés (singe et rongeurs principalement), après consommation de viande de brousse, ou après contact avec un patient infecté (lésions cutanées, affaires personnelles - intrafamilial).

Exposition depuis mai 2022 : cas mondiaux autochtones liés à des transmissions cutanées lors de rapports sexuels.

Les cas identifiés à ce jour en Europe sont bénins. Les populations potentiellement plus à risque de formes graves (éruption majeure, surinfection, pneumopathie, atteinte cornéenne, signes encéphaliques) sont les immunodéprimés, les femmes enceintes car transmission materno-fœtale / périnatale possible avec formes graves du nouveau-né, et les enfants (forme plus sévère).

Sa transmission peut se faire par différentes voies :

- Principalement par contact direct avec des lésions cutanées, des croutes ou des liquides biologiques ;
- Par voie respiratoire : exposition à des sécrétions respiratoires échangées lors de présence prolongée en face à face ou lors de contact plus intimes (baisers, caresses, relations sexuelles oro-génitales) ;
- Par contact indirect par des objets (linge, vêtements, objets de toilette ou de cuisine…) ;
- Par transmission transplacentaire de la mère à l'enfant.

1. Définitions des cas et des contacts

Cas suspect = signes cliniques évocateurs uniquement.

- Éruption cutanée ou muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de MKP, isolée (sans autre signes simultanés), précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie.

Cas possible = signes cliniques évocateurs + exposition à risque d'infection.

- Éruption cutanée ou muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de MKP, isolée (sans autre signes simultanés), précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie, avec au moins l'une des expositions suivantes dans les 3 semaines précédant le début des signes :

- Retour d'un voyage dans un pays d'Afrique où le virus circule habituellement ; où
- Partenaires sexuels multiples, quelle que soit l'orientation sexuelle ; où
- Homme ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Cas probable = signes cliniques évocateurs + contact à risque d'un cas confirmé.

- Éruption cutanée ou muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de MKP, isolée (sans autre signes simultanés), précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie,
- **ET** un contact à risque (définition infra) avec un cas confirmé en France, ou dans un autre pays.

Cas confirmé = qPCR ou RT-PCR spécifique Monkeypox ou générique Orthopoxvirus.

- Un résultat positif de qPCR ou RT-PCR spécifique du virus MKP,
- **OU** un résultat positif en qPCR générique du genre Orthopoxvirus, associée ou non à un résultat de séquençage partiel spécifique du virus MKP

Personne-contact à risque :

- Toute personne ayant eu un contact physique direct non protégé sans notion de durée avec la peau lésée ou les fluides biologiques d'un cas probable ou confirmé symptomatique, quelles que soient les circonstances y compris rapport sexuel, actes de soin médical ou paramédical, ou un contact physique indirect par le partage d'ustensiles de toilette, ou le contact avec des textiles (vêtements, linge de bain, literie) ou de la vaisselle sale utilisés par le cas probable ou confirmé symptomatique.
- Toute personne ayant eu un contact non protégé à moins de 2 mètres pendant 3 heures avec un cas probable ou confirmé symptomatique (ex. ami proche ou intime, partenaire sexuel habituel même en l'absence de rapports sexuels, personnes partageant le même lieu de vie sans lien intime, voisin pour un transport de longue durée, personnes partageant le même bureau, acte de soin ou d'hygiène, même classe scolaire, salle de TD universitaire, club de sport pour les sports de contacts, salles de sports, …).

Personne-contact à risque négligeable :

- Toute personne ayant eu un contact à risque tel que décrit ci-dessus en présence de mesures de protection efficaces respiratoires portées par le cas où le contact, et de mesures de protection efficaces contact portées par la personne-contact. Les mesures de protection efficaces vis-à-vis du contact physique direct sont le port de gants étanches (latex, nitrile, caoutchouc), et vis-à-vis du contact respiratoire sont les masques chirurgicaux et FFP2, et les hygiaphones.
- Toute autre situation.

2. Conduite à tenir en pratique

2.1.Faire le diagnostic clinique et éliminer les diagnostics différentiels

Patient suspect = Tableau clinique ET exposition compatible

Incubation habituelle de 7 à 14 jours (min 5j- max 21 jours)

Tableau clinique, 2 phases de l'infection :

- Phase initiale, prodromique non spécifique : fièvre >38°C, frissons, polyadénopathies cervicales et inguinales en particulier, myalgies, asthénie.
- Phase d'éruption, 1 à 3 jours après début de la fièvre, en une seule poussée : macules, puis papules, vésicules, pustules parfois de grande taille, avec ombilication centrale, parfois nécrotiques, pseudo-folliculites, inflammation péri-lésionnelle, pouvant atteindre tout le corps notamment paumes et plantes de pieds, visage, cuir chevelu, région ano-génitale, bouche. Poussée unique en général, mais possibilité de lésions d'âges différents. Douleurs lors des poussées, peu de prurit.

Guérison en 2 à 4 semaines, avec formation de croûtes, elles-mêmes encore infectieuses.

- Recherche de signes de gravité : létalité peu documentée (jusqu'à 10% des cas). Les complications peuvent être : éruption majeure (plus de 100 vésicules), formes digestives, ORL avec compressions locales, atteinte cornéenne, signes encéphalitiques, sepsis, surinfection, pneumopathie. Ces formes-là nécessitent une hospitalisation en ESR, voire en CHU.

Diagnostics différentiels : varicelle (mais lésions d'âges différents épargnant paumes et plantes), rougeole, variole (pas d'adénopathies), infections bactériennes cutanées, syphilis, gale, allergies.

Description des lésions :

LE PATIENT EST CONTAGIEUX PENDANT TOUTES LES PHASES CLINIQUES		
Délai approximatif	Phase clinique (source CDC)	Illustration (source gov.uk)
J0	Phase prodromique non spécifique : fièvre >38°C, poly adénopathie, myalgies, asthénie	
J1-2	Enanthème 1ères lésions = bouche / langue	
J2-3	Macules Rash centrifuge débutant sur la face et se répandant vers les membres en 24h, puis les paumes des mains et plantes des pieds	
J3	Papules	
J4-5	Vésicules (liquide clair) ∅ ≈ 3mm	
J6-7	Pustules (liquide opaque) pointues, fermes ∅ ≈ 2mm	
	Pustules ombiliqués ∅ ≈ 3-4mm	
	Pustules ulcérés ∅ ≈ 5mm	
J12	Formation de croûte sur lésion mature	
A partir de J14	Croûte en cours de cicatrisation *A noter : le patient reste contagieux jusqu'à la cicatrisation complète après chute des croûtes*	

Checklist en cas Monkeypox suspecté :

Si le patient doit être hospitalisé, les patients seront adressés en première intention dans les établissements de santé de référence (ESR) REB.

En absence d'hospitalisation (la grande majorité des cas) :

- Donner une ordonnance pour rechercher bilan IST systématique à J30 si FR d'IST : sérologie VIH, VHB, VHC, TPHA VDRL, PCR gonocoque et Chlamydia 1er jet d'urine, anus et gorge.
- Arrêt de travail (21 jours si forte suspicion)
- Pour les cas possibles, probables et confirmés : faire la DO à l'ARS. Pas de DO pour les cas suspects
    - fax : 01 44 02 06 76.
    - E-mail : ars75-alerte@ars.sante.fr. Tél : 0 800 811 411

➔ Identification précoce des personnes contact à risque avec l'ARS (patients et personnels).
➔ Il est recommandé aux personnes contacts à risque élevé ou modéré de surveiller deux fois par jour leur température pendant 3 semaines après le dernier contact à risque avec le cas probable ou confirmé, la fièvre signant le début de la contagiosité et étant plus précoce que l'éruption.
➔ Prévenir le patient qu'il sera contacté par l'ARS et Santé publique France
➔ Prévenir Santé Publique France au 07 64 55 93 28
➔ Déclarer le cas à la CPIN

2.2.Les précautions complémentaires

Le patient est contagieux du début des symptômes jusqu'à guérison complète des lésions cutanées : il est donc nécessaire de mettre en place des précautions complémentaires.

Les dernières recommandations de la SF2H (octobre 2023) concernant la prise en charge en milieu hospitalier des patients atteints ou suspects d'infection à MKP, sont les suivantes :

- Mise en place des précautions complémentaires contact (port de tablier à usage unique) et port d'un masque chirurgical en cas de prise en charge d'un patient suspect ou infecté par le MKP.
- Port de gants recommandé pour les contacts avec les lésions cutanées, les muqueuses ou risque de contact avec les liquides biologiques
- L'utilisation des appareils de protection respiratoire type FFP2 est limité aux recommandations pour les situations à risques d'aérosolisation quel que soit le micro-organisme en cause.

Pour le patient : masque chirurgical en dehors de la chambre et en présence d'une tierce personne + hygiène des mains par friction hydroalcoolique + couvrir les lésions cutanées.

Bionettoyage :

- Classique, Surfanios® ou spray/lingettes désinfectantes.
- Matériel partagé à limiter au maximum

Déchets de soins : filière DASRI.

2.3. Dépistage microbiologique

Tester les cas suspects et possibles. Par exception, pour ces cas, le test peut ne pas être réalisé si les symptômes cliniques sont suffisamment évocateurs et que les diagnostics différentiels ont été écartés.

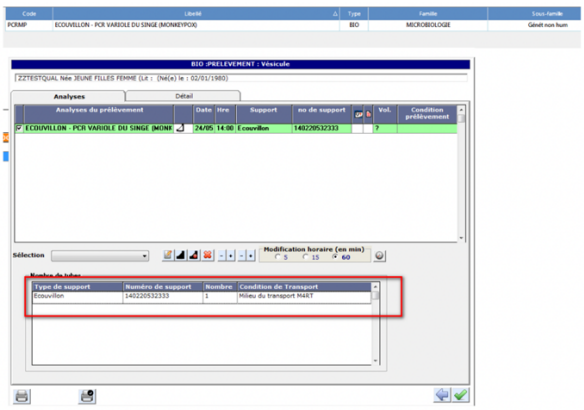
Il est inutile de tester les cas probables.

Diagnostic par test génomique : PCR spécifique MPXV → Prélèvement de préférence cutané (biopsie, ou écouvillon en frottant plusieurs vésicules), ou bien nasopharyngé si poussée éruptive dans la bouche ou la gorge.

► Différents types de prélèvements :

- **Cutanéomuqueux :** Vésicules, ulcérations => gratter le plancher de la vésicule (où se situent les cellules infectées) avec un écouvillon sec, et/ou prélèvement d'une croûte qui pourront être ensuite conservés dans un tube sec ou déchargé dans un milieu de transport viral Biopsie pour les lésions sèches de type macule ou papule si pré-traitement par le laboratoire possible
- **Sphère ORL :** Écouvillonnages oropharyngés (nasopharyngés possibles), à décharger dans un milieu de transport viral surtout si poussée éruptive dans la bouche ou la gorge.
- **Sang :** virémie brève (1 à 2 jours), recherche de virus peu rentable, sur sang total en tube EDTA.
- **Respiratoires semi-profonds et profonds** par aspirations trachéo-bronchiques, liquides broncho-alvéolaires, prélèvements distaux protégés, crachats induits si signes
- **LCR** si suspicion d'atteinte neurologique.

Privilégier la prescription connectée :



Réalisation et envoi des prélèvements par les soignants :

PREPARER : Les étiquettes et le Bon de demande avant de prélever : identification du patient, localisation exacte du site de prélèvement, et mention explicite de « recherche de MonkeyPox virus » ;

PRELEVER : Écouvillonner la lésion, à l'aide d'un 1 écouvillon sécable dans un tube de transport viral (type Virocult, M4RT), puis retirer l'écouvillon et l'introduire directement dans le tube contenant du milieu de transport viral ;

DECONTAMINER les tubes de prélèvement à l'intérieur de la chambre/box avant leur **mise en triple emballage.**

- Désinfecter la surface des tubes de prélèvement à l'aide d'une lingette désinfectante.
- Retirer la paire de gants.
- Réaliser une friction des mains avec SHA.

TRIPLE EMBALLAGE :

Le 1er CONDITIONNEMENT EST REALISE A L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE/BOX

- Étiqueter le tube avec les étiquettes issues de la PCBM,
- S'assurer que le tube de transport viral qu'il est bien refermé hermétiquement,
- Mettre le tube dans le premier SACHET PLASTIQUE (risque Biohazard),
- Retirer la surblouse et le tablier,
- Réaliser une FHA,
- Sortir de la chambre/box avec le prélèvement.

Le RESTE DU CONDITIONNEMENT est fait A L'EXTERIEUR de la chambre/box

- Mettre le sachet dans le sac kangourou, avec le bon de demande dans la pochette kangourou
- Le tout doit être positionné dans un contenant rigide (Boite de transport) qui aura été préalablement récupéré à l'accueil du laboratoire par le coursier et sur lequel il sera explicitement mentionné la « recherche de MonkeyPox virus »

ACHEMINEMENT Les échantillons sont transportés par coursier à l'accueil central des laboratoires : ne pas utiliser le pneumatique pour l'acheminement des échantillons.

INFORMER l'équipe de microbiologie de l'envoi de l'échantillon aux postes 8123 (accueil microbiologie) ou 8197 (internes microbiologie) ou 7070 (sénior microbiologie) ou par mail à labomicrobio@ghpsj.fr ou infectieux@ghpsj.fr

2.4.Vaccination post-exposition

Discuter de la vaccination dans les 4j après le contact à risque, au maximum 14j selon recommandations HAS (balance bénéfice-risque individuelle à évaluer), incluant les

professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle. Une vaccination précoce présente un intérêt important chez un patient à risque de forme grave. Elle est réalisée avec le vaccin Imvanex® ou Jynneos®, dit de troisième génération administrée avec un schéma à deux doses (ou trois doses chez les sujets immunodéprimés), espacées de minimum 28 jours.

2.5.Numéros utiles :

Établissement référent : Hôpital Bichat

- ➔ ESR Bichat (Tél : 01 40 25 78 04)
- ➔ Standard (nuit, we et jours fériés) : 01 40 25 80 80 demander l'infectiologue de garde
- ➔ → CNR : Laboratoire Expert des Orthopoxvirus, tél : 06 03 87 58 59

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT D'INFECTION DUE AU CORONAROVIRUS DU MOYEN ORIENT (MERS-COV)

1. Rappel

La majorité (89 %) des cas est rapportée par les pays de la péninsule Arabique (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen) et plus particulièrement par l'Arabie saoudite (83 %). La contamination est interhumaine par voie respiratoire. Le délai d'incubation moyen est de 5,5 jours ; au-delà de 14 jours après un dernier contact avec un sujet contagieux, le risque de déclarer la maladie est considéré comme nul.

2. Définition – Repérer le cas :

En pratique : Cas possible = Tableau clinique (< 14 jours après exposition) ET Exposition compatible

Définition de cas disponible sur Santé Publique France (dernière mise à jour : 4 juillet 2022) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/notre-action/#tabs

La définition de cas a été modifiée par rapport à celle du 12 septembre 2018, pour apporter des précisions sur le type de tableaux cliniques justifiant le classement en cas possible en fonction du type d'exposition à risque, et notamment la notion de pneumopathie hypoxémiante pour les personnes ayant voyagé ou séjourné dans un pays à risque (cf. liste ci-dessous).

2.1. Cas possible :

a) Tout personne présentant un tableau clinique sévère avec :
- Un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)

OÙ :

- Une pneumopathie hypoxémiante définie par une oxygénorequérance associée à des anomalies sur l'imagerie de thorax, avec une fièvre ≥38°C

ET :

- Ayant voyagé ou séjourné dans un pays à risque (listés ci-dessous) dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes.

b) Toute personne présentant un tableau clinique d'infection respiratoire aigüe, quel que soit le niveau de gravité :

ET au moins une des expositions à risque listées ci-dessous, dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes :

- Contact (ex : famille, soignants) avec un cas possible ou confirmé lorsque que celui-ci était malade (i.e. symptomatique) ;

- Activité professionnelle ou hospitalisation dans un établissement de soins situé dans un pays à risque (cf. liste ci-dessous) ;
- Contact proche avec un dromadaire ou un produit issu de l'animal (lait non pasteurisé, viande crue, urine) dans un pays à risque (cf. liste ci-dessous).

Pour les personnes immunodéprimées ou présentant une pathologie chronique, il faut considérer également la survenue d'un syndrome fébrile avec diarrhée et/ou tableau clinique sévère.

2.2. Cas confirmé :

Tout cas possible avec un prélèvement biologique indiquant l'infection par le MERS-CoV.

Liste des pays considérés à risque au 4 juillet 2022 :

- Les pays de la péninsule arabique qui ont rapporté des cas et où une circulation du virus a été documentée : Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen ;
- Tout autre pays ayant rapporté un ou plusieurs cas autochtone(s) au cours des 12 derniers mois.

2.3. Diagnostics alternatifs à envisager

Principales autres causes de fièvre ou de pneumonie au retour de la péninsule arabique :

- Autre virose respiratoire/COVID/grippe, infection urinaire haute, typhoïde, salmonellose, arbovirose (fièvre de la vallée du rift, fièvre West Nile, fièvre à Phlébotomes), brucellose aiguë (endémique dans cette zone), paludisme (peu probable mais quelques pays de la liste sont endémiques notamment pour Plasmodium vivax)
- Pneumopathie bactérienne (dont légionellose) ou virale autre
- La diarrhée fébrile : salmonellose mineure et autres diarrhées du voyageur
- Autre infection

3. Conduite à tenir devant cas possible

3.1. Protéger-Mesures d'isolement

3.1.1. Aux urgences :

Devant tout patient consultant pour fièvre et syndrome respiratoire aigu dans les 14 jours suivant le retour d'une zone à risque d'infection au virus MERS-Cov) (péninsule arabique), l'agent administratif à l'accueil doit :

➔ Prévenir l'IOA (6190) et le médecin sénior régulateur (7790).

Pour le patient :

- Demander au patient (et aux accompagnants) de porter un masque chirurgical (masque chirurgical et SHA à disposition sur le comptoir de l'accueil des urgences) et de faire une friction de mains avec le SHA (flacon à conserver par le patient)
- Installer immédiatement le patient dans le box 7 ou 8
- En cas de SDRA : réalisation des gestes médicaux nécessaires (réanimation si besoin) sans réalisation de bilan ou d'imagerie, l'urgence étant le transfert
- En cas d'absence de SDRA : tout patient suspect de MERS-CoV doit avoir une imagerie pulmonaire ; réalisation d'une radiographie au lit du patient, la plaque doit être emballée. Cette radiographie est nécessaire au classement du cas.
  Possibilité de prélever un bilan biologique y compris des GDS et PCR COVID+/- grippe. En revanche pas de prélèvements microbiologiques respiratoires (ECBC, aspiration nasopharyngée…)
  Si besoin des antibiotiques pourront être débutés avant le transfert.

Le personnel y compris le manipulateur radio :

- Mise en place de précautions complémentaire « air » et précautions complémentaires contact :
- Masque FFP2 à porter avant d'entrer dans le box, vérifier étanchéité (fit test)
- Mettre la surblouse à usage unique dans le box
- Port d'un tablier plastique si soins mouillants
- Lunettes de protection si soins à risque de projection
- Gants non stériles en systématique
- Renforcement de l'utilisation des SHA
- Les déchets seront éliminés selon la filière DASRI

3.1.2. En hospitalisation *(si apparition de signes respiratoires pendant son séjour)*

Patient en chambre seule :

Maintien du patient dans sa chambre.

Le personnel : mise en place de précautions complémentaire « air » et précautions complémentaires contact (cf. ci-dessus)

4. Analyse clinico-épidémiologique pour estimer la probabilité diagnostique et classer le cas

Le médecin senior du service, en lien avec l'ARS (tel : 0 800 811 411) classe le patient en cas possible (critères de gravité cliniques ou d'exposition) ou cas exclu. ars75-alerte@ars.sante.fr.

4.1. Le patient est un cas possible validé

Décision d'orientation du patient avec l'ARS en priorité à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière (les enfants sont pris en charge à Necker) via un SMUR

- Téléphone astreinte infectiologie de la Pitié : 01 42 16 01 07
- Téléphone service de réanimation de la Pitié : 01 42 16 77 44

- Avertir la direction : direction@ghpsj.fr
- Avertir la CPIN : hygiene@ghpsj.fr / DECT : **74.97**, **77.67**

Le médecin sénior du service contacte le médecin régulateur du SAMU 75 (15) qui est en charge du transport.

4.1.1. Après transfert, bionettoyage de la chambre ou du box avant toute nouvelle utilisation :

➔ Matériels à prévoir
- Détergent : Déterg'anios® : Dilution : 10 ml pour 4 litres d'eau.
- Anios Oxy'Floor® : 1 sachet pour 5 litres d'eau tiède (dilution à 0.5%)
- Bandeaux
- Chiffonnettes
- Seaux

Le personnel en charge du patient doit effectuer le bionettoyage. Le personnel a une casaque imperméable à usage unique à manches longues, un tablier plastique, un masque FFP2 des lunettes de protections et une paire de gants en nitrile à longues manchettes ;

- **Si présence d'autres déchets liquides non recueillis dans le bassin : les recouvrir par de l'eau de Javel diluée.**
- Bionettoyage en 3 étapes :
- Nettoyage avec un détergent Déterg'anios®
- Rinçage à l'eau.
- Désinfection des sols et des surfaces avec la solution d'Anios Oxy'Floor® : 1 sachet pour 5 litres d'eau tiède (dilution à 0.5%)
- Laisser agir 60 minutes.
- Élimination des déchets dans un fut DASRI

4.2. <u>Le patient est un cas exclu :</u>

- Poursuite de la prise en charge classique

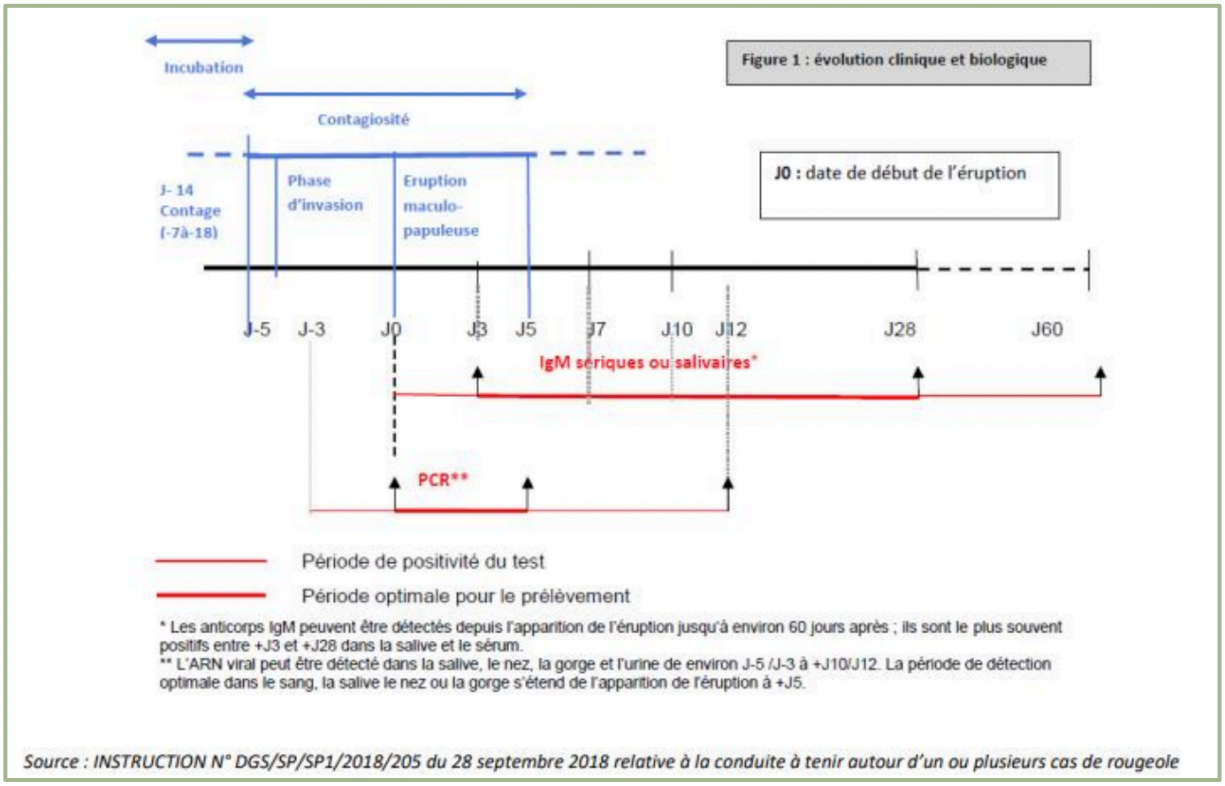
PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DE ROUGEOLE

1. Situation épidémique, contagiosité :

On observe une recrudescence importante de la rougeole en Europe et dans le monde. En France l'incidence augmente depuis 2023 avec de nombreux foyers épidémiques.

La contagiosité est très importante ; la transmission du virus est directe par voie aérienne à partir des sécrétions nasopharyngées et, plus rarement, par des objets contaminés. La période d'incubation dure une dizaine de jours. La phase de contagiosité commence la veille de l'apparition des premiers symptômes, soit cinq jours avant le début de l'éruption, et s'étend jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Dans une population non immunisée, une personne contagieuse peut contaminer 15 à 20 personnes.

Figure : Évolution clinique de la rougeole :



Source : INSTRUCTION N° DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d'un ou plusieurs cas de rougeole

2. Vaccination :

Un sujet est immunisé contre la rougeole s'il a fait la maladie ou sa vaccination est à jour.

Vérifier son statut vaccinal contre la rougeole et le cas échéant à la mise à jour des vaccinations des patients selon les recommandations en vigueur du calendrier vaccinal dans le respect des contre-indications habituelles du vaccin trivalent ROR ;

- Toute personne née depuis 1980 doit avoir reçu deux doses de vaccins contre le ROR avec un délai d'au moins un mois entre les deux doses quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies ;
- Pour toute personne née avant 1980, non vaccinées et sans antécédent connu de rougeole, la vaccination avec une dose de vaccin trivalent ROR est fortement recommandée, sans contrôle sérologique préalable, pour les professions de santé ou toute personne exerçant dans les services accueillant des patients à risque de rougeole grave (immunodéprimés), au contact des enfants ou exposées au contact d'un cas de rougeole.

La vaccination contre la rougeole peut être prescrite et administrée à tout public par un médecin ou une sage-femme ; Elle peut aussi être prescrite aux personnes de plus de 11 ans, sauf aux personnes immunodéprimées, par un pharmacien ou un infirmier ;

3. Signes cliniques :

Le diagnostic est à évoquer devant tout patient, quel que soit son statut vaccinal, en présence : d'une fièvre ≥ 38,5°C associée à une éruption maculo-papuleuse et d'au moins un des signes suivants : conjonctivite, rhinite, toux, signe de Köplik.

La phase éruptive est une éruption maculopapuleuse qui persiste cinq à six jours et qui survient en moyenne quatorze jours après le contage. Elle débute au niveau du visage et derrière les oreilles et s'étend progressivement de haut en bas et vers les extrémités.

Otites et diarrhées sont les complications les plus fréquentes. Les complications sévères surviennent notamment chez les patients âgés de moins d'1 an et de plus de 20 ans : pneumonie, surtout chez l'enfant (2 à 7 %) et encéphalite aiguë, surtout chez l'adulte (0,5 à 1/1 000). La panencéphalite sclérosante subaiguë est une complication rare (estimée à 1 pour 100 000 patients infectés), tardive (en moyenne sept ans après la rougeole) et constamment létale. Les personnes immunodéprimées peuvent présenter des complications (pneumopathie interstitielle à cellules géantes ou encéphalite à inclusions) habituellement mortelles.

Une confirmation biologique est indispensable préférentiellement par prélèvement oropharyngé et amplification génique par RT-PCR (cf. ci-dessous).

4. Conduite à tenir :

4.1. Signalement précoce

Maladie à déclaration obligatoire.

Tout cas cliniquement évocateur (y compris avant résultats biologiques) doit faire l'objet d'un signalement sans délai au point focal régional de l'Agence Régionale de Santé (ARS) par tout moyen approprié (téléphone, mail) ou à l'aide de la fiche déclaration obligatoire même si tous les items n'ont pu être renseignés, ils pourront être complétés par la suite.

ARS :

➔ E-mail : ars75-alerte@ars.sante.fr
➔ Tél : 0 800 811 411
➔ Fax : 01 44 02 06 76

4.2.Précautions complémentaires air

Cf. Affiche Précautions Complémentaires Air.

- Chambre individuelle, porte fermée. Aération régulière de la chambre
- Mise en place des PC air (masque FFP2 pour les soignants et les visiteurs) ; chambre individuelle
- Limiter les déplacements du patient au strict nécessaire ; masque chirurgical pour le patient.
- Limiter les visites
- Mesures d'éviction recommandées pendant toute la période de contagiosité du cas à savoir dès les premiers symptômes jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption.
- Désinfection des mains (précautions standard), bionettoyage, circuit du linge et des déchets habituels.

4.3.Prélèvement diagnostique oropharyngé pour PCR

L'ARN viral est détectable de quelques jours avant le début de l'éruption jusqu'à environ 10 jours après.

Faire un écouvillonnage nasopharyngé (idem que le tube pour PCRCOVID) pour réalisation d'une RT-PCR idéalement dans les cinq premiers jours suivant le début de l'éruption maculo-papuleuse le cas échéant.

La prescription doit se faire en prescription connectée via DxCare

Code	Libellé	Type	Famille	Sous-famille
PCRROUG	ECOUVILLON NASO PHARYNGÉ - PCR ROUGEOLE	BIO	MICROBIOLOGIE	Virologie

Dans tous les cas, ces prélèvements ne doivent pas retarder le signalement précoce à l'ARS ni la mise en œuvre des premières mesures urgentes.

4.4. Prévention des cas secondaires si le patient n'a pas été isolé dès son arrivée à l'hôpital

- Recenser les contacts parmi les personnels, les patients et leurs accompagnants pour :

- Les informer et vérifier leur statut vaccinal
- Vacciner avec le ROR, si possible immédiatement, ou dans les 72h :
    - Les nourrissons de 6 à 11 mois révolus
    - Les personnes sans schéma vaccinal complet (cf. ci-dessus). NB : la vaccination reste recommandée si le délai de 72h est dépassé
- Si la vaccination est contre indiquée, organiser l'administration d'immunoglobulines polyvalentes dans les 6 jours pour les personnes à risque :
    - Les nourrissons de moins de 6 mois dont la mère n'a pas d'ATCD de rougeole et n'a pas été vaccinée
    - Les nourrissons de 6 à 11 mois n'ayant pu être vaccinés dans les 72 h suivant le contact
    - Les patients ou personnels immunodéprimés
    - Les femmes enceintes non vaccinées et sans antécédent de rougeole.

NB : Des cas de rougeole ont été décrits chez des personnes vaccinées. Aussi, en cas d'apparition de symptômes évocateurs, tout personnel doit :

- Porter un masque chirurgical
- Consulter un médecin, réaliser un prélèvement diagnostique
- Ne pas se rendre sur le lieu de travail, informer l'encadrement du service

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DU COVID

Cette procédure s'applique lorsque l'épidémie COVID a un taux d'incidence modéré (TI < 100 cas/ 100 000 habitants).

1. Contexte :

On rappelle que la transmission du COVID est gouttelettes et contact. Il est bien démontré que les patients porteurs du virus contaminent l'environnement de leur chambre (poignées, lavabo, siphons, cuvette des toilettes).

La transmission de la grippe est gouttelettes.

Les précautions décrites ci-dessous participent aux précautions standard, à respecter pour tout patient.

2. Règles du port de masques :

2.1. Port du masque pour le personnel

Le masque chirurgical est indiqué chez tout professionnel :

- Qui a des signes d'infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures
- Qui a un facteur de risque de forme grave du COVID-19 / Grippe
- Qui est en contact avec un patient :
    - Suspect ou atteint d'infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures (NB : masque FFP2 si tuberculose ORL/pulmonaire, rougeole, varicelle) *,
    - Immunodéprimé relevant d'un isolement protecteur,
    - Lors d'un soin à risque de projection de liquides biologiques (NB : masque FFP2 si soin à risque d'aérosolisation, ex : intubation, bronchoscopie, ...)
    - Lors de la réalisation d'un soin invasif (intervention chirurgicale, soins sur plaie ouverte...)
- Qui travaille dans un service accueillant des patients à risque de formes graves de COVID-19 / Grippe (par ex : transplantation) sur décision du chef de service.

**En cas de personnel de santé avec COVID-19 : masque chirurgical en continu pendant 14 jours. Rester seul pour tous les moments, ne permettant pas le port de masque en continu (ex : repas, pause-café etc…) Désinfection des mains par FHA.*

Le masque FFP2 doit être porté par les personnels pour les indications suivantes, pour tout patient (identifié COVID ou non) (cf. annexe) :

- Actes invasifs ou manœuvres respiratoires à risque d'aérosolisation listées ci-dessous. Le port du masque FFP2 doit être associé au port de lunettes de protection et d'une protection de la tenue (surblouse).
    - Prélèvement naso-pharyngé

  - Aspiration trachéale, intubation/extubation
  - Endoscopie haute
  - Pose de sonde naso-gastrique
  - Nébulisation
  - VNI, traitement de l'apnée du sommeil (SAPS)
  - Kiné respiratoire
  - EFR
  - Ventilation au masque
  - Oxygénothérapie haut débit, Optiflow…

- Prise en charge d'une tuberculose pulmonaire/ORL ou d'une rougeole ou d'une varicelle.

2.2. Port du masque pour les patients :

Le masque chirurgical est indiqué à l'intérieur des bâtiments hospitaliers pour les patients :

- Ayant des signes d'infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures
- Immunodéprimés (relevant d'un isolement protecteur)
- A risque de forme grave de COVID-19/ Grippe.
- Cas contact proche d'un cas de COVID-19/ Grippe (ex : vivant sous le même toit)

Pour les patients ayant une indication au port de masque chirurgical, le patient devra porter son masque durant les soins, pendant la visite médicale et lors des transferts pour les examens.

Si transfert ou examen en dehors de sa chambre : l'IDE ajuste le masque au patient avant qu'il sorte de sa chambre. Le patient doit garder le masque durant toute la durée de ses transferts et son examen.

Donner un flacon de SHA à chaque patient. **Former le patient à l'hygiène des mains** et insister sur la nécessité de se frictionner les mains à chaque fois qu'il devra toucher son masque, les parties communes ou qu'il sort de sa chambre.

Former le patient à la manipulation du masque.

Aération régulière de la chambre. Demander au patient d'ouvrir sa fenêtre régulièrement s'il est autonome.

2.3. Port du masque pour les visiteurs

Visites non autorisées aux visiteurs ayant des signes d'infection des voies respiratoires. En cas de circonstances exceptionnelles et que la visite ne peut être reportée, ils doivent porter un masque en continu à l'intérieur des bâtiments.

3. Dépistage COVID pour le patient

3.1. Indications

Les indications sont les suivantes :

- Tout patient ayant des symptômes évocateurs d'infection COVID, même mineurs (sans
- COVID dans les 8 dernières semaines) : un dépistage doit être réalisé dès leur apparition.
- Contact d'un cas COVID-19 (ex : chambre double ou en cas de cluster) : dépistage à J0 puis entre J 2 et J4 (par PCR ou test antigénique)
- Lors d'un cluster, dépistage à J0. Si tous négatifs, renouveler entre J2 et J4. Si négatifs, arrêt des dépistages. Si d'autres cas sont identifiés, renouveler à J7 et à J14.
- Concernant le dépistage préopératoire, la SFAR ne préconise plus de dépistage systématique avant une intervention chirurgicale, mais préconise si le patient est COVID un report de la chirurgie de 10 jours minimum chez le patient non à risque ayant une forme non grave de COVID-19, et de 4 semaines chez le patient à risque et/ou ayant une forme grave (si la chirurgie le permet).

3.2. Aide à l'interprétation d'une PCR SARS COV 2 positive

Devant une PCR positive avec antécédent de COVID > 8 semaines ou date du premier épisode inconnue ou sans antécédent connu de COVID :

- Si symptôme, même modérés : infection récente.
- Si aucun symptôme :
    - CT ≤ 33 : infection récente
    - CT > 33 contrôle de PCR dans les 48 heures.
        - Si CT ≤ 33 : infection récente.
        - Si CT > 33 : infection probablement ancienne.

4. Conditions d'hospitalisation :

4.1.Chambre double

Pour les patients en chambre double, la surveillance clinique est quotidienne. En cas d'apparition de signes de COVID ou Grippe chez l'un des patients, l'installer en chambre seule et faire la PCR SARS CoV-2.

4.2. Chambre individuelle

La chambre individuelle est fortement recommandée pour les patients à risque de forme grave de COVID-19/ grippe.

Chambre individuelle nécessaire pour :

- Patient suspect de COVID/ Grippe
- Ayant des symptômes respiratoires ou un syndrome grippal
- Contact d'un cas de COVID-19/ Grippe
- Sévèrement immunodéprimé et ceux à risque d'échec vaccinal.

- Patient nécessitant un traitement produisant des aérosols (O2 haut débit, aérosols, VNI, Optiflow, appareillage apnée du sommeil) ou kinésithérapie respiratoire
- Patient nécessitant un isolement lié à une autre pathologie que le COVID-19/ Grippe (sauf si microorganisme identique, par exemple : 2 bactéries multirésistantes identiques).
- Chambre ne permettant pas le respect des mesures de distanciation physique ou patient ne pouvant pas appliquer les mesures de distanciation physique (par ex : troubles cognitifs sévères).

4.3. Conduite à tenir en cas de découverte d'un cas de COVID-19 ou de Grippe en chambre double

Le praticien en charge du patient informe le voisin de chambre du patient qu'il a été en contact avec un cas de COVID-19/ Grippe. Ce patient est considéré comme une personne contact à risque. Le praticien en charge du patient informe la CPIN (tel : 7915- 7767).

Cas où le patient contact est encore hospitalisé :

Le patient contact est placé en isolement en chambre seule. Lui faire une PCR SARS CoV2 (soit à J0). Mise en place de précautions gouttelettes et contact. Renouveler le dépistage pour le COVID entre J2 et J4.

Cas où le patient contact sort à domicile :

Le praticien informe le patient qu'il est contact COVID-19/ Grippe en lui donnant les consignes suivantes :

Remise d'une prescription de dépistage COVID-19 à réaliser au laboratoire de son choix (entre J2 et J4).

- Isolement à domicile et respect des mesures barrières pour protéger l'entourage pendant 7 jours
- Surveillance de la survenue de signes cliniques
- Personne à contacter en cas d'apparition de signes cliniques, notamment son médecin traitant.
- Il en informe également le médecin traitant du patient

Cas où le patient est transféré dans un autre établissement/EHPAD :

Le praticien informe l'établissement d'accueil où le patient a été transféré.

Et la CPIN du GHPSJ se met en lien avec la CPIN de l'autre établissement pour le suivi d'éventuels cas secondaires.

5. Règles des visites :

Patient **COVID/grippe** : visites pour les patients COVID à l'appréciation de l'équipe médicale.

Patient **NON COVID/grippe :**

- Visites non autorisées aux visiteurs ayant des signes d'infection des voies respiratoires. En cas de circonstances exceptionnelles et que la visite ne peut être reportée, ils doivent porter un masque en continu à l'intérieur des bâtiments.
- Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre.

6. Bionettoyage de la chambre :

Selon la procédure habituelle.

7. Vaccinations :

COVID recommandée :

- 2 fois / an pour les personnes de plus de 80ans, les patients immunodéprimés et les patients à très haut risque de forme grave.
- 1 fois / an pour les professionnels de santé, les personnes de plus de 65 ans et les patients avec comorbidités.

GRIPPE recommandée :

- Pour tous les personnels de santé 1 fois / an lors de la campagne de vaccination antigrippale.

8. Modalités du port du masque FFP2 :

Indications : prélèvement nasopharyngé, aspiration trachéale, nébulisation, oxygénothérapie haut débit, Optiflow® intubation/extubation, VNI, kinésithérapie respiratoire, endoscopie haute, EFR, épreuve d'effort, pose sonde nasogastrique, ventilation au masque.

AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE / BOX

→ Mettre un masque FFP2

→ Ajuster la barrette nasale (doigts à plat)

→ En cas de port de lunette de vue garder les lunettes lors de l'ajustement du masque.

1) **Repérer le haut (barrette nasale).**
2) **Passer les élastiques derrière la tête, de part et d'autres des oreilles.**
3) **Vérifier que le masque couvre bien le menton.**

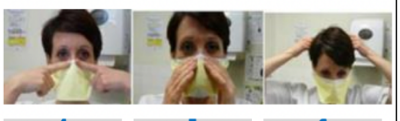
→ Réaliser un Fit-check:

→ Vérifier l'absence de fuite sur les bords en réaliser une forte expiration.

→ Vérifier que le masque se creuse en réalisant une forte inspiration (le masque doit se creuser).

Buée sur lunettes = non protégé

4) **Ajuster le masque en pinçant la barrette**
5) **Tester l'étanchéité : placer les mains sur le masque et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.**
6) **Après usage, retirer le masque par les élastiques.**



PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DU COVID AUX URGENCES

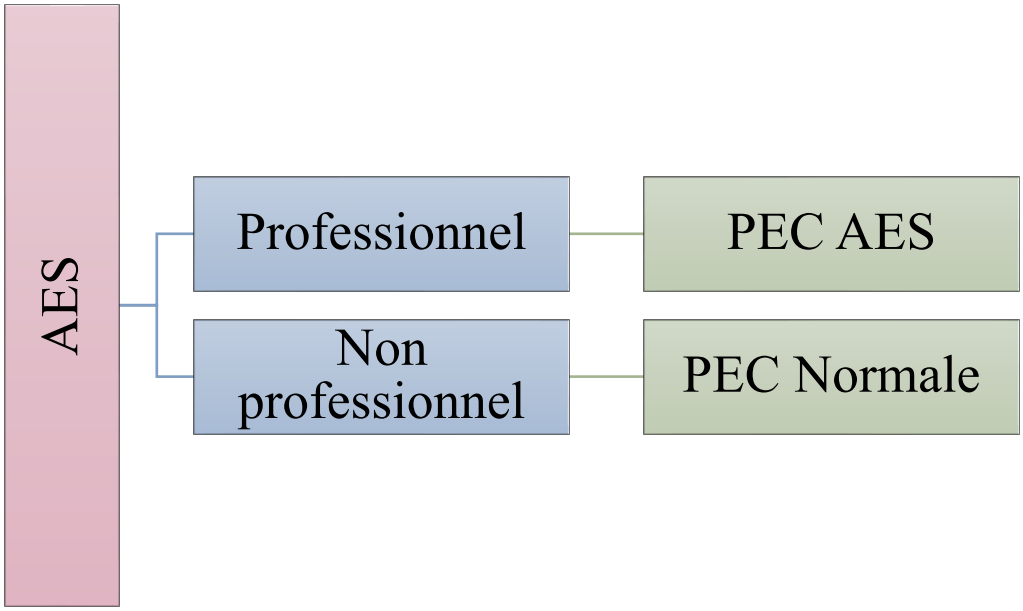
Tous les patients présentant une détresse respiratoire aiguë nécessitant une prise en charge immédiate à la SAUV, seront installé dans le box 8 nommé « SAUV COVID ».

Un dépistage COVID par RT-PCR est réalisée :

- **Si le test est négatif :**
  - Installation du patient à la SAUV.
- **Si le test est positif :**
  - Le patient est sous oxygénothérapie à moins de 6L/min :
    - Possède toutes ses facultés cognitives et/ou peut garder un masque
      → Installation en zone d'attente.
    - Ne possède pas toutes ses facultés cognitives et/ou ne peut pas garder un masque
      → Installation en box.
  - Le patient est sous oxygénothérapie à plus de 6L/min :
    - Laisser le patient dans le box.
  - Le patient nécessite l'administration d'aérosol
    - Isoler le patient en box (Box 11 ou avec fenêtre).

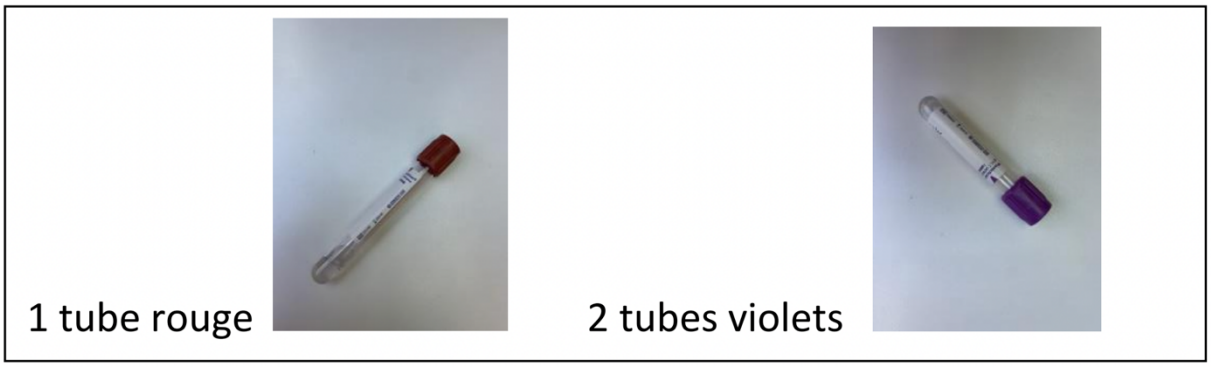
5. ZONE 1

PRISE EN CHARGE D'UN AES

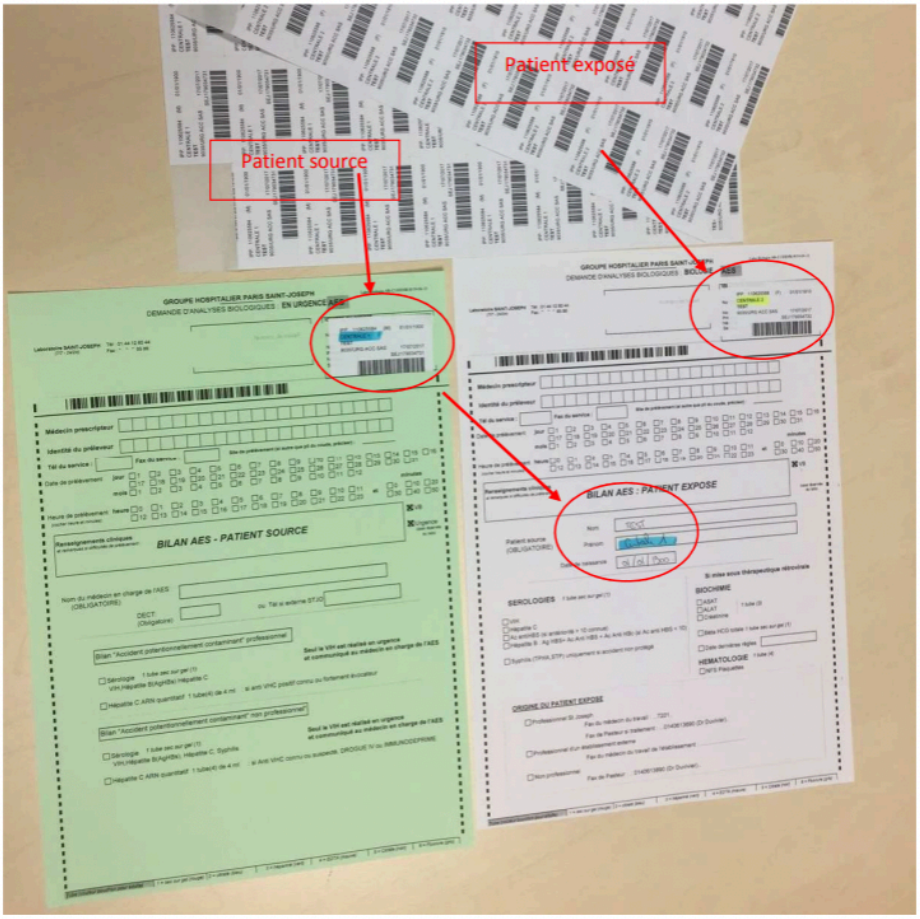


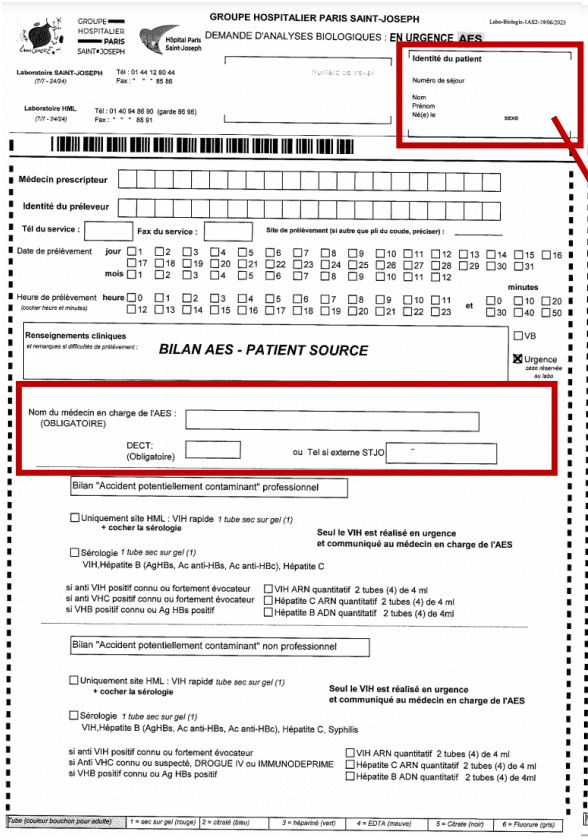
Procédure AES professionnel :

1- Récupérer les tubes du patients sources et prélèvement sanguins du patient exposé.



2- Envoie au laboratoire des tubes avec étiquettes, du patient source ET du patient dans deux sachets différents, mais dans 1 seul pochette d'envoie.
3- Remplir les demandes papiers en se référant aux prescription DxCare.
Attention : Ne pas utiliser les étiquettes connectées DxCare.
4- Si un TPE (trithérapie) est prescrit (Delstrigo®) donner au patient la totalité du traitement prescrit sur ordonnance (3 ou 5 jours donc 3 ou 5 cp) avec première prise au SAU (prescription DxCare).




GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

DEMANDE D'ANALYSES BIOLOGIQUES : EN URGENCE AES

Identité du patient

Numéro de séjour

Nom

Prénom

Né(e) le

sexe

Médecin prescripteur

Identité du préleveur

Tél du service :

Fax du service :

Site de prélèvement (si autre que pli du coude, préciser) :

Date de prélèvement jour

mois

Heure de prélèvement heure

minutes

Renseignements cliniques

et remarques si difficultés de prélèvement :

BILAN AES - PATIENT SOURCE

VB

Urgence

Nom du médecin en charge de l'AES : (OBLIGATOIRE)

DECT: (Obligatoire)

ou Tel si externe STJO

Bilan "Accident potentiellement contaminant" professionnel

Uniquement site HML : VIH rapide 1 tube sec sur gel (1)
+ cocher la sérologie

Seul le VIH est réalisé en urgence et communiqué au médecin en charge de l'AES

Sérologie 1 tube sec sur gel (1)
VIH,Hépatite B (AgHBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc), Hépatite C

si anti VIH positif connu ou fortement évocateur
si anti VHC positif connu ou fortement évocateur
si VHB positif connu ou Ag HBs positif

VIH ARN quantitatif 2 tubes (4) de 4 ml
Hépatite C ARN quantitatif 2 tubes (4) de 4 ml
Hépatite B ADN quantitatif 2 tubes (4) de 4ml

Bilan "Accident potentiellement contaminant" non professionnel

Uniquement site HML : VIH rapide tube sec sur gel (1)
+ cocher la sérologie

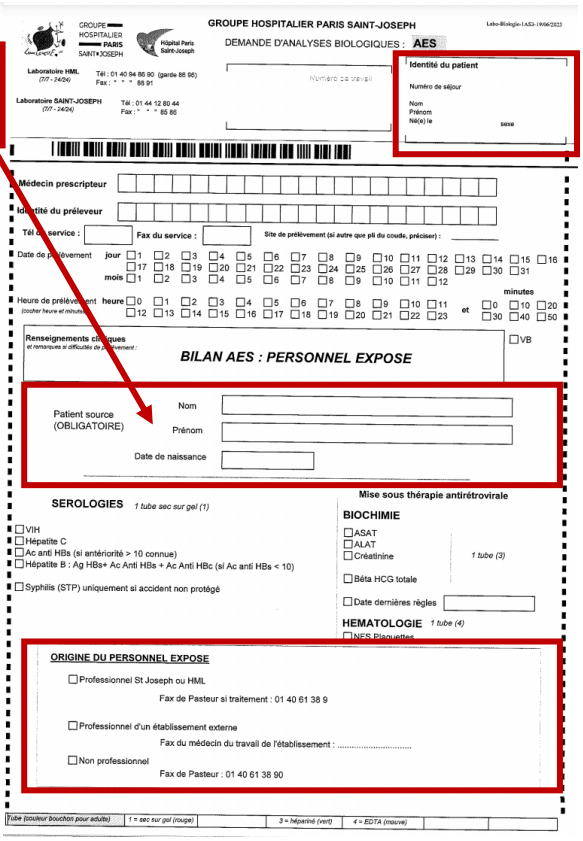
Seul le VIH est réalisé en urgence et communiqué au médecin en charge de l'AES

Sérologie 1 tube sec sur gel (1)
VIH,Hépatite B (AgHBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc), Hépatite C, Syphilis

si anti VIH positif connu ou fortement évocateur
si Anti VHC connu ou suspecté, DROGUE IV ou IMMUNODEPRIME
si VHB positif connu ou Ag HBs positif

VIH ARN quantitatif 2 tubes (4) de 4 ml
Hépatite C ARN quantitatif 2 tubes (4) de 4 ml
Hépatite B ADN quantitatif 2 tubes (4) de 4ml

Tube (couleur bouchon pour adulte) | 1 = sec sur gel (rouge) | 2 = citraté (bleu) | 3 = héparine (vert) | 4 = EDTA (mauve) | 5 = Citrate (noir) | 6 = Fluorure (gris)


GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

DEMANDE D'ANALYSES BIOLOGIQUES : AES

Identité du patient

Numéro de séjour

Nom

Prénom

Né(e) le

sexe

Médecin prescripteur

Identité du préleveur

Tél du service :

Fax du service :

Site de prélèvement (si autre que pli du coude, préciser) :

Date de prélèvement jour

mois

Heure de prélèvement heure

minutes

Renseignements cliniques

et remarques si difficultés de prélèvement :

BILAN AES : PERSONNEL EXPOSE

VB

Patient source (OBLIGATOIRE)

Nom

Prénom

Date de naissance

SEROLOGIES 1 tube sec sur gel (1)

VIH
Hépatite C
Ac anti HBs (si antériorité > 10 connue)
Hépatite B : Ag HBs+ Ac Anti HBs + Ac Anti HBc (si Ac anti HBs < 10)

Syphilis (STP) uniquement si accident non protégé

Mise sous thérapie antirétrovirale

BIOCHIMIE

ASAT
ALAT
Créatinine

1 tube (3)

Béta HCG totale

Date dernières règles

HEMATOLOGIE 1 tube (4)

NFS Plaquettes

ORIGINE DU PERSONNEL EXPOSE

Professionnel St Joseph ou HML

Fax de Pasteur si traitement : 01 40 61 38 9

Professionnel d'un établissement externe

Fax du médecin du travail de l'établissement : .....

Non professionnel

Fax de Pasteur : 01 40 61 38 90

Tube (couleur bouchon pour adulte) | 1 = sec sur gel (rouge) | 3 = héparine (vert) | 4 = EDTA (mauve)

MISE EN PLACE D'ATTELLE OU DE SYNDACTYLIE

A ECRIRE

6. ZONE 2

CYCLES DE TROPONINE ET ECG

A ECRIRE

PROTOCOLE DE POSE DE SONDE NASOGASTRIQUE (SNG)

Ce protocole a pour objet d'améliorer le confort du patient en prévenant la douleur induite lors de la pose d'une sonde nasogastrique par l'utilisation d'une anesthésie locale de contact.

Indication à la pose de sonde nasogastrique :

- Drainer le contenu de l'estomac (air, sécrétions, patient intubé ou en occlusion...).
- Préciser un diagnostic (recherche de BK, recherche d'une hémorragie digestive).
- Administrer un médicament.
- Pour tous les patients présentant une suspicion d'occlusion et nécessitant un scanner abdominopelvien.

Contre-indication à l'anesthésie locale :

- Muqueuse ORL infectée.
- Hypersensibilité aux anesthésiques locaux.
- Porphyries.
- Épilepsie non traitée ou non équilibrée sous traitement.

Matériel :

- Solution hydroalcoolique (SHA).
- Mouchoirs
- Gants non stériles à usage unique.
- Anesthésique local :
    - Lidocaïne 5% nébuliseur®
    - Xylocaïne visqueuse gel 2%®
- Sonde de Salem : sonde à double courant (diamètre (Ch) : 16, 18 ou 21).
- Compresses non stériles.
- Haricot + carré de soins.
- Lubrispray®
- Stéthoscope
- Seringue de 60mL à embout conique.
- Sparadrap
- Système mural d'aspiration digestive prêt à l'emploi
- Manomètre sur prise de vide (- 50mmHg maximum).

Pose de la sonde :

1) Informer le patient de la nécessité du soin et du but poursuivi (lavage, aspiration), expliquer son déroulement afin de s'assurer de sa participation, en particulier le geste de déglutition.

2) Installer le patient en position assise, tête inclinée vers l'avant (permet l'ouverture de l'œsophage) ; installer le carré de soin sur le thorax du patient ; lui demander de se moucher.
3) Lavage de mains avec SHA et pose de gants non stériles.
4) Anesthésie locale :
    a. Pulvériser la Lidocaïne 5% nébuliseur® au niveau des 2 narines, en progressant vers l'oropharynx et en demandant au patient d'avaler (5 pulvérisations par narine).
    b. Introduire dans la bouche l'équivalent d'1 cuillère à café (5ml) de Xylocaïne gel 2%®. Dire au patient de répartir avec la langue le produit dans la cavité buccale et d'avaler lentement sans absorber d'eau.
    c. Attendre 3 à 5 min.
5) Choisir le repère sur la sonde :
    a. 1er repère : distance entre l'oreille et le nez
    b. 2eme repère : ajouter au 1er repère, la distance entre le nez et le creux épigastrique
6) Lubrifier la sonde avec Lubrispray® avant d'introduire la sonde horizontalement dans 1 narine, respecter la courbure physiologique.
   Demander au patient de déglutir lors de la progression de la sonde pour faciliter le passage du carrefour pharyngé, puis progresser doucement jusqu'à l'estomac.
7) Vérifier le bon positionnement de la sonde :
    a. Aspirer 30mL d'air dans la seringue et adapter la seringue à la sonde
    b. Poser le stéthoscope en région épigastrique, injecter les 30mL d'air contenus dans la seringue.
    c. Écouter les borborygmes qui confirment la bonne position de la sonde.
    d. Fixer la sonde avec du sparadrap sur la narine puis sur la joue.
    e. Adapter la sonde en fonction de l'indication, au système d'aspiration et régler le manomètre.
    f. Possibilité de demander un contrôle par radiographie.
8) Attendre 2 heures avant toute ingestion après pose de sonde sous anesthésie locale.

Surveillance de la sonde :

- S'assurer de la présence d'un sifflement au niveau de la prise d'air de la sonde et de mouvement dans la sonde (en cas d'absence de bruit et de mouvement, la sonde est bouchée)
- Surveiller la quantité de liquide recueilli dans le collecteur (si sonde en aspiration)

Vérifier l'absence de nausées, vomissements

PROTOCOLE DE POSE DE SONDE URINAIRE CHEZ L'HOMME

Le sondage urinaire est défini par l'introduction d'une sonde stérile dans la vessie par l'urètre.

Références :

- *Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier*
- *Surveiller et prévenir les infections associées aux soins ; SF2H- septembre 2010.*
- *Prévention de l'infection urinaire nosocomiale, Recommandations pour la pose et la gestion d'une sonde vésicale Cclin sud-ouest 2003*
- *Conférence de consensus-association française d'urologie-Paris 2002*

Rappel :

La pose de sonde urinaire est réalisée par un IDE sur prescription médicale (Décret n°2004-802).

Conduite à tenir :

1- Définition – indication :

Le sondage urinaire est défini par l'introduction d'une sonde stérile dans la vessie par l'urètre. Ce protocole traite du sondage à demeure. Les indications et la durée du sondage urinaire doivent être limitées et reconsidérées chaque jour. Les méthodes alternatives au sondage à demeure (protections, étui pénien, sondage itératifs…) exposent à un moindre risque d'infection et doivent être préférées chaque fois que possible.

XYLOCAINE® 2% gel urétral est un gel non coloré, présenté en seringue préremplie de 10g (200 mg de chlorhydrate de lidocaïne). Xylocaïne® mise au contact de la muqueuse urétrale, exerce un effet anesthésique local en se fixant sur les terminaisons nerveuses situées dans la muqueuse et en bloquant de manière spécifique, totale et réversible la conduction nerveuse. Le maximum d'efficacité est obtenu à l'issue de 5 à 10 minutes d'application. La durée d'action se prolonge 30 min.

2- Contre-indications à l'utilisation de la Xylocaïne® 2% gel urétral :

- Hypersensibilité aux anesthésiques locaux à liaison amide (très rare) ou à l'un des excipients
- Porphyries récurrentes
- Épilepsie non contrôlée par un traitement
- Méat urétral inflammatoire ou infecté, afin d'éviter un passage sanguin trop important de l'anesthésique à travers une muqueuse éraillée par des tentatives infructueuses (contre-indication relative)

3- Matériel :

- Matériel pour le traitement hygiénique des mains par friction : PHA (produit hydro alcoolique)
- Matériel pour la toilette intime (savon liquide, gant de toilette à usage unique, serviette propre ou compresses sèches, bassin, protection de lit, gants non stériles)
- Produit pour la désinfection cutanéo-muqueuse : Dakin®.
- Matériel pour le sondage :
    - Set de sondage se composant de :
        - Champ stérile
        - Champ troué pré-fendu
        - Compresses stériles,
        - Ampoule d'eau stérile 20ml
        - Seringue de 20cc
        - 1 aiguille 18G
        - Gel lubrifiant
    - Une sonde urinaire stérile (prévoir une autre sonde si échec du sondage) + Une poche stérile
    - Xylocaïne® 2% gel urétral en seringue préremplie
    - 2 paires de gants stériles.

4- Méthode :

Informer le patient et l'installer confortablement sur un lit propre, protection à usage unique. En fonction des possibilités, il peut être conseillé de travailler à deux personnes.

- Toilette urogénitale :
    - Réaliser une friction hydroalcoolique ;
    - Mettre les gants non stériles pour réaliser la toilette intime avec du savon doux et un gant de toilette à usage unique ;
    - Décalotter le gland ;
    - Rincer à l'eau du réseau et sécher avec des compresses ou une serviette propre ;
    - Enlever les gants, réaliser une friction hydroalcoolique ;
    - Ouvrir le set de sondage ;
    - Déposer stérilement le matériel (poche, sonde) sur le set à sondage.
    - Ouvrir le blister du Xylocaïne 2% gel urétral® et le déposer stérilement sur le set de sondage
    - Verser du Dakin® sur les compresses stériles
    - Se désinfecter les mains et mettre des gants stériles.
    - Connecter la poche et la sonde sur le champ stérile (système clos)

- Désinfection du méat urinaire et injection de Xylocaïne® 2% gel urétral :

- Avec les compresses stériles de Dakin®, réaliser une antisepsie du méat en badigeonnant largement en allant du méat vers l'extérieur.
- Injecter lentement dans l'urètre le contenu de la seringue de Xylocaïne® 2% gel urétral sans forcer, par simple pression sur le piston.
- Jeter la seringue dans le sac DAOM.
- Laisser une compresse imbibée de Dakin® sous la verge.
- Enlever les gants. Se désinfecter les mains
- L'anesthésie est complète au bout de 5 à 10 minutes.

Il est donc indispensable de laisser au moins 5 minutes le gel en place avant d'introduire la sonde.

- Pose de la sonde :
  - A l'aide d'un gant non stérile, retirer la compresse laissée sur le méat.
  - Se désinfecter les mains ;
  - Mettre la 2ème paire de gants stériles.
  - Remplir la seringue d'eau stérile.
  - Tester le ballonnet ;
  - Lubrifier la sonde avec le lubrifiant fourni dans le set ;
  - Installer le champ troué stérile sur le patient ;
  - Appliquer à nouveau du Dakin® sur le méat ;
  - Tenir la verge décalottée verticalement.
  - Introduire la sonde lentement et progressivement, sans forcer.
  - Incliner la verge vers le bas, après avoir obtenu quelques gouttes d'urines en continuant la mise en place de la sonde.
  - Gonfler le ballonnet avec l'eau stérile (quantité maximum indiquée sur la sonde).
  - Recalotter la verge.
  - Éliminer le champ à usage unique dans le sac DAOM.
  - Fixer le collecteur en position déclive.
  - Tracer dans le dossier de soins (date, n° charrière posée, signature soignant).

5- Surveillance

- Hygiène des mains à chaque manipulation du dispositif
- Maintenir en position déclive le collecteur. Éviter tout contact du sac avec le sol
- Vérifier la perméabilité du système, l'absence d'obstruction, de coude, de fuites.
- Maintenir stérile donc clos le montage, ne pas déconnecter la sonde et le sac collecteur.
- Pour prélever, utiliser le site prévu (tube+ adaptateur vacutainer) après avoir désinfecté avec de l'alcool à 70 °.
- Toilette quotidienne au savon doux.

- Quotidiennement se questionner sur l'intérêt du sondage afin de retirer la sonde sur prescription dès qu'elle est inutile.

S'il est nécessaire de changer le collecteur, tout le système sonde et collecteur doit être remplacé par un nouveau système clos.

PROTOCOLE DE POSE DE SONDE URINAIRE CHEZ LA FEMME

Le sondage urinaire est défini par l'introduction d'une sonde stérile dans la vessie par l'urètre.

Références :

- *Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier*
- *Surveiller et prévenir les infections associées aux soins ; SF2H- septembre 2010.*
- *Prévention de l'infection urinaire nosocomiale, Recommandations pour la pose et la gestion d'une sonde vésicale Cclin sud-ouest 2003*
- *Conférence de consensus-association française d'urologie-Paris 2002*

Rappel :

La pose de sonde urinaire est réalisée par un IDE sur prescription médicale (Décret n°2004-802).

Conduite à tenir :

1- Définition – Indications

Le sondage urinaire est défini par l'introduction d'une sonde stérile dans la vessie par l'urètre. Ce protocole traite du sondage à demeure. Les indications et la durée du sondage urinaire doivent être limitées et reconsidérées chaque jour. Les méthodes alternatives au sondage à demeure (protections, étui pénien, sondage itératifs…) exposent à un moindre risque d'infection et doivent être préférées chaque fois que possible.

2- Matériel

- Matériel pour le traitement hygiénique des mains par friction : PHA (produit hydroalcoolique)
- Matériel pour la toilette intime (savon liquide, gant de toilette à usage unique, serviette propre ou compresses sèches, bassin, protection de lit, gants non stériles)
- Produits pour la désinfection cutanéo-muqueuse : Dakin®.
- Matériel pour le sondage :
    - Set à sondage se composant de :
        - Champ troué à usage unique,
        - Absorbex
        - Compresses stériles,
        - Ampoule d'eau stérile
        - Seringue de 20cc,
        - Lubrifiant
- Une sonde urinaire stérile (prévoir une autre sonde si échec du sondage) + Une poche stérile.

- 2 paires de gants stériles.

3- Méthode

Informer la patiente et l'installer confortablement sur un lit propre, protection à usage unique. Dans certains cas, la mise en place d'un bassin peut faciliter la pose de la sonde urinaire. En fonction des possibilités, il peut être conseillé de travailler à deux personnels :

- Toilette urogénitale :
  - Réaliser une friction hydroalcoolique.
  - Mettre les gants non stériles pour réaliser la toilette intime avec du savon doux et un gant de toilette à usage unique.
  - Rincer à l'eau du réseau et sécher avec des compresses ou une serviette propre.
  - Enlever les gants, réaliser une friction hydroalcoolique.
  - Ouvrir le set à sondage.
  - Déposer stérilement le matériel (poche, sonde) sur le set à sondage.
  - Verser du Dakin® sur des compresses stériles.
  - Se désinfecter les mains et mettre des gants stériles.
  - Connecter la poche et la sonde sur le champ stérile (système clos).

- Désinfection du méat urinaire :
  - Avec les compresses stériles de Dakin®, réaliser une antisepsie du méat en badigeonnant largement en allant du méat vers l'extérieur.
  - Laisser une compresse imbibée de Dakin® sur le méat
  - Enlever les gants. Se désinfecter les mains

- Pose de la sonde :
  - A l'aide d'un gant non stérile, retirer la compresse laissée sur le méat.
  - Se désinfecter les mains.
  - Mettre la 2eme paire de gants stériles.
  - Remplir la seringue d'eau stérile.
  - Tester le ballonnet.
  - Lubrifier la sonde avec le lubrifiant fourni dans le set.
  - Installer le champ troué stérile sur la patiente.
  - Repérer le méat en écartant les lèvres avec une compresse stérile de Dakin®.
  - Appliquer à nouveau du Dakin® sur le méat.
  - Introduire la sonde lentement et progressivement, sans forcer.
  - Après avoir obtenu quelques gouttes d'urines, gonfler le ballonnet avec l'eau stérile (quantité maximum indiquée sur la sonde).
  - Tirer doucement sur la sonde jusqu'à ce que le ballonnet gonflé bute sur le col vésical.
  - Éliminer le champ à usage unique dans le sac DAOM.
  - Fixer le collecteur en position déclive.

- Tracer dans le dossier de soins (date, n° charrière posée, signature soignant).

4- Surveillance

- Hygiène des mains à chaque manipulation du dispositif
- Maintenir en position déclive le collecteur. Éviter tout contact du sac avec le sol
- Vérifier la perméabilité du système, l'absence d'obstruction, de coude, de fuites.
- Maintenir stérile donc clos le montage, ne pas déconnecter la sonde et le sac collecteur.
- Pour prélever, utiliser le site prévu (tube+ adaptateur vacutainer) après avoir désinfecté avec de l'alcool à 70.
- Toilette quotidienne au savon doux.
- Quotidiennement se questionner sur l'intérêt du sondage afin de retirer la sonde sur prescription dès qu'elle est inutile.
- S'il est nécessaire de changer le collecteur, tout le système sonde et collecteur doit être remplacé par un nouveau système clos.

PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE D'UNE RAU EN CAS DE RAD

En cas d'incapacité complète ou partielle à uriner malgré une vessie pleine (à différencier de l'anurie).

Elle peut être simple ou la conséquence d'un caillotage post chirurgie urologique. Le bladder scan confirme la rétention à partie de 500mL d'urine dans la vessie.

Ne seront pas inclus dans le protocole :

- 1er sondage vésical chez l'homme.
- Sténose urétrale connue.
- Traumatisme de l'urètre.
- Prostatite aiguë (diagnostiquée ou en cours de traitement).
- Infections des voies urinaires hautes ou basses de la femme (diagnostiquée ou en cours de traitement).
- Post opératoire des voies urinaires et prostate dans les 30 jours.
- Bricker ou chirurgie reconstructrice des voies urinaires.

Conduite à tenir :

A l'IOA :

- Rechercher les signes de globe urinaire au bladder scan :
    - Dernière miction ?
    - Chirurgie prostatique récente ?
    - Hématurie ? Avec ou sans caillots ?
    - Douleur ? (Si oui, cf protocole douleur IOA).
- Prévenir MAO si chirurgie urologique récente pratiquée à Saint-Joseph.
- Patient à inscrire en zone 2 systématiquement.

Après installation en box, prévenir une IDE qui prendra en charge le patient avant qu'il soit vu par un médecin.

Mettre le dossier dans la bannette des « installés non vus ».

En zone :

→ Rétention simple :

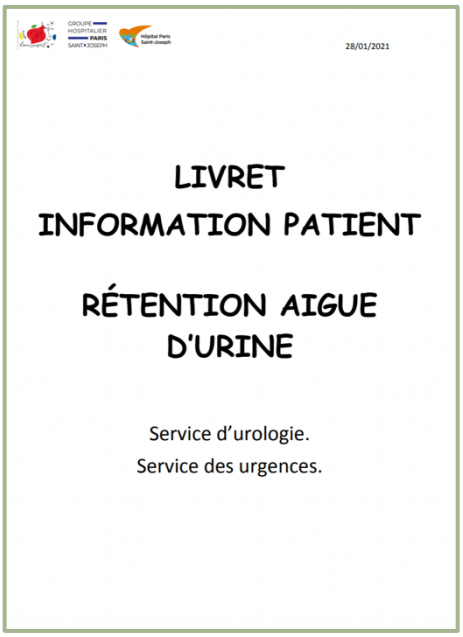
- Pose d'une sonde de Foley (clamper à partir de 500mL obtenus au moment de la pose, déclamper après 15 minutes).
- BU + ECBU systématiques.
- Faire la traçabilité dans DxCare (Menu > Pancarte > Surveillance > Diagramme de soins > Soins techniques)
- Prélèvement sanguin : NFS, IONO, TP/INR-TCA.

→ Rétention sur hématurie :

- Pose de sonde double courant et commencer le lavage vésical.
- Bilan entrée-sortie (voir fiche « bilan entrée/sortie lavage vésicaux »).
- BU + ECBU systématiques.
- Faire la traçabilité dans DxCare.
- Prélèvement sanguin : NFS, IONO, TP, TCA (+ INR si AVK), Groupes sanguin + RAI (au cas où déglobulisation).

Prise en charge médicale dès que possible.

A la fin de la prise en charge, remise en main propre du livret information au patient « rétention aiguë d'urine »



Fiche « bilan entrée/sortie lavage vésicaux » :

N° de la poche	Entrée	Sortie	Diurèse (entrée – sortie)	Traçabilité DxCare

Exemple :

N° de la poche	Entrée	Sortie	Diurèse (entrée – sortie)	Traçabilité DxCare
①	3000	3500	(3000-3500) = 500	X
②	3000	1900 1500	(3000-3400) = 400	X

③	3000			

FEUILLE DE TRANSMISSIONS ZONE 2

7. IOA

PROCEDURE DE CERTIFICAT DE NON-ADMISSION (CNA) ET REQUISITION

Prise en charge aux urgences d'une personne privée de liberté.

Rappel :

Article 7 (article R.4127-10 du CSP) : Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

1) Prise en charge d'une personne en dégrisement (CNA) :

La personne est conduite aux urgences par les forces de l'ordre.

1- Optimiser la prise en charge en installant rapidement la personne afin d'éviter l'attente pouvant induire une perturbation des conditions de travail aux urgences.
2- Après examen, un certificat médical est délivré aux forces de l'ordre stipulant que son état ne nécessite pas une hospitalisation.
3- On délivre alors aux forces de l'ordre un certificat de non-admission (CNA) uniquement si ivresse simple et critères de retour à domicile.
4- Dans tous les autres cas, admission en UHCD pour surveillance et en cas de besoin, protocole de sevrage si éthylique chronique.
5- Un certificat d'admission est remis aux forces de l'ordre.

2) Prise en charge d'une personne en garde à vue (GAV) :

Rappel :

L'examen d'une personne qui mise en garde à vue est un droit.

Il se fait par un médecin de l'UMJ sur réquisition avec pour mission de préciser si l'état de la santé de cette personne permet ou non le maintien dans un lieu de rétention, tel qu'un commissariat ou une gendarmerie.

Cependant la survenu d'une pathologie aigue dans sa cellule pendant la garde à vue, n'exige pas de réquisition.

Il est conduit à l'hôpital dans le cadre d'une urgence, pour des soins et non dans le cadre de sa procédure.

La personne en garde à vue est généralement amenée aux urgences par les pompiers suivit par l'équipe de police, ou parfois amenée par les policiers seuls. Les policiers se doivent de poursuivre la surveillance dans l'enceinte de l'établissement.

L'examen doit être pratiqué comme pour tous les autres patients :

1- A l'abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
2- Libre de toute entrave, sauf circonstances exceptionnelle, justifié dans la procédure.
3- Les forces de l'ordre restent toujours à proximité.
4- La prise en charge comporte un examen clinique et si nécessaire la réalisation d'examen complémentaire.
5- Prise en charge aussi du GAV selon ses antécédents et son traitement.
6- Hormis l'administration ponctuelle d'un médicament symptomatique ou le cas d'une pathologie aigue nécessitant une prise en charge immédiates, le médecin doit éviter autant que possible, d'instaurer à sa sortie un nouveau traitement non urgent.
7- Lorsque l'examen et le bilan aboutissent à une sortie, un compte rendu de la prise en charge est remis sous enveloppe aux forces de l'ordre.
8- Un traitement antalgique si besoin pour les 12h qui suivent, est remis dans une enveloppe à l'attention des forces de l'ordre afin qu'ils puissent le lui remettre.
9- Enfin, un certificat de non-admission est remis aux forces de l'ordre.
10- Si l'état du GAV nécessite une hospitalisation ou dans l'hypothèse où le GAV refuse son traitement et si ce refus compromet sa sécurité sanitaire à court terme, une hospitalisation doit être aussi envisagée.
11- Un certificat d'admission est remis aux forces de l'ordre (changer l'entête).

PROCEDURE D'UTILISATION DES PACKS REFRIGERANTS

Modalités d'utilisation des packs réfrigérants lors de traumatismes douloureux sans plaie.

→ Objectif :

Diminuer la douleur provoquée par un traumatisme récent.

Limiter l'œdème péri-lésionnel.

→ Indications :

Toute douleur à la suite d'un traumatisme récent, mono articulaire, distal (main, poignet, coude, genou, cheville, pied) sans plaie associée.

→ Contre-indications :

Plaie

→ Précautions d'emploi :

- ➔ Par rapport au patient
  - Ne pas appliquer au contact direct de la peau, mais avec une protection cutanée.
  - Surveillance cutanée régulière.
- ➔ Par rapport à l'environnement :
  - Désinfection après chaque utilisation
  - Placer au congélateur après chaque utilisation et attendre 2h avant la prochaine utilisation.

→ Effets indésirables :

- ➔ Risque de brulure thermique si placé au contact direct de la peau.
- ➔ Sensation d'engourdissement momentané de la zone réfrigérée.

→ Déroulement de l'application du pack réfrigérant (Physiopack®) :

1) Avant l'application :

a. Évaluation de la douleur par échelle d'évaluation (EN, EVS, Algoplus) par IDE.
b. Prescription selon protocole à l'IOA : l'IDE prescrit l'application du pack réfrigérant sur le logiciel du service dans le cadre de sa prise en charge à l'accueil en l'absence de lésion cutanée associée au traumatisme.
c. Préparation du matériel :
   - Placer le pack réfrigérant suffisamment refroidi dans un jersey de taille adaptée avant l'application sur la zone traumatisée douloureuse.
d. Préparation du patient :
   - Expliquer au patient les modalités d'administration du pack réfrigérant (pas de contact cutané direct).

- Expliquer au patient les bénéfices de l'antalgie par le froid.
- Expliquer le principe de l'autosurveillance cutanée.
- Installer le patient confortablement dans une position adaptée.

2) <u>Pendant l'application :</u>

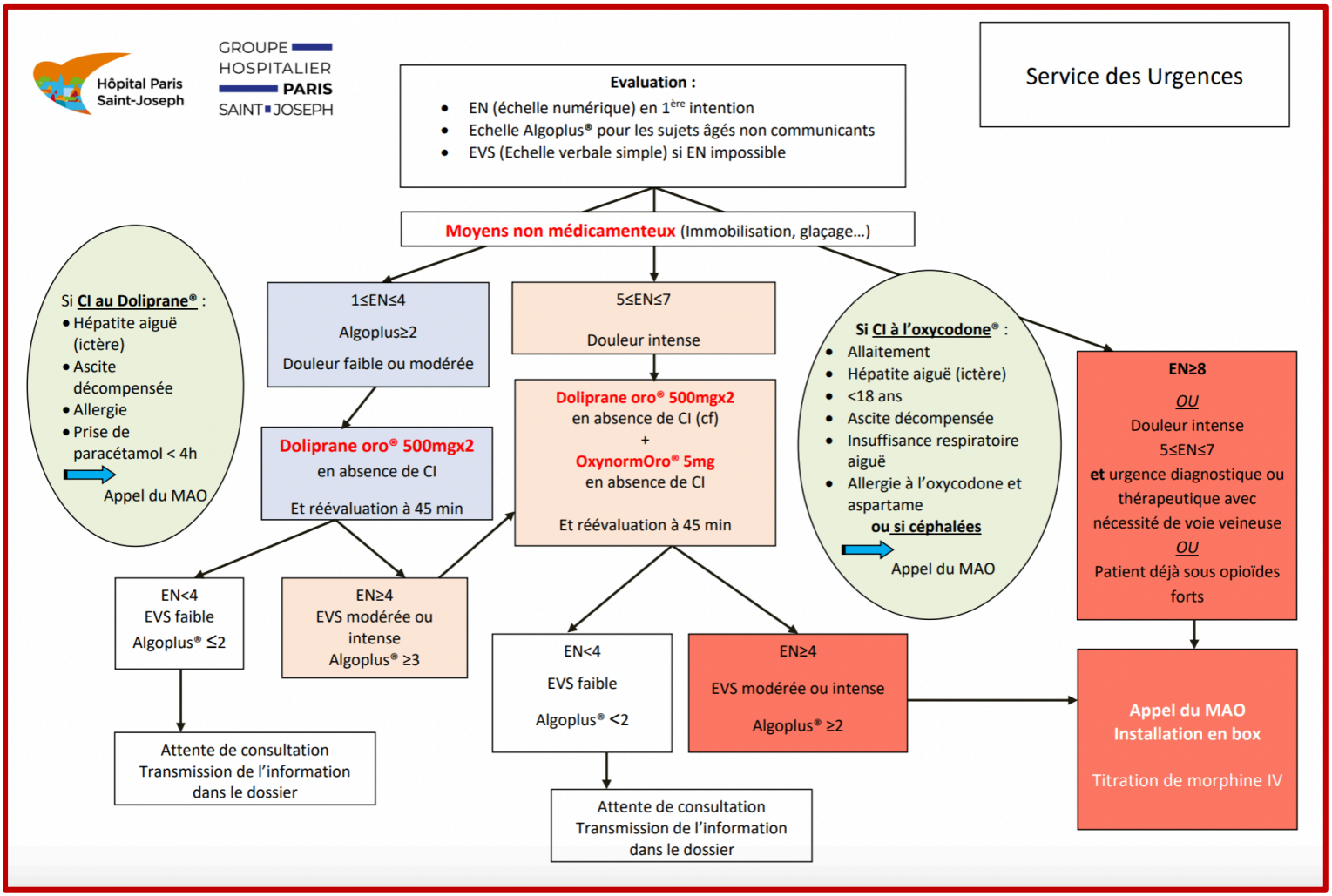
a. Application efficace pendant 20 à 30 minutes avec surveillance cutanée régulière par le patient.
b. Arrêter l'administration du produit dès que le pack n'est plus efficace c'est-à-dire au bout de 20 à 30 min.
c. Arrêter l'application dès l'apparition de douleur ou de sensation de brulure cutanée.
d. Arrêter l'application si apparition de lésion cutanée.

3) <u>Après l'application</u>

a. Surveillance du patient :
   - Surveillance de l'état cutanée du patient (absence de brûlure).
b. Transmissions :
   - Elles se font sur les documents de transmissions spécifiques :
     - Étiquette du patient.
     - Heure de pose
     - Secteur d'orientation du patient.

       Noter les effets secondaires éventuellement survenus.
c. Entretien du matériel :
   - Nettoyer le pack réfrigérant avec des lingettes Bactinyl®
   - Remettre le pack réfrigérant au congélateur en box d'accueil infirmier (IOA
   - Le pack réfrigérant sera réutilisable au bout de 2h.
d. Renouveler l'application après 2h si besoin.

SCHEMA DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR



AGRESSIONS SEXUELLES

→ Prise en charge IOA :

- ➔ Tri vert – prise en charge totale <1h
- ➔ Installation box MAO ou box 6
- ➔ Examen par un médecin senior - en journée MAO ou médecin zone 1

→ Prise en charge soignante :

- ➔ Ne pas laver ou laisser se laver le patient jusqu'à la consultation aux UMJ
- ➔ Préserver les habits portés lors de l'agression, manipuler avec des gants (conserver en sac vestiaire clos).
- ➔ Recueil d'urine à laisser au patient pour d'éventuels dosages de toxiques.

→ Prise en charge médicale :

- ➔ Examen somatique à la recherche de lésions traumatiques externes récentes ou gynécologiques nécessitant des soins urgents (plaies hémorragiques)
  - Si possible, prise de clichés des lésions à insérer dans le dossier
  - Pas d'examen gynécologique
- ➔ Chez la femme :
  - Prescription et délivrance si nécessaire d'une contraception orale post rapport, de type : Levonorgestrel (Norlevo®) dans les 72h ou Ulipristal acétate (Ellaone® 30) de 72h à 5j
- ➔ Bilan AES - pré-thérapeutique et patient exposé (cf. protocole)
  - Prescription et délivrance du traitement + feuille d'information
  - Délivrance d'un Certificat médical initial
- ➔ Inciter au dépôt de plainte, si acceptation :
  - Appel du commissariat du 14e : 0153741406 pour déclencher la prise en charge (la police organisera la prise en charge aux UMJ après audition)
  - Appel des UMJ Hôtel Dieu 0142348700 (facultatif en fonction du contexte, rôle de la police)

En cas de refus de dépôt de plainte, considérer que la victime peut changer d'avis dans les jours à venir et maintenir l'ensemble de la prise en charge (hors appel police) et en lui expliquant les formalités de dépôt de plainte.

→ Documents à remettre à la sortie :

- CMI
- Courrier pour l'UMJ / double du dossier médical
- Fiche d'information « agression sexuelle »
- Fiche d'information AES

→ Fiche d'information :

Conseils aux patients

Vous avez été victime d'une agression sexuelle.
Voici quelques informations importantes :

Vous avez bénéficié lors de votre séjour au sein de nos urgences d'un examen médical visant à constater les premières lésions.
Des prélèvements sanguins ont été réalisés, et si besoin un traitement a été mis en place. Une solution de contraception d'urgence vous a été proposée si nécessaire.

Dépôt de plainte

1) Le commissariat du XIVème arr. de Paris a enregistré votre plainte dans l'enceinte des urgences et s'occupe de votre prise en charge

Votre dépôt de plainte effectué, avec une réquisition, vous devrez vous rendre aux *Urgences Médico Judiciaires de l'Hôtel Dieu* (1 place Parvis Notre-Dame, 75004), afin d'effectuer les démarches médico-légales qui complèteront votre plainte.

2) Vous n'avez pas décidé de porter plainte ce jour, vous pouvez changer d'avis et dans ce cas, vous devrez vous rendre au commissariat qui vous convient dès que vous le souhaitez.

Urgences Médico Judiciaires (UMJ)

Vous allez bénéficier dans ce service d'examens médicaux qui viseront à identifier l'ADN de votre agresseur, à constater les sévices physiques, et à vous prodiguer les soins nécessaires.

- Le médecin effectuera dans un premier temps un examen clinique général, guidé par les informations que vous pourrez lui fournir (cavité buccale, examen gynécologique, etc…) à la recherche de lésions causées par l'agression.

- Des prélèvements de marqueurs ADN pourront être effectués lors de cet examen dans un but d'identification de l'agresseur (poils pubiens, sperme, urine, sang, salive etc.).

Une prise en charge psychologique vous sera également proposée.

Voici quelques conseils afin de « conserver » les marqueurs ADN de votre agresseur

1) Ne pas se laver après l'agression jusqu'à la consultation aux UMJ

2) Préserver les habits que vous portiez lors de l'agression (vous pouvez les conserver dans le sac qui vous a été remis).

3) Gardez, de manière la plus précoce, vos urines (doute d'intoxication au GHB) dans le pot à urines qui vous a été donné.

4) **Ne restez pas seul(e), faites-vous accompagner d'un proche pour effectuer vos démarches.**

Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires

PRISE EN CHARGE DE FEMME VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES

→ Introduction :

Le rôle des urgences est important dans la prise en charge des personnes victimes de violences et en particulier des femmes victimes de violences conjugales.

Peu de femmes lorsqu'elles consultent aux urgences osent parler des violences qu'elles subissent, tout comme très peu de femmes osent porter plainte (moins de 20 %) Et lorsqu'elles le font, on se doit de savoir les prendre en charge de façon pluridisciplinaire.

→ L'accueil par l'IAO :

Si une patiente consulte pour des violences conjugales, on la laisse parler afin de savoir qu'elle est sa demande et de quoi elle a besoin.

- Il s'agit d'une victime, elle consulte pour des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
- Montrer de l'empathie
- Écouter
- Prévenir le MAO, le psychiatre et l'assistante sociale.

Prise en charge à l'IAO identique que pour les autres patients

Puis installation directe dans un box pour prise en charge médicale psychologique et sociale

→ L'accueil par l'urgentiste :

1. **L'écoute :**
   - ➔ Montrer de l'empathie et noter la demande de la victime et ce dont elle a besoin.

2. **L'examen :**
   - ➔ Noter les doléances.
   - ➔ Prise en charge identique à toute victime : bilan lésionnel, imagerie si besoin, les soins et le traitement.
   - ➔ Faire une prise de photos datées et identifiées, avec l'accord de la victime et en conservant un double des photographies.
   - ➔ Si la victime signale une appréhension à son retour à domicile, la prise en charge par l'assistante sociale permettra de lui trouver un hébergement provisoire.
   - ➔ Si c'est la nuit, on hospitalise la patiente aux lits d'urgences.

3. **Le certificat médical :**
   - ➔ La consultation et l'examen clinique sont un préalable indispensable à la rédaction du certificat.
   - ➔ Ce certificat est essentiel car il est une preuve qui pourra être utile si la patiente souhaite porter plainte et s'il y a une procédure judiciaire, même si la plainte est tardive.

- Reporter les dires de la victime sur le mode déclaratif, au présent, entre guillemets ; « Mme X…dit avoir été victime de.... " "la victime déclare…" "selon les dires de la victime … ».
- Noter les doléances de façon exhaustive
- **Décrire avec précision les lésions constatées**
- **Préciser s'il y a aussi des violences psychologiques.**

4. <u>Prise en charge pluridisciplinaire :</u>

➔ Orientation vers les autres professionnelles
➔ Orientation vers le psychiatre ou l'IDE psy.
➔ Orientation vers l'assistante sociale

<u>Si prise en charge la nuit ou si absence de l'assistante sociale :</u>

En cas de situation jugée grave :

➔ Conseiller de déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.
➔ Informer du droit de quitter le domicile conjugal avec les enfants, en le signalant à la police (main courante) ou à la gendarmerie.
➔ Informer du droit de saisir en urgence le juge aux affaires familiales, même sans dépôt de plainte, pour demander une ordonnance de protection.
➔ Décider d'une hospitalisation des enfants pour protection et évaluation.
➔ Si besoin faire un signalement avec l'accord de la victime, pour porter à la connaissance du procureur de la république les sévices ou privation constatés, sans nommer l'auteur des faits ; mais cet accord n'est pas nécessaire si la victime est un mineur, une personne vulnérable ou un <u>majeur en danger immédiat</u> et placé dans l'incapacité de se protéger en raison de la contrainte morale résultats de l'emprise exercée par l'auteur des violences (article 226-14 du code pénal)

« La loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales étend les possibilités de signalement des violences conjugales par les médecins, dans un cadre bien précis »

**Modèle de signalement au procureur de la république sont disponible sur le site internet du conseil national de l'ordre des médecins.*

DELIVRANCE D'ANTALGIQUE PAR L'IOA

→ Évaluation de la douleur :

- EN (échelle numérique) en 1ère intention
- Échelle Algoplus pour les sujets âgés non communicants
- EVS (Échelle verbale simple) si EN impossible

→ Douleur faible ou modérée, EN entre 1 et Algoplus ≥ 3 :

- Moyens non médicamenteux (immobilisation, positionnement, glaçage, réassurance, orthèse…)
- Proposition de délivrance de **Paracétamol Oro® 500mgx2 ou gélules**
- Sauf si contre-indications : appel du médecin régulateur
  - Hépatite aiguë (ictère)
  - Ascite décompensée
  - Allergie
- Sauf si prise de paracétamol<4h : appel du régulateur
- Réévaluation à 45 minutes
  - Patient soulagé (EN<4, EVS faible, Algoplus ≤2) : Transmission de l'information dans le dossier et attente de la consultation
  - Patient non soulagé (EN≥4, EVS modérée ou intense, Algoplus ≥3) : proposer
    - **Oxynormoro® 5mg** sauf contre-indications (appel du médecin régulateur) :
    - Hépatite aiguë (ictère)
    - Ascite décompensée
    - Insuffisance respiratoire aiguë
    - Bradypnée (FR < 12/min)
    - Somnolence
    - Grossesse ou allaitement (contre-indication relative)
    - Allergie à l'oxycodone et aspartame

→ Douleur intermédiaire, EN entre 5 et 7 :

- Moyens non médicamenteux (immobilisation, glaçage…)
- Proposition de délivrance d'**Oxynormoro® 5mg**, sauf contre-indications (appel du médecin régulateur) :
  - Hépatite aiguë (ictère)
  - < 18 ans
  - Ascite décompensée
  - Insuffisance respiratoire aiguë
  - Bradypnée (FR < 12/min)
  - Somnolence
  - Grossesse ou allaitement (pas une contre-indication absolue)
  - Allergie à l'oxycodone et aspartame

+ **Doliprane Oro® 500mgx2**, sauf si contre-indications (appel du médecin régulateur) :

- Hépatite aiguë (ictère)
- Ascite décompensée
- Allergie
- Prise de paracétamol < 4h

➔ Réévaluation de la douleur à 45 minutes

- Patient soulagé (EN<4, EVS faible, Algoplus ≤2) : Transmission de l'information dans le dossier et attente de la consultation
- Patient non soulagé (EN≥4, EVS modérée ou intense, Algoplus ≥3) : appel du médecin régulateur et installation en box.

→ EN ≥ 8 OU Douleur intense 5 ≤ EN ≥ 7 et urgences diagnostique ou thérapeutique avec nécessité de voie veineuse OU Patient déjà sous opioïdes forts :

Appel du médecin régulateur et installation en box pour titration de morphine intraveineuse 2mg toutes les 5 minutes en IV si poids <60kg, 3mg si>60kg (surveillance scopée + conscience et FR)

Surveillance = minimum 3minutes après le dernier bolus de morphine.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CONSULTATION ET/OU HOSPITALISATION D'UN DETENU (A METTRE)

PATIENT PORTEUR D'ARME OU DE DROGUE

Un patient ne peut pas garder une arme en sa possession ou détenir de la drogue pendant son séjour à l'hôpital ou lors d'une consultation.

La détention de drogue ou d'arme constitue un délit.

Cependant, aucun texte de loi ne prévoit la levée du secret professionnel en cas de détention illicite de stupéfiant ou d'arme, l'identité du patient ne doit donc pas être divulguée (sauf sur réquisition judiciaire).

→ Patient détenteur d'arme :

1. Le personnel soignant prévient immédiatement son encadrement et le médecin en charge du patient.
2. Le cadre alerte le responsable de la sécurité (7714) et le service des relations patients (3585 du lundi au vendredi, de 9h à 18h) ou l'administrateur de garde.
3. Le responsable de la sécurité récupère l'arme auprès du patient, en se munissant de gants et en la manipulant le moins possible puis la dépose au coffre central du PC sécurité en présence d'une personne des relations patients ou de l'administrateur de garde.
4. Le responsable de la sécurité et le responsable des relations patients ou l'administrateur de garde préviennent le commissariat du 14ème arrondissement **sans donner l'identité du patient** qui viendra confisquer l'arme (le patient pourra réclamer l'arme au commissariat).

Cas particuliers : le patient détenteur d'une arme est un membre des forces de l'ordre (militaire, gendarme, police).

- ➔ Si le patient est **conscient** : il doit prévenir sa hiérarchie qui viendra récupérer son arme de service.
- ➔ Si le patient est **inconscient** : Le responsable de la sécurité récupère l'arme auprès du patient, en se munissant de gants et en la manipulant le moins possible puis la dépose au coffre central du PC sécurité en présence d'une personne des relations patients ou de l'administrateur de garde. L'arme sera rendue au patient lors de sa sortie. Si ce n'est pas possible, le responsable de la sécurité contacte le commissariat du 14ème arrondissement pour venir confisquer l'arme.

→ Patient détenteur de drogue :

1. Le personnel soignant prévient immédiatement son encadrement et le médecin en charge du patient.
2. Le cadre alerte le responsable de la sécurité (7714) et le service des relations patients (3585 du lundi au vendredi, de 9h à 18h) ou l'administrateur de garde.
3. Le responsable de la sécurité récupère la drogue auprès du patient, en se munissant de gants et décide conjointement avec le responsable des relations patients ou l'administrateur de garde :

- ➔ Si **la quantité récupérée est à usage personnel** : procéder à la destruction de la drogue.
- ➔ Si la quantité récupérée est supérieure à un usage personnel : le responsable de la sécurité dépose la drogue au coffre central du PC sécurité en présence d'une personne des relations patients ou de l'administrateur de garde et contacte le commissariat du 14ème arrondissement **sans donner l'identité du patient** pour venir confisquer la drogue.

Dans tous les cas une FEI doit être rédigée.

PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : PRESCRIPTION DE RADIOLOGIE

→ Conduite à tenir :

Dans le cadre de la coopération professionnelle aux urgences, des actes diagnostiques et thérapeutiques sont délégués aux infirmières par les médecins.

Cas 1 :

- ➔ Prise en charge de la douleur à l'accueil des Urgences.
- ➔ Les IOA sont formés à la prise en charge de la douleur dès l'accueil des urgences. Une prescription d'antalgique fait suite à une évaluation de la douleur. Les infirmiers sont formés à l'évaluation de la douleur et à l'administration d'antalgiques selon un protocole défini.

Cas 2 :

- ➔ Prescription anticipée de radio dès l'accueil
- ➔ Les IOA prescrivent des radios pour les patients dès l'accueil.
- ➔ Elles reçoivent une formation spécifique en interne et peuvent prescrire des radios dans le cadre de monotraumatisme des membres.

→ Prescription de radiographies anticipée par l'IDE :

Faisabilité :

- ➔ Patient coopérant, inspection facile, valide
- ➔ Traumatisme distal mono-articulaire

Exclusion :

- ➔ Douleur non traumatique
- ➔ Patient non valide
- ➔ Traumatismes multiples (> ou = 2 localisations)
- ➔ Traumatisme proximal (rachis, face)
- ➔ Critères de gravité (instabilité hémodynamique)
- ➔ Femmes enceintes

Prescription :

- ➔ Localisation+ COTE+ Incidences minimum (F/P)
- ➔ Épaule : F/P, + ou - Clavicule (facultatif)
- ➔ Coude : F/P, Tête radiale
- ➔ Avant-bras : F/P
- ➔ Poignet : F/P, + ou - incidence scaphoïde
- ➔ Main/Doigts : F/P (préciser doigt, phalange P1P2P3)
- ➔ Hanche : F/P, toujours bassin de face (facultatif)

- ➔ Genou : F/P
- ➔ Jambe : F/P
- ➔ Cheville : F/P,+ ou - Pied F/P
- ➔ Pied/Orteil : Pied F/P

La mise en application implique des droits de prescription spécifiques dans Dxcare. Un profil spécifique au service des urgences a été mis en place.

Seules les infirmières formées au protocole peuvent l'exécuter.

➔ Dans DxCare :

METTRE PHOTO ET MARCHE A SUIVRE

PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : INTOCICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)

→ Pathologie :

Intoxication par inhalation de CO. Le CO (gaz inodore incolore insipide volatile et explosif) et produit lors d'une combustion incomplète (appareil de chauffage mal réglé ou inadapté, ventilation insuffisante, fumée d'incendie).

Les signes non spécifiques sont fonction de la dose : céphalée (100ppm), fatigue et nausée (200ppm), vomissements et syncopes (500ppm), coma (1000ppm). L'intoxication est à évoquer dans son caractère collectif, récidivant et/ou fonction de l'environnement.

L'intoxication associe une hypoxie une toxicité cellulaire.
Le CO à une affinité 200 fois supérieure à l'O^2 sur l'hémoglobine.
La saturation est faussement rassurante (les deux gaz sont fixés).

→ Critères de gravité :

- Perte de connaissance depuis l'intoxication
- Troubles de la conscience (somnolence, confusion, désorientation)
- Femme enceinte (CO ayant une affinité majeure pour l'HB fœtale)
- Signes de choc

  - Si signe de gravité, et après avis régulateur, installation en SAUV.

En fonction de la clinique et du mode d'intoxication virgule l'oxygénothérapie hyperbare peut être recommandée (contacter le sentir hyperbare de l'hôpital de Garches 01.47.10.77.82).
En cas d'intoxication aux fumées d'incendie, intoxication cyanée type doit être évoqué, et prise en charge conjointement (Cyanokit®).

→ Conduite à tenir, intoxication CO simple = aucun critère de gravité

IOA :

- Oriente le patient vers la zone 1 (zone 2 si pathologie associée)
- Prévient l'IDE concernée
- Demande si le patient est fumeur ou non (modification du taux d'HbCO de base)

IDE Zone :

- Installation en position assise
- Mise en place oxygénothérapie haute concentration MHC 8-10L d'O2
- Dosage de CO veineux
- Réalisation ECG à faire signer par médecin
- Évaluation par le médecin de zone dès que possible.

PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : RETENTION AIGUE D'URINE

→ Pathologie :

Incapacité complète ou partielle à uriner malgré une vessie pleine (A différencier de l'anurie).

Elle peut être simple ou la conséquence d'un caillotage post chirurgie urologique.

Le bladder scan confirme la rétention à partir de 500 ml d'urine dans la vessie.

→ Ne seront pas inclus dans le protocole :

- 1er sondage vésical chez l'homme
- Sténose urétrale connue
- Traumatisme de l'urètre
- Prostatite aiguë (diagnostiquée ou en cours de traitement)
- Infection des voies aériennes côte ou baisse de la femme (diagnostiquée ou en cours de traitement)
- Post-opératoire des voies urinaires prostate dans les 30 jours
- Bricker ou chirurgie reconstructrice des voies urinaires

→ Conduite à tenir :

IOA :

➔ Rechercher signe de globe urinaire au bladder scan :
  - Dernière miction ?
  - Chirurgie prostatique récente ?
  - Hématurie ? Avec ou sans caillots ?
  - Douleur ? Si oui protocole douleur

➔ Prévenir MAO si chirurgie urologique récente pratiquée à St-Jo

➔ Patients et inscrits en zone 2 systématiquement

Après installation en box, prévenir IDE qui prendra en charge le patient avant qu'il soit vu par un médecin.

Mettre le dossier dans la bannette des « installés non vus »

IDE Zone. :

Rétention simple :

➔ Pose de Foley (Clamper à partie de 500mL obtenus au moment de la pose, et déclamper après 15min).

➔ BU + ECBU systématique

- ➔ Faire la traçabilité dans DxCare (Pancarte > Surveillances > Diagramme de soins > Soins techniques)
- ➔ Prélèvement sanguin : NFS, IONO, TP/INR - TCA

Rétention sur hématurie :

- ➔ Pose de sonde double courant et commencer le lavage vésical
- ➔ Bilan entrée – sortie
- ➔ BU + ECBU systématique
- ➔ Faire la traçabilité dans DxCare (Pancarte > Surveillances > Diagramme de soins > Soins techniques)
- ➔ Prélèvement sanguin : NFS, IONO, TP/TCA (+INR si AVK) + Groupe & RAI (au cas où déglobulisation).

Prise en charge médicale dès que possible

PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : PRISE EN CHARGE DES PLAIES

Port de gants de soins obligatoire (pas de gants stériles)

→ Quelles plaies ?

- Plaie d'allure suturable, sans saignement important, de moins de 12h au niveau :
- Du cuir chevelu
- Du visage SAUF les paupières
- Des membres supérieurs et inférieurs

→ Conduite à tenir :

➔ Si **plaie non souillée** : rincer abondamment à **l'eau du robinet ou eau en flacon** ou encore Sérum Physiologique.

➔ Si **plaie souillée (gravier, terre, etc.)** : lavage **eau et savon** et enlever les corps étrangers superficiels.

1. Essuyer en douceur la plaie avec la compresse mouillée d'eau.
   Pas d'indication à une désinfection d'emblée.
2. Pulvériser **Xylocaïne Spray® 5%** après le nettoyage (ou à défaut Xylocaïne gel).
3. Répartir les pulvérisations entre la plaie et la compresse.
   Ne pas dépasser les 10 pulvérisations (pas de risque allergique, mais dose limite).
4. Le délai d'action en application sur les muqueuses et en infiltration est de 5 à 10 min et sa durée d'action est de 20 à 30 min.
5. Maintenir une compresse humide imbibée de **Xylocaïne Spray® 5%** jusqu'à la suture.

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D'UNE ALERTE THROMBOLYSE

Alerte thrombolyse : tous signes neurologiques (présent ou résolutif) < 6h

➔ Appeler MAO pour déclencher l'alerte thrombolyse
- AVC de moins de 6 h
- AVC du réveil ou moins de 04h30
- AIT de moins de 04h30

➔ **Signes cliniques :**
- Déficit moteur
- Déficit sensitif
- Trouble du langage
- Trouble de la vision
- Examen des pupilles
- Vertiges.

➔ **A l'IOA :**
- Décubitus 0° degré strict
- Prise de tension aux 2 bras
- Fréquence cardiaque
- Saturation plus fréquence respiratoire
- Glycémie (HGT)
- Température
- Déshabillage +/-
- Glasgow ou vigilance

ECG + prélèvement sanguin + voie veineuse périphérique réalisé en SAUV.

PROTOCOLE DE REALISATION D'UN ELECTROCARDIOGRAMME A L'IAO

Un électrocardiogramme sera réalisé par l'équipe d'accueil devant les motifs suivants :

- ➔ Douleur thoracique/épigastriques
- ➔ Douleur dorsale et/ou épaule gauche SANS traumatisme
- ➔ Tous les malaises
- ➔ Anomalie du bilan sanguin :
  - Hyper/hypokaliémie
  - Troponine augmentée
- ➔ Fréquence cardiaque supérieure à 120 ou inférieure à 45
- ➔ Anémie inférieure à 7 g d'hémoglobine avec antécédent cardiovasculaire (IDM)
- ➔ IMV
- ➔ Traumatisme thoracique (nécessitant d'être allongée).

Sauf pour les patients installés directement en SAUV pour un autre motif, dans ce cas l'équipe de la SAUV le réalisera

Mes livrets d'accueil

Tome 1 - La fondation et l'hôpital

Tome 2 – Le service des urgences

Tome 3 – Mon intégration

Tome 4 – Mon plan de formation et le développement de mes compétences

Tome 5 – Mes outils du quotidien

Tome 6 – Les logiciels Ressources Humaines

Tome 7 – Les logiciels métiers

Tome 8 – Les procédures et protocoles du service et de l'institution

Tome 9 – Situation sanitaire exceptionnelle